

Examen fédéral 2022 jour 1

Question 1

Votre patient de 65 ans vient à votre cabinet 10 jours après une opération pour une prothèse de hanche pour la réfection et contrôle du pansement. A l'anamnèse, il mentionne le fait qu'il trouve son mollet un peu tendu et modérément douloureux. Que faites-vous ?

- A. le convoquer dans une semaine pour un nouveau contrôle
- B. rechercher une thrombose veineuse profonde**
- C. appliquer de la glace
- D. faire une radiographie du mollet
- E. prescrire des bas de contention

Les symptômes tels que la douleur et la tension dans le mollet chez un patient postopératoire peuvent être des signes de TVP. Les patients ayant subi une chirurgie orthopédique, comme une prothèse de hanche, présentent un risque accru de développer une TVP en raison de l'immobilisation prolongée et des autres facteurs de risque liés à la chirurgie.

Approche diagnostique recommandée :

1. Évaluation de la probabilité pré-test (PTP) en utilisant les critères de Wells.

2. Dosage des D-dimères :

- Si la probabilité pré-test est faible, un test des D-dimères peut être utile pour exclure une TVP.
- Si la probabilité pré-test est intermédiaire ou élevée, ou si les D-dimères sont positifs, une échographie veineuse est indiquée.

3. Échographie veineuse (US) :

- Si les D-dimères sont positifs ou si la probabilité pré-test est intermédiaire ou élevée, une échographie veineuse doit être effectuée.
- L'échographie veineuse est le test de référence pour confirmer la présence de TVP.

Réponse : B

Question 2

Il y a un an, vous diagnostiquez chez votre patiente de 53 ans une hypertension artérielle de stade II et prescrivez pour cela une bithérapie par antagoniste des récepteurs à l'angiotensine et un diurétique. De plus, elle prend depuis 8 semaines un AINS (naproxène 250mg) pour des douleurs articulaires importantes, avec bon effet. Elle vous consulte aujourd'hui car elle ne comprend pas pourquoi sa tension artérielle est actuellement à 150/90 mmHg. Quelle est la raison la plus probable ?

Les AINS, y compris le naproxène, peuvent causer une augmentation de la pression artérielle en raison de leur effet sur la fonction rénale. Ils inhibent la production de prostaglandines, qui jouent un rôle clé dans le maintien du flux sanguin par la vasodilatation des artérioles afférentes. Cette inhibition peut entraîner une hypoperfusion rénale et une réduction du débit de filtration glomérulaire, ce qui conduit à :

- Rétention d'eau et de sodium.
- Activation du système rénine-angiotensine-aldostérone.

Ces effets contribuent à l'augmentation de la pression artérielle.

- A. régime riche en sel
- B. traitement par AINS**
- C. mauvaise adhérence thérapeutique
- D. douleurs articulaires

Réponse : B, C (+1) (HTA plutôt sur IRC qu'IRA non)??

Question 3

Une patiente de 23 ans se présente aux urgences suite à une entorse de sa cheville droite en inversion. Depuis, elle n'a pas pu poser le pied par terre à cause de la douleur. À l'examen clinique, la malléole externe est tuméfiée et la palpation de la cheville est diffusément douloureuse. La flexion et l'extension de cheville ne peuvent pas être réalisées à cause de la douleur. La radio ne montre rien. Que faire ?

- A. AINS, pas d'attelle ni de canne
- B. Attelle Aircast, AINS, charge selon douleurs avec béquilles**
- C. Plâtre, AINS, pas de charge pendant 6 semaines
- D. Chirurgie pour stabilisation du ligament collatéral externe
- E. Chirurgie pour ostéosynthèse de la malléole externe

1. Traitement initial :

- Appliquer le principe POLICE (Protection, Optimal Loading, Ice, Compression, Elevation).
- Considérer l'utilisation des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) pour réduire la douleur et l'inflammation.

2. Support fonctionnel :

- Pour les entorses légères à modérées : fournir un support fonctionnel (par exemple, une attelle de cheville) pendant 4 à 6 semaines.
- Pour les entorses sévères : immobiliser la cheville.
 - Une immobilisation de ≤ 10 jours est recommandée.
 - Pour une entorse de grade II : utiliser une attelle ou une botte de marche pour le membre inférieur.
 - Pour une entorse de grade III : envisager un plâtre court pour la jambe.

3. Référence à la chirurgie orthopédique :

- Si les symptômes ne se résolvent pas avec une gestion conservatrice.
- En cas d'entorse latérale sévère de grade III.
- En cas de rupture du ligament médial (ligament deltoïdien).
- En cas d'entorse syndesmote de haut grade.
- En cas d'instabilité chronique de la cheville.

Réponse: B

Question 4

Une réfugiée érythréenne de 30 ans consulte pour asthénie, perte d'appétit et perte de poids (10 kg) depuis 8 semaines. La patiente est cachectique et présente une adénopathie

symétrique en susclaviculaire, cervical et occipital. Labo: 100 Hb, 130 Thrombocytes, 2.6 Lc,

Créat normale, 65 ALT, CRP 60

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Mononucléose infectieuse
- B. Lymphome de Hodgkin
- C. VIH
- D. Tuberculose
- E. Paludisme

Les symptômes de la patiente (asthénie, perte d'appétit, perte de poids significative, adénopathie symétrique susclaviculaire, cervicale et occipitale, anémie, thrombocytose et CRP élevée) suggèrent fortement une maladie systémique grave. Les diagnostics les plus probables incluent :

- **Lymphome de Hodgkin** : caractérisé par une adénopathie indolore, souvent sus-claviculaire et cervicale, accompagnée de symptômes systémiques tels que la perte de poids, la fatigue et la fièvre.
- **Tuberculose** : peut se présenter avec une lymphadénopathie généralisée, perte de poids, et une élévation de la CRP.
- **VIH** : peut également se présenter avec une lymphadénopathie généralisée et des symptômes systémiques, mais l'anémie et les autres symptômes hématologiques sont plus caractéristiques du lymphome.
- **Mononucléose infectieuse** : présente souvent une adénopathie cervicale mais est généralement accompagnée de pharyngite et est moins probable chez une patiente de 30 ans sans autres symptômes spécifiques.
- **Paludisme** : bien que possible, il est moins probable sans historique de voyage récent en zone endémique ou de symptômes typiques tels que la fièvre périodique.

Parmi ces diagnostics, le lymphome de Hodgkin est le plus probable en raison de la présentation classique des adénopathies localisées et des symptômes B (asthénie, perte d'appétit, perte de poids).

Réponse: C ?, A (adp symetrique et prevalence 0.5% HIV en Erytrée (pas Afrique subsaharienne)) B ? (+2)

Question 7

Une patiente de 27 ans se présente à votre consultation en raison de douleurs apparues au niveau des deux poignets ainsi qu'au niveau du genou gauche. De plus, elle vous rapporte avoir des brûlures mictionnelles depuis 2 semaines environ.

A l'examen clinique vous objectiviez des articulations tuméfiées, chaudes et douloureuses à la palpation. En outre, vous observez une conjonctivite bilatérale, que la patiente dit avoir remarqué depuis quelques jours également.

Quel démarche vous permet de poser le diagnostic?

- A. Dosage des anticorps antinucléaires (ANA)
- B. Frottis urétral
- C. Dosage de l'acide urique dans le sérum
- D. Ponction articulaire
- E. Radiographies des articulations douloureuses

Caractéristiques Cliniques

- Période de latence : 1 à 4 semaines après l'infection initiale.
- Symptômes musculosquelettiques :
 - Oligoarthritis (parfois polyarthrite) : début aigu, asymétrique, souvent migratoire, principalement dans les membres inférieurs.
 - Sacroïllite.
 - Enthésite.
 - Dactylite.
- Symptômes extra-articulaires :
 - Conjonctivite, iritis, épiclérite ou kératite.
 - Manifestations dermatologiques : balanite circinée (lésions cutanées du gland), kératoderme blennorrhagique (hyperkératinisation des paumes et des plantes).
 - Urétrite.
 - Ulcères buccaux.
 - Manifestations cardiaques : régurgitation aortique, blocs auriculo-ventriculaires, péricardite.
- Symptômes de l'infection antérieure : diarrhée, symptômes du tractus urogénital (dysurie, douleur pelvienne, prostatite).

Basé sur les caractéristiques cliniques, l'histoire du patient et l'examen physique.

- Soutenu par des tests de laboratoire ou des examens d'imagerie, bien qu'il n'existe pas de tests spécifiques de confirmation pour l'arthrite réactive.

Traitement

- Phase aiguë : traitement principalement symptomatique avec des AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens).

- Identifier et traiter les infections sous-jacentes.

- Pour les cas sévères ou chroniques : corticostéroïdes systémiques ou médicaments antirhumatismaux modificateurs de la maladie (DMARDs).

Pronostic

- L'arthrite réactive se résout généralement spontanément en 6 à 12 mois.
- Une petite proportion de patients peut développer une arthrite sévère ou chronique.

L'arthrite réactive, autrefois connue sous le nom de syndrome de Reiter, est une affection auto-immune post-infectieuse appartenant au groupe des spondyloarthropathies séronégatives. Elle survient généralement après une infection bactérienne du tractus gastro-intestinal ou urogénital.

Étiologie

- Infections gastro-intestinales : Shigella, Yersinia, Salmonella, Campylobacter.
- Infections urogénitales : Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum.
- Rarement : Bartonella henselae.

Épidémiologie

- Prédominance chez les jeunes adultes, surtout les hommes.
- Association avec l'antigène HLA-B27.
- Les patients infectés par le VIH ont un risque accru de développer une arthrite réactive.

Un homme de 62 ans se présente aux urgences de l'hôpital cantonal tard le soir après s'être cogné la cuisse droite contre une table lorsqu'il bougeait des meubles chez lui dans la journée. Depuis il a des fortes douleurs au niveau de la cuisse droite et vous observez une tuméfaction importante. La pression de la loge musculaire est mesurée à 65 mmHg (norme <5) et une échographie avec le résultat ci-dessous est réalisée. En regardant le dossier du patient vous apprenez que le patient est sous thérapie par Marcoumar pour une FA permanente. Vous mesurez l'INR qui est à 4.1.

Quelle est la prochaine chose à faire en priorité?

Le syndrome des loges aigu est causé par une ischémie tissulaire due à une augmentation de la pression à l'intérieur d'un compartiment fascial. Il s'agit d'une urgence chirurgicale caractérisée par une douleur et un gonflement progressifs rapides d'un membre, souvent déclenchés par une blessure traumatique.

Caractéristiques cliniques

- Douleur intense et progressive dans une extrémité, souvent disproportionnée par rapport à la blessure initiale.
- Signes de mauvaise perfusion tissulaire : pâleur, absence de pouls.
- Signes de dommages nerveux : paresthésie (fourmillements), paralysie.

Diagnostic

- Le diagnostic est basé sur des signes cliniques et confirmé par la mesure des pressions intra-compartimentales. Les valeurs suivantes sont utilisées pour diagnostiquer un syndrome des loges aigu :
 - Pression intra-compartimentale ≥ 30 mm Hg
 - Delta pression (ΔP) ≤ 30 mm Hg ($\Delta P = \text{pression diastolique} - \text{pression intra-compartimentale}$)

Traitement

Le traitement nécessite une fasciotomie dans les 4 à 6 heures pour prévenir la nécrose tissulaire irréversible.

Autres types de syndrome des loges

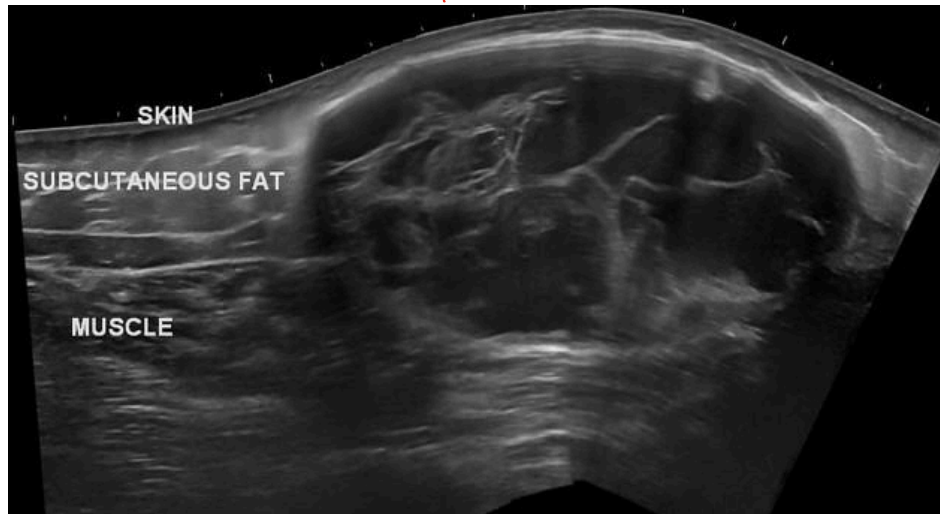
- Syndrome des loges d'effort chronique : caractérisé par des douleurs récurrentes des membres pendant l'exercice ou l'effort.
- Syndrome des loges abdominal : causé par une pression accrue dans la cavité abdominale, souvent chez les patients gravement malades ou blessés.

Arthrite réactive

Syndrome des loges

≥ 30 mmHg
Sy. des loges confirmé

Hématome



(je ne retrouve pas d'image très similaire mais il y a avait une collection liquidienne légèrement cloisonné visible au niveau du quadriceps)

- A. Administration de fibrinogène
- B. Angiographie et embolisation artériel
- C. Surélévation de la jambe et application de glace
- D. **Drainage de l'hématome**
- E. Radiographie de la jambe

1. Syndrome des loges aigu (SLA) :

- La pression intra-compartimentale élevée (65 mmHg) est bien au-delà de la norme (< 5 mmHg), confirmant le diagnostic de SLA.
- Les symptômes et signes de SLA nécessitent une intervention rapide pour éviter des dommages irréversibles.

2. INR élevé (4.1) :

- L'INR élevé suggère une anticoagulation excessive, augmentant le risque de saignement.
- La correction de l'INR peut être nécessaire, mais ne doit pas retarder l'intervention chirurgicale.

Interventions supplémentaires

- Administration de vitamine K et/ou de plasma frais congelé : Pour corriger l'INR avant la chirurgie si possible.
- Surveillance continue : Maintenir une surveillance étroite de l'état hémodynamique et des signes cliniques.

Mesures à éviter

- **Élévation de la jambe et application de glace** : Peut aggraver l'ischémie en réduisant le flux sanguin.
- **Angiographie et embolisation artérielle** : Non indiqué en première intention dans le contexte de SLA confirmé.
- **Radiographie de la jambe** : Non prioritaire par rapport à la gestion chirurgicale urgente.

Supp. à l'angine à streptocoque (SGA)

Question 9

Un garçon de 5 ans arrive avec son père au cabinet de pédiatrie. Depuis la veille, il tousse et a le rhume, mais pas de fièvre. Le père vous dit qu'à la maternelle, plusieurs enfants ont une angine à streptocoques et il aimerait qu'on fasse le test pour son fils. Le garçon est en bon état général, il n'a pas d'adénopathies et il a des amygdales rouges et enflées mais sans dépôts ni points blancs. L'auscultation pulmonaire est normale. Quelle est votre approche?

- A. Vous faites le test pour le streptocoque
- B. Vous envoyez le patient chez l'ORL
- C. Vous faites une prise de sang
- D. Vous entamez une antibiothérapie
- E. **Vous calmez le père et vous lui dites qu'un test au streptocoque n'est pas indiqué pour le moment**

Critères	Points
Âge	
- 3-14 ans	+1
- 15-44 ans	0
- > 44 ans	-1
Exsudat ou gonflement des amygdales	+1
Adénopathies cervicales antérieures sensibles ou enflées	+1
Température > 38°C	+1
Absence de toux	+1

Réponse: E

Epidémiolo.

Question 10

Une étude est faite sur le dépistage précoce de l'hypertension artérielle. Pour le groupe A, le seuil de détection de l'hypertension diastolique est fixé à 95 mmHg, pour le groupe B à 110 mmHg. Que peut-on dire sur la sensibilité et la spécificité?

Lorsque le seuil de détection de l'hypertension diastolique est fixé à un niveau plus bas (95 mmHg) dans le groupe A par rapport à un niveau plus élevé (110 mmHg) dans le groupe B, les effets sur la sensibilité et la spécificité sont les suivants :

1. **Sensibilité** : La sensibilité est la capacité d'un test à identifier correctement ceux qui ont la maladie (vrais positifs). Un seuil plus bas (95 mmHg) détectera davantage de personnes avec une hypertension diastolique, y compris certains qui pourraient être faussement positifs. Ainsi, la sensibilité sera meilleure dans le groupe A.

2. **Spécificité** : La spécificité est la capacité d'un test à identifier correctement ceux qui n'ont pas la maladie (vrais négatifs). Un seuil plus élevé (110 mmHg) identifiera moins de personnes comme ayant une hypertension diastolique, réduisant ainsi le nombre de faux positifs. Par conséquent, la spécificité sera meilleure dans le groupe B.

- A. La sensibilité et la spécificité sont meilleures dans le groupe A
- B. La sensibilité et la spécificité sont meilleures dans le groupe B
- C. La spécificité est la même dans les deux groupes, la sensibilité est meilleure dans le groupe A
- D. La spécificité est la même dans les deux groupes, la sensibilité est meilleure dans le groupe B
- E. La sensibilité est meilleure dans le groupe A, la spécificité est meilleure dans le groupe B

Réponse: E

Question 17

(Question d'ancrage) Un homme de 42 ans se présente à votre cabinet avec une conjonctivite bilatérale, des arthralgies, et rash maculo-érythémateux. Vous suspectez une rougeole, raison pour laquelle vous prélevez du sang afin d'effectuer une sérologie IgM. Laquelle des propositions suivantes est correcte?

- A. Pas de déclaration obligatoire
- B. Déclaration obligatoire en cas de suspicion (avant le résultat des sérologies) par le médecin dans les 2h
- C. Déclaration obligatoire en cas de suspicion (avant le résultat des sérologies) par le médecin dans les 24h
- D. Déclaration obligatoire par le médecin une fois le résultats des sérologies positives
- E. Déclaration obligatoire par le laboratoire une fois le résultats des sérologies positives

La déclaration de la rougeole est obligatoire dès la suspicion (avant le résultat des sérologies) par le médecin dans les 24 heures.

Déclarations de maladies et d'infection

Office fédéral de la santé publique
Guide de la déclaration obligatoire

45. Rougeole

Virus de la rougeole

	Médecin	Laboratoire
Critères de déclaration	I. Suspicion clinique reposant sur la triade : 1. fièvre 2. exanthème maculopapuleux 3. toux, rhinite ou conjonctivite ou II. en l'absence de signes cliniques spécifiques ou en cas de découverte fortuite, au plus tard lors de l'obtention du résultat positif d'analyses de laboratoire Dans certaines situations, le service du médecin cantonal peut inviter le médecin à faire un prélèvement et à l'envoyer, à des fins de PCR et de génotypage, au Centre de référence.	Résultat positif obtenu par : I. culture ou II. analyse de séquences (p. ex. PCR, séquençage, NGS) ou III. mise en évidence d'anticorps (IgM, augmentation du titre $\geq 4 \times$ ou séroconversion) ou IV. mise en évidence de l'antigène Ne pas déclarer les évaluations du statut immunitaire Résultat négatif obtenu par : I. analyse de séquences (p. ex. PCR, séquençage, NGS) Tout prélèvement pour lequel la PCR fournit un résultat positif doit être envoyé à fin de génotypage au Centre de référence désigné par l'OFSP.
Délai de déclaration	24 heures	24 heures
Destinataire	Médecin cantonal	Médecin cantonal et OFSP
Formulaire de déclaration	www.bag.admin.ch/infreporting	www.bag.admin.ch/infreporting
Données sur la personne	Nom complet	Nom complet
Envoi des échantillons	Laboratoire habituel	Centre national de référence pour la rougeole et la rubéole (CNR/RB), Genève

Réponse: C (+1) D, E

Une femme de 64 ans, connue pour un tabagisme à 30 UPA et alcoolique à 3 verres de vodka par jour depuis des années, autrement sans antécédents médicaux particuliers, se présente pour une lésion de 7mm au niveau du triangle rétro-malléolaire gauche ne guérissant pas et saignant par moments depuis quelques semaines. A l'examen de la bouche, vous notez une dentition éparse et une hygiène de bouche précaire. Laquelle des propositions suivantes de suite de prise en charge est correcte?

Suspicion de la malignité
Analyse histo. pour écarter un carcinome épidermoïde

Une lésion buccale persistante et saignante doit être suspectée d'être maligne, surtout avec des facteurs de risque tels que le tabagisme et la consommation d'alcool. Une analyse histologique est essentielle pour diagnostiquer ou exclure un carcinome épidermoïde ou une autre forme de cancer buccal.

- A. L'envoyer chez le dentiste pour remplacer les dents manquantes et effectuer un traitement d'hygiène de bouche générale
 - Argument contre : Bien que l'hygiène buccale et le remplacement des dents manquantes soient importants, cette approche ne traite pas directement la lésion persistante et saignante de 7 mm. Une telle lésion, surtout chez une patiente avec des facteurs de risque comme le tabagisme et l'alcoolisme, nécessite une évaluation plus approfondie pour exclure une malignité.
- B. Prescrire un traitement antibiotique pendant 14 jours et contrôle clinique pour suivi de l'évolution
 - Argument contre : Les antibiotiques sont utilisés pour traiter les infections bactériennes, mais une lésion buccale persistante et saignante sans signes clairs d'infection ne justifie pas cette approche. De plus, cela retarderait le diagnostic d'une possible malignité.

- C. Suspectant une gingivite, vous prescrivez des AINS et la revoyez en contrôle clinique dans 3 jours
- Argument contre : La gingivite se présente généralement avec des gencives enflammées et saignantes, mais la description de la lésion dans le triangle rétro-molaire, qui est persistante et saignante, est plus suggestive d'une affection sérieuse. Les AINS peuvent réduire l'inflammation et la douleur, mais ne traiteront pas la cause sous-jacente de la lésion.
- D. Excision de la lésion en vue d'une analyse histologique
- Argument pour : Cette approche est appropriée car elle permet une évaluation diagnostique complète de la lésion. Chez une patiente avec des facteurs de risque élevés de cancer (tabagisme et alcoolisme), une analyse histologique est essentielle pour diagnostiquer ou exclure une malignité, telle qu'un carcinome épidermoïde.
- E. L'envoyer chez le dentiste car vous suspectez une infection paradentaire
- Argument contre : Une infection paradentaire (périodontite) peut causer des douleurs et des saignements, mais une lésion persistante de cette nature nécessite une évaluation plus approfondie. En envoyant uniquement la patiente chez le dentiste pour cette suspicion, on risque de manquer un diagnostic de cancer.

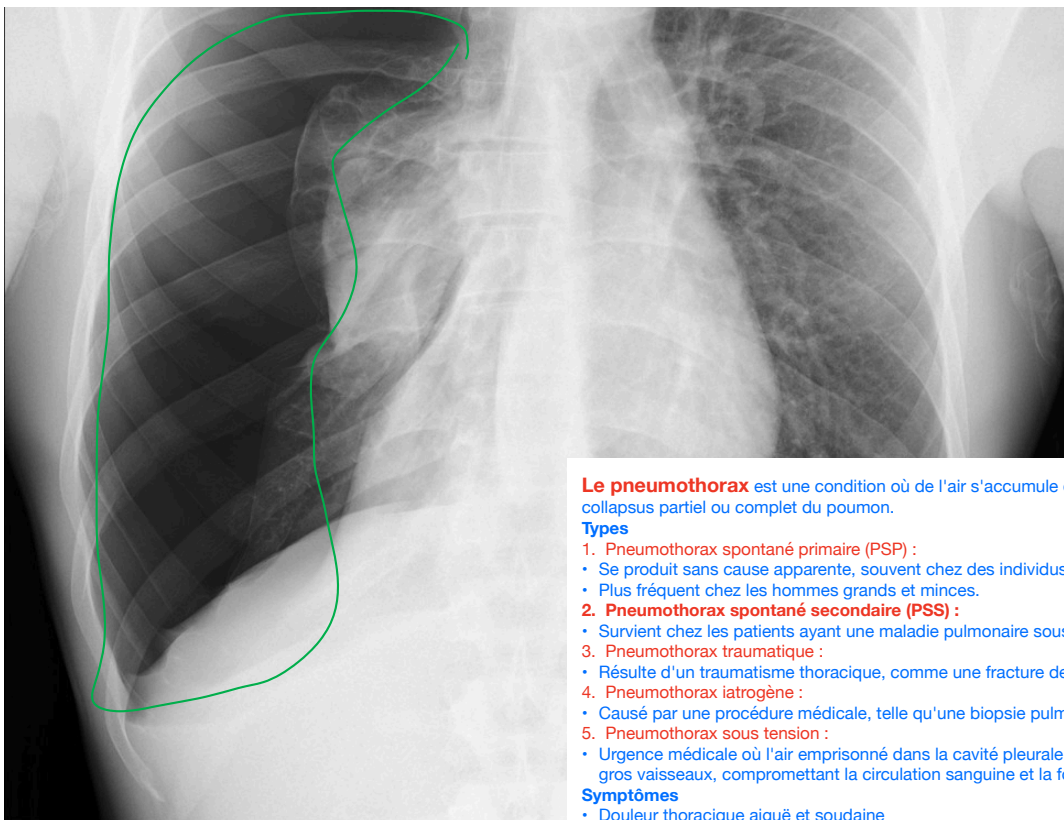
- A. L'envoyer chez le dentiste pour remplacer les dents manquantes et effectuer un traitement d'hygiène de bouche générale
- B. Prescrire un traitement antibiotique pendant 14j et contrôle clinique pour suivi de l'évolution
- C. Suspectant une gingivite, vous prescrivez des AINS et la revoyez en contrôle clinique dans 3j
- D. **Excision de la lésion en vue d'une analyse histologique**
- E. L'envoyer chez le dentiste car vous suspecter une infection paradentaire

Réponse: D

Question 19

Patient de 57 ans, hospitalisé pour une **pneumonie**. L'infirmière vient vous dire que le patient ne va pas bien. Le labo montre des leuco à 12 et une CRP à 36.

Vous demandez une radio de thorax qui est la suivante:



Le pneumothorax est une condition où de l'air s'accumule dans l'espace pleural, entraînant un collapsus partiel ou complet du poumon.

Types

1. Pneumothorax spontané primaire (PSP) :

- Se produit sans cause apparente, souvent chez des individus jeunes et en bonne santé.
- Plus fréquent chez les hommes grands et minces.

2. Pneumothorax spontané secondaire (PSS) :

- Survient chez les patients ayant une maladie pulmonaire sous-jacente (ex. : BPCO, fibrose kystique).

3. Pneumothorax traumatique :

- Résulte d'un traumatisme thoracique, comme une fracture de côte ou une plaie pénétrante.

4. Pneumothorax iatrogène :

- Causé par une procédure médicale, telle qu'une biopsie pulmonaire ou une ventilation mécanique.

5. Pneumothorax sous tension :

- Urgence médicale où l'air emprisonné dans la cavité pleurale exerce une pression sur le cœur et les gros vaisseaux, compromettant la circulation sanguine et la fonction respiratoire.

Symptômes

- Douleur thoracique aiguë et soudaine
- Dyspnée (difficulté à respirer)
- Diminution des bruits respiratoires du côté affecté
- Cyanose (dans les cas sévères)

Diagnostic

1. Examen clinique :

- Diminution ou absence de bruits respiratoires à l'auscultation
- Tympanisme à la percussion du thorax

2. Imagerie :

- Radiographie thoracique : montre une ligne de plèvre séparée de la paroi thoracique et l'absence de marquages pulmonaires périphériques.
- CT scan thoracique : plus sensible et peut détecter de plus petits pneumothorax.

Traitement

1. Observation :

- Pour les pneumothorax petits et asymptomatiques, surtout chez les patients stables.

2. Oxygénothérapie :

- Peut aider à résorber l'air plus rapidement dans les pneumothorax petits.

3. Aspiration à l'aiguille :

- Pour les pneumothorax plus grands ou symptomatiques.

4. Drainage thoracique (thoracostomie) :

- Insertion d'un tube thoracique pour évacuer l'air chez les patients présentant des pneumothorax plus importants ou des pneumothorax sous tension.

5. Chirurgie :

- Indiquée en cas de récides ou de pneumothorax persistants.
- Techniques incluent la pleurodèse (adhérence des deux couches pleurales) ou l'excision des bulles pulmonaires.

Pronostic

- Les pneumothorax primaires spontanés peuvent récidiver dans environ 30% des cas.
- Les pneumothorax secondaires sont associés à un risque plus élevé de complications et de mortalité en raison des conditions pulmonaires sous-jacentes.

Prévention

- Éviter les activités à risque élevé chez les individus prédisposés (ex. : plongée sous-marine, vol en avion sans cabine pressurisée).
- Surveillance et gestion adéquate des maladies pulmonaires chroniques pour réduire le risque de pneumothorax secondaire.

Quel est votre diagnostic ?

- A) Pneumonie secondaire
- B) Embolie pulmonaire

Pneumothorax spontané II

- C) Insuffisance cardiaque gauche
- D) **Pneumothorax**
- E) Tumeur pulmonaire

Réponse: D

Question 20 (question revenant souvent = ancrage)

Patient de 59 ans, présente une **tuméfaction** pré-auriculaire d'environ 2 cm de diamètre, bords mal délimités. **Liquide purulent** sort à la pression du canal excréteur parotidien. Dx le plus probable ?

- A) Abscess dentaire
- B) Furoncle auriculaire
- C) **Sialadénite bactérienne**
- D) Tumeur
- E) Obstruction du canal excréteur parotidien

- Symptômes : Gonflement douloureux unilatéral, érythème de la glande salivaire, écoulement purulent du canal excréteur.
- Facteurs de risque : Mauvaise hygiène buccale, déshydratation, obstruction (comme les sialolithes), diabète, insuffisance rénale.
- Traitement : Gestion symptomatique (sialogogues, AINS), antibiothérapie (amoxicilline/acide clavulanique, clindamycine), drainage chirurgical si abcès.

La **sialadénite** est une inflammation aiguë ou chronique des glandes salivaires, souvent causée par une infection bactérienne ou virale.

Types de sialadénites

Sialadénite suppurative aiguë

- Cause : Infection bactérienne (souvent par *Staphylococcus aureus*, parfois par streptocoques viridans, *Haemophilus influenzae* ou polymicrobienne).
- Localisation : Principalement la glande parotide.
- Facteurs de risque : Obstruction (sialolithiasis), mauvaise hygiène buccale, déshydratation, médicaments anticholinergiques, diabète, hypothyroïdie, insuffisance rénale.
- Symptômes : Apparition aiguë, gonflement unilatéral douloureux et érythème de la glande salivaire, écoulement purulent du canal excréteur, symptômes systémiques (fièvre, frissons).
- Diagnostic : Diagnostic clinique, culture de l'écoulement purulent, imagerie (échographie, CT) en cas de complications ou suspicion de sialolithiasis.
- Traitement : Gestion symptomatique (sialogogues, AINS), antibiothérapie (amoxicilline/acide clavulanique, clindamycine), chirurgie (incision et drainage d'un abcès, extraction de pierres salivaires).

Sialadénite chronique

- Cause : Épisodes récurrents de douleur et inflammation des glandes salivaires causés par stase salivaire, troubles auto-immuns (syndrome de Sjögren), néoplasmes, infections bactériennes.
- Symptômes : Épisodes récurrents de douleur et gonflement, symptômes de la cause sous-jacente.
- Diagnostic : Basé sur la cause sous-jacente suspectée (diagnostics pour syndrome de Sjögren).
- Traitement : Gestion symptomatique des troubles des glandes salivaires, traitement de la cause sous-jacente.

Complications

- Abscess (parapharyngé, intraglandulaire)
- Angine de Ludwig
- Paralysie du nerf facial

Réponse: C

Question 21 (question revenant souvent = ancrage)

Un travailleur se plaint suite à un **traumatisme** de douleur au niveau de l'**articulation inter-phalangienne distale de l'index**. L'examen est normal hormis un **hématome sous unguéal** de l'index gauche que faire ?

- A. Enlever l'ongle évacuer l'hématome replacer l'ongle
- B. **Trépanation de l'ongle pour évacuer l'hématome**
- C. Retrait de l'ongle et pansement occlusif
- D. Surveillance

Hématome sous-unguéal :

Définition

- Accumulation de sang sous la plaque de l'ongle, souvent suite à un traumatisme écrasant de la phalange distale.

Symptômes

- Douleur intense, décoloration de l'ongle.

Traitement

- Décompression des hématomes couvrant plus de 50% du lit de l'ongle.
- Anesthésie digitale pour la gestion de la douleur.
- Créer 2 à 3 trous dans la plaque de l'ongle avec une unité d'électrocautérisation ou une aiguille de calibre 18.
- La vidange peut être difficile après 48 heures en raison de la formation de caillots.

Réponse B

Question 22

Une femme est amenée par son amie pour une plaie au niveau de la cuisse, il n'a pas de saignement actif et les structures profondes ne sont pas atteintes. Au niveau des bras plusieurs marques de plaies cicatrisées anciennes. La femme explique qu'elle est angoissée car sa thérapeute habituelle ne peut pas la voir. Elle est dans une nouvelle relation depuis quelques semaines et a souvent des disputes durant lesquelles elle dit **se sentir obligée de se frapper la tête ou de se blesser**. Diagnostic le plus probable?

- A. Personnalité dépendante
- B. (Manque de confiance en soi)
- C. **Trouble de la personnalité émotionnellement labile** = *Borderline*
- D. Trouble de la personnalité histrionique
- E. trouble de la personnalité schizoïde

Réponse C (?), A ? l'**auto-mutilation** et la **peur de l'abandon** fait plutôt pensé au **borderline**

Question 28

Sialadénite

*Psy
Tr. personnalité
Borderline*

Tamsulosine
EII

(Question d'ancrage) Un homme de 72 ans suivi par des spécialistes pour une polyarthrite rhumatoïde et une hyperplasie bénigne de la prostate, se présente pour des vertiges et des épisodes d'hypotension orthostatique. Lequel des médicaments ci-dessous peut contribuer à la symptomatologie du patient ?

- A. Finastéride
- B. Méthotrexate
- C. Tamsulosine
- D. Omeprazole
- E. Beta bloquant

= α -bloquant "OSINE"

Réponse : C

Question 29

Une femme de 53 ans consulte pour asthénie, sudations nocturnes et.... L'examen clinique est dans la norme. Sa seule plainte est une difficulté à mastiquer. Le bilan biologique retrouve uniquement une anémie normocytaire normochrome.

Quelle est la suite pour poser le diagnostic?

- A. Un CT du thorax jusqu'au bassin
- B. Une électrophorèse des protéines
- C. Des transaminases, une créatinine, une VS et une CRP
- D. Une gastroscopie et colonoscopie
- E. Une radiographie de l'articulation temporaire mandibulaire des deux côtés

Réponse : C ?

Question 30

Homme de 60 ans connu pour un diabète, une fibrillation auriculaire et de l'hypertension. Il présente depuis quelque temps une intolérance à la chaleur, une perte de poids et une fatigue. Il prend de l'amiodarone pour sa FA, de la metformine pour son diabète ainsi que de l'hydrochlorothiazide, lisinopril et du vérapamil pour son HTA. À l'examen clinique, on met en évidence une hyperréflexie bilatérale, un oedème aux membres inférieurs et un trémor. Au bilan sanguin, la TSH est effondrée tandis que T3 et T4 sont nettement supérieurs à la norme. Parmi sa liste de traitements habituels, lequel des médicaments peut être à l'origine de sa pathologie ?

- A. Amiodarone
- B. Metformine
- C. Hydrochlorothiazide
- D. Lisinopril
- E. Verapamil

- L'amiodarone est un médicament connu pour provoquer des dysfonctionnements thyroïdiens, y compris l'hyperthyroïdie (thyrotoxicose) et l'hypothyroïdie.
- Dans le cas clinique, le patient présente des signes cliniques (intolérance à la chaleur, perte de poids, fatigue, hyperréflexie, œdème, tremblement) et biologiques (TSH effondrée, T3 et T4 élevées) caractéristiques de l'hyperthyroïdie.
- L'amiodarone contient une quantité élevée d'iode (environ 37%) et peut provoquer une thyrotoxicose de type I (augmentation de la synthèse et de la libération des hormones thyroïdiennes) ou de type II (destruction des cellules folliculaires thyroïdiennes et libération des hormones préformées).

Horton ?
MM ?

Hyperthyroïdie
médicaments

Réponse : A

Question 31:

Une femme de 65 ans est retrouvée morte **pendue** dans son appartement. La corde est attachée à la poignée de la porte, noeud typique, sillon derrière l'oreille, pétéchies conjonctivales. Dans ses antécédents médicaux, on retrouve un infarctus du myocarde récent et pose de stents coronariens. Quelle est la cause la plus probable du décès ?

- A. Infarctus du myocarde
- B. Embolie pulmonaire
- C. **Anoxie** cérébrale
- D. Occlusion du larynx

Anoxie cérébrale : La description du cas indique qu'elle a été retrouvée pendue avec des signes typiques d'asphyxie mécanique :

- Corde attachée à la poignée de la porte
- Sillon derrière l'oreille
- Pétéchies conjonctivales

Ces signes sont caractéristiques d'une **suspension par strangulation**, conduisant à une **anoxie cérébrale due à une interruption de l'apport sanguin au cerveau**, ce qui est compatible avec une mort par pendaison.

Bien que les antécédents médicaux de la patiente incluent un infarctus du myocarde récent et la pose de stents coronariens, les éléments fournis dans le cas clinique (signes de pendaison) pointent clairement vers une cause de décès par anoxie cérébrale plutôt qu'un infarctus ou une autre cause cardiaque.

Réponse: C

Infarctus du myocarde : Il n'y a pas de signes directs dans le cas clinique indiquant que l'infarctus est la cause immédiate du décès. Les signes de pendaison sont plus probants.

Embolie pulmonaire : Aucune donnée clinique ne soutient cette hypothèse dans la description donnée.

Occlusion du larynx : Bien que cela puisse provoquer l'anoxie, la description clinique pointe plus spécifiquement vers une anoxie cérébrale due à la pendaison.

Question 32

(Question d'ancrage) Femme G1P0 à **41 3/7** consulte pour des contractions utérines et perte de liquide. A l'examen, on constate un col mi mou, centré, à un doigt, une hauteur utérine à 33cm (plus sûre) de la symphyse pubienne. La tête de l'enfant est bien appuyé sur le col, présentation céphalique. Le **liquide est méconial**. La mère est afébrile. Le CTG montre un rythme cardiaque foetal stable à 145bpm. Quelle est votre attitude:

- A. **provocation**
- B. césarienne
- C. hospitaliser et attendre 48h
- D. antibiothérapie

A. Provocation : Cette option est recommandée car le **liquide amniotique méconial** indique un **risque potentiel de syndrome d'aspiration méconiale**. Induire le travail permet de minimiser ce risque et de surveiller de près le fœtus pendant le processus d'accouchement. De plus, la mère est à terme et présente des signes de début de travail avec un col mi mou, centré et à un doigt.

B. Césarienne : Bien que ce soit une option en cas de détresse fœtale aiguë ou d'autres complications, le CTG montre un rythme cardiaque fœtal stable à 145 bpm. Il n'y a pas d'indication immédiate de souffrance fœtale nécessitant une césarienne urgente.

C. Hospitaliser et attendre 48h : Cette option n'est pas recommandée car le liquide méconial est un signe de stress fœtal potentiel, et une attente prolongée pourrait augmenter le risque de complications.

D. Antibiothérapie : Il n'y a aucune indication d'infection maternelle ou de fièvre dans ce cas. L'antibiothérapie n'est donc pas justifiée uniquement en raison de la présence de liquide méconial.

Réponse C: pas de signe de chorioamnionite, travail déjà en cours.

(Question d'ancrage) Constat de décès par le médecin de garde à domicile, la porte doit être forcée pour rentrer dedans. A l'intérieur, **corps en état de décomposition avancé**. Le médecin traitant est contacté et dit que l'habitante de l'appartement est connue pour des maladies cardio-vasculaires et a fait un infarctus il y a 6 mois. Que faire?

- A. Retenir que c'est une mort naturelle
- B. **Appeler la police**
- C. Contacter la famille pour avertir du décès
- D. Rédiger un constat de décès au nom de la dame de l'appartement

Dans la situation décrite, voici les étapes appropriées à suivre, basées sur les protocoles de certification et d'enquête sur les décès en cas de décomposition avancée :

1. Appeler la police : Le décès en état de décomposition avancée doit être considéré comme un décès sous des circonstances inhabituelles ou potentiellement suspectes. Cela nécessite l'intervention des autorités pour une enquête approfondie.

2. Contacter le médecin légiste : Une enquête par un médecin légiste ou un coroner est nécessaire pour déterminer la cause exacte du décès et s'assurer qu'il n'y a pas eu de violence ou de négligence impliquée. Le corps ne doit pas être déplacé avant l'arrivée du coroner ou du médecin légiste.

3. Informer la famille : Une fois que la police et les autorités compétentes ont été contactées, il est important d'informer la famille de la personne décédée du décès et des procédures en cours.

Réponse: B

Question 33

Un homme de 22 ans en bonne santé habituelle se présente à votre consultation pour une fatigue et une **douleur au niveau du pharynx**. Il est rentré il y a deux mois d'un voyage de 3 mois en Tanzanie. Vous objectivez à l'examen clinique un **état subfébrile**, des **adénopathies cervicales**, une **rate palpable** en dessous du rebord costal et un **pharynx hyperémié**. Tension à 115/82, Fc à 88/min. Quel est le diagnostic le plus probable?

Mononucleose
EBV

- A. Leucémie myéloïde aiguë
- B. Infection à Epstein Barr virus
- C. Malaria
- D. Angine à streptocoques

Réponse B

Question 34

Une femme de 43 ans mère au foyer se casse le bras en tombant d'une échelle alors qu'elle jardinait. Elle est assurée par la Lamal mais n'a pas de complémentaire accident. Qui paie les frais médicaux ?

- A. LAA
- B. Lamal
- C. Assurance maternité
- D. La patiente

Réponse B (+1) ou D (+4)?

Question 38 (Question d'ancrage)

Un adolescent de 15 ans se présente aux urgences avec une douleur intense, soudaine au niveau des testicules. À l'examen clinique, le testicule est remonté, le scrotum est rouge, tuméfié et douloureux à la palpation. La bandelette urinaire est normale. Quelle est l'attitude à adopter.

- A. Hospitaliser et suivre l'évolution
- B. RAD avec antalgie
- C. Garder en observation aux urgences et mettre de la glace
- D. Donner des AB
- E. Explorer chirurgicalement

Réponse E

Question 39

Un homme de 35 ans, après une semaine de diarrhée aqueuse, se présente aux urgences pour une perte de force progressive dans les membres inférieurs. À l'examen clinique, on note une force M4 aux membres inférieurs, une diminution de la sensibilité symétrique et une aréflexie. Quelle est la mesure à prendre?

- A. ENMG
- B. IRM lombaire
- C. PL
- D. CT cérébral

Syndrome de Guillain-Barré (SGB)

Définition :

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est une polyradiculonévrite aiguë d'origine auto-immune, caractérisée par une faiblesse musculaire progressive bilatérale et des troubles sensoriels, tels que des paresthésies.

Pathogénie :

- Les autoanticorps ciblent des antigènes dans la gaine de myéline, les cellules de Schwann et les membranes axonales.
- Souvent précédé par une infection des voies respiratoires supérieures ou gastro-intestinales (environ 65% des cas).

Caractéristiques Cliniques :

- Faiblesse musculaire bilatérale rapidement progressive, généralement ascendante à partir des membres inférieurs.
- Implication sensorielle (e.g., paresthésies).
- Hyporéflexie ou aréflexie.

Diagnostics :

- Diagnostic Clinique : Basé sur les symptômes typiques et l'exclusion d'autres diagnostics, en particulier dans les présentations atypiques.
- Analyse du Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) : Montre une dissociation albuminocytologique (augmentation des protéines avec une numération leucocytaire normale).
- Études Électrodiagnostiques : Études de conduction nerveuse et électromyographie pour soutenir le diagnostic et classer les sous-types de SGB.

Traitement :

- Immunoglobulines Intraveineuses (IVIg)
- Plasmaphérèse
- Surveillance étroite des complications telles que l'insuffisance respiratoire, l'embolie pulmonaire et l'arrêt cardiaque.

Prognostic :

- Taux de mortalité : ~5%
- Jusqu'à 20% des patients restent sévèrement handicapés malgré le traitement.

Arguments en faveur de l'infection à EBV (Mononucléose infectieuse) :

- **Fatigue et état subfébrile** : Symptômes courants dans la mononucléose infectieuse.
- **Adénopathies cervicales** : Typiquement présentes dans l'infection à EBV.
- **Splénomégalie** : Fréquente dans les cas de mononucléose infectieuse.
- **Pharynx hyperémié** : L'angine ou la pharyngite est souvent observée dans la mononucléose.

Arguments contre les autres diagnostics :

- **Leucémie myéloïde aiguë** : Les symptômes peuvent inclure la fatigue et l'adénopathie, mais la présence de pharyngite et de splénomégalie sans autres signes hématologiques (comme l'anémie, les infections fréquentes, les hémorragies) est moins suggestive.
- **Malaria** : Généralement caractérisée par des épisodes de fièvre, des frissons et des sueurs, mais moins fréquemment associée à une pharyngite et des adénopathies cervicales.
- **Angine à streptocoques** : Peut expliquer la pharyngite et l'hyperémie pharyngée, mais ne s'accompagne généralement pas de splénomégalie ni d'adénopathies cervicales généralisées.

Pour confirmer le diagnostic d'infection à EBV, des tests d'anticorps (comme le test Monospot) peuvent être réalisés, ainsi qu'une analyse de laboratoire montrant une lymphocytose avec plus de 10% de lymphocytes atypiques.

Avantages de l'assurance complémentaire accident pour une mère au foyer :

1. **Couverture étendue** : Elle couvre des prestations supplémentaires non incluses dans la LAMal, comme les soins à domicile, les traitements alternatifs, ou des chambres privées en cas d'hospitalisation.
2. **Indemnités journalières** : En cas d'incapacité temporaire de travailler (comme pour les tâches ménagères), elle peut recevoir une indemnité journalière.
3. **Aucun coût à la charge** : La complémentaire accident peut couvrir des franchises et des quotes-parts, réduisant ainsi les frais personnels.
4. **Transport et rapatriement** : En cas d'accident grave, elle peut couvrir les frais de transport médical et de rapatriement.
5. **Soins de réadaptation** : Elle peut offrir des prestations pour la réadaptation et la convalescence, améliorant ainsi le rétablissement.

Question 38 (Question d'ancrage)

Un adolescent de 15 ans se présente aux urgences avec une douleur intense, soudaine au niveau des testicules. À l'examen clinique, le testicule est remonté, le scrotum est rouge, tuméfié et douloureux à la palpation. La bandelette urinaire est normale. Quelle est l'attitude à adopter.

La torsion testiculaire est une urgence chirurgicale où le cordon spermatique se tord, coupant l'apport sanguin au testicule.

Épidémiologie :

- Plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes.
- Peut survenir à tout âge.

Étiologie :

- Anomalies anatomiques prédisposantes (ex. : « clapper bell »).
- Activité physique ou traumatismes.

Clinique :

- Début soudain de douleur intense unilatérale dans le testicule.
- Position anormale du testicule (souvent plus élevé).
- Scrotum rouge, tuméfié, et douloureux à la palpation.
- Absence de réflexe crémasterien.
- Signes de préhn négatif (soulever le testicule n'améliore pas la douleur).

Diagnostic :

- Clinique : Basé sur l'examen physique et l'histoire du patient.
- Imagerie :
 - Échographie Doppler : Absence de flux sanguin dans le testicule affecté.
 - Whirlpool sign : Image caractéristique du cordon spermatique tordu.

Traitement :

- Chirurgie immédiate : Détorsion manuelle et fixation testiculaire (orchidopexie) pour prévenir la récurrence.
- Temps critique : Le traitement doit être fait dans les 6 heures suivant le début des symptômes pour éviter une nécrose testiculaire.

Prognostic :

- Le taux de survie du testicule dépend de la rapidité de l'intervention chirurgicale.
- Retard dans le traitement peut entraîner une perte du testicule affecté et des complications comme l'atrophie testiculaire.

Syndrome de Guillain-Barré (SGB)

Définition :

Le syndrome de Guillain-Barré (SGB) est une polyradiculonévrite aiguë d'origine auto-immune, caractérisée par une faiblesse musculaire progressive bilatérale et des troubles sensoriels, tels que des paresthésies.

Pathogénie :

- Les autoanticorps ciblent des antigènes dans la gaine de myéline, les cellules de Schwann et les membranes axonales.
- Souvent précédé par une infection des voies respiratoires supérieures ou gastro-intestinales (environ 65% des cas).

Caractéristiques Cliniques :

- Faiblesse musculaire bilatérale rapidement progressive, généralement ascendante à partir des membres inférieurs.
- Implication sensorielle (e.g., paresthésies).
- Hyporéflexie ou aréflexie.

Diagnostics :

- Diagnostic Clinique : Basé sur les symptômes typiques et l'exclusion d'autres diagnostics, en particulier dans les présentations atypiques.
- Analyse du Liquide Céphalo-Rachidien (LCR) : Montre une dissociation albuminocytologique (augmentation des protéines avec une numération leucocytaire normale).
- Études Électrodiagnostiques : Études de conduction nerveuse et électromyographie pour soutenir le diagnostic et classer les sous-types de SGB.

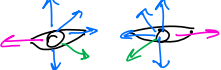
Traitement :

- Immunoglobulines Intraveineuses (IVIg)
- Plasmaphérèse
- Surveillance étroite des complications telles que l'insuffisance respiratoire, l'embolie pulmonaire et l'arrêt cardiaque.

Prognostic :

- Taux de mortalité : ~5%
- Jusqu'à 20% des patients restent sévèrement handicapés malgré le traitement.

Une patiente en bonne santé habituelle qui se présente avec une **diplopie verticale**. Elle voit double quand elle **regarde en-bas à gauche**. Quelle structure est atteinte ?

- A. Myasthénie oculaire 
 B. Paralyse du nerf abducens gauche
 C. **Paralyse du nerf trochléaire droite IV**
 D. Paralyse du nerf oblique inférieur gauche
 E. Paralyse du nerf oculomoteur droite

La diplopie verticale qui augmente lorsqu'on regarde en bas à gauche indique généralement **une atteinte du nerf trochléaire** (quatrième nerf crânien). Le muscle supérieur oblique, innervé par le nerf trochléaire, est principalement responsable de la dépression de l'œil en position adductée. Une paralysie du nerf trochléaire droit entraînera une difficulté à déprimer l'œil droit en adduction, provoquant une diplopie lorsque la patiente regarde en bas à gauche.

Réponse C

Question 52

(Ancrage) Patient 56 ans connu pour des crises d'épilepsies tonico-cloniques généralisée depuis 6 ans suite à un accident de la voie publique. Il bénéficie dès lors d'un traitement par acide valproïque. Ce patient est hospitalisé pour une broncho-pneumonie avec un traitement antibiotique de amoxicilline/acide clavulanique. Durant l'hospitalisation il a présenté en l'espace de 4 heures, **2 crises focales** prenant le membre supérieur droite puis **1 crises focales progressant en crise généralisée tonico-clonique** avec altération de la conscience.

Le **status epilepticus (EME)** est défini comme une crise d'épilepsie qui dure au moins 5 minutes ou une série de crises se succédant rapidement sans retour complet à l'état neurologique normal entre les crises. Cette condition augmente le risque de conséquences à long terme, telles que des lésions neuronales et des déficits fonctionnels.

Quelle est la meilleure attitude à tenir face à ce patient ?

- A. Attendre que les crises se résolvent puis augmenter le traitement de fond
 B. Effectuer un CT cérébral injecté
 C. Administrer une dose supplémentaire acide valproïque par rapport à son traitement de base
 D. Administrer des **benzodiazépines iv** puis de la **phénytoïne iv**
 E. Administrer une hydratation iv et donner un fébrifuge

Réponse: D

Question 51

Un patient de 32 ans arrive aux urgences avec une **sensation d'oppression thoracique** importante. En **hypotension** et **tachycardie**. Un cathétérisme de Swann-Ganz met en évidence des **résistances systémiques augmentées**.
 Quelle est la nature du **choc** ?

- A. Sepsis
 B. Insuffisance surrénalienne aiguë
 C. Neurogène
 D. Embolie pulmonaire
 E. **Cardiogène**

Le **cathétérisme de Swan-Ganz**, également appelé cathétérisme du cœur droit, est une procédure utilisée pour mesurer les pressions dans le cœur droit et l'artère pulmonaire. Voici les points clés de cette procédure :

Description
 • Le cathétérisme de Swan-Ganz implique l'insertion d'un cathéter à ballonnet à lumière multiple dans le cœur droit et l'artère pulmonaire pour surveiller les pressions intracardiaques et les pressions artérielles pulmonaires. Ce cathéter est appelé cathéter de Swan-Ganz.

Indications

1. Évaluation des patients avec insuffisance cardiaque, cardiomyopathie, maladies cardiaques congénitales et valvulopathies :
 - Mesure de la pression, de l'oxygène et du débit cardiaque du cœur droit pour évaluer la gravité de la dysfonction.
 - Mesure de la pression capillaire pulmonaire bloquée (PCWP) pour diagnostiquer la gravité de l'insuffisance ventriculaire gauche et de la sténose mitrale.
2. Hypertension pulmonaire suspectée :
 - Mesure de la pression artérielle pulmonaire moyenne (mPAP) et de la pression veineuse centrale (CVP).

Procédure

1. Accès veineux : Une veine (généralement dans l'aîne, le bras ou le cou) est ponctionnée pour insérer le cathéter.
2. Avancement du cathéter : Le cathéter de Swan-Ganz est avancé à travers les chambres droites du cœur jusqu'à l'artère pulmonaire.
3. Mesures des pressions : Les pressions sont mesurées à différents points, incluant l'oreillette droite, le ventricule droit, et l'artère pulmonaire.

Utilité

- Pression artérielle pulmonaire : Évaluation des pressions pour diagnostiquer l'hypertension pulmonaire.
- Pression capillaire pulmonaire bloquée (PCWP) : Indirectement mesure la pression de l'oreillette gauche, utile pour évaluer l'insuffisance ventriculaire gauche.
- Débit cardiaque : Mesure du débit cardiaque pour évaluer la fonction cardiaque globale.

Hémodynamique en choc cardiogénique (contexte de l'utilisation)

- Choc cardiogénique : Augmentation de la pression capillaire pulmonaire bloquée (PCWP), diminution du débit cardiaque (CO), augmentation de la résistance vasculaire systémique (SVR).

Choc cardiogénique

A. Sepsis

Sepsis est une réponse inflammatoire systémique sévère à une infection qui peut entraîner un dysfonctionnement organique. Le choc septique est une forme de choc distributif qui se caractérise par une vasodilatation systémique, une hypotension persistante nécessitant des vasopresseurs pour maintenir une pression artérielle moyenne (PAM) ≥ 65 mmHg, et une hyperlactatémie (> 2 mmol/L) malgré une réanimation liquidienne adéquate. Cependant, dans ce cas, les résistances vasculaires systémiques sont diminuées, ce qui ne correspond pas à l'augmentation des résistances observée chez le patient.

B. Insuffisance surrénalienne aiguë

L'insuffisance surrénalienne aiguë peut entraîner un choc hypovolémique et distributif en raison d'une perte de sodium et d'eau, et d'une incapacité à maintenir une vasoconstriction adéquate. Les patients peuvent présenter une hypotension, une tachycardie, et des niveaux de potassium élevés. Toutefois, une résistance vasculaire systémique augmentée n'est pas typique de cette condition.

C. Neurogène

Le choc neurogénique résulte d'une lésion du système nerveux central, souvent à la suite d'une lésion de la moelle épinière, qui entraîne une perte de tonus sympathique. Les caractéristiques incluent une hypotension, une bradycardie (contrairement à la tachycardie), et une peau chaude et sèche due à une vasodilatation périphérique. La résistance vasculaire systémique est généralement diminuée dans le choc neurogénique, ce qui ne correspond pas à l'augmentation observée chez le patient.

D. Embolie pulmonaire

L'embolie pulmonaire massive peut entraîner un choc obstructif. Les patients présentent une hypotension, une tachycardie, et une augmentation de la résistance vasculaire pulmonaire qui peut également augmenter la résistance vasculaire systémique. Les signes cliniques peuvent inclure une dyspnée aiguë, des douleurs thoraciques, et des signes de cœur droit aigu (comme la dilatation des veines jugulaires). Toutefois, l'embolie pulmonaire n'est pas la cause la plus fréquente d'une résistance vasculaire systémique augmentée.

E. Cardiogène

Le choc cardiogénique est causé par une défaillance cardiaque aiguë, souvent due à un infarctus du myocarde, une cardiomyopathie ou des arythmies sévères. Les caractéristiques incluent une hypotension, une tachycardie, une augmentation de la résistance vasculaire systémique en réponse à la baisse du débit cardiaque, une congestion pulmonaire et des signes de congestion veineuse systémique comme une jugulaire distendue. Les résistances vasculaires systémiques augmentées correspondent bien à l'état décrit chez le patient.

Une femme de 65 ans qui présente des douleurs thoraciques soudaines irradiantes dans les omoplates. Son mari appelle les secours qui trouvent Madame tachycarde et avec des sueurs froides (FC 120, TA 110/80). Elle est amenée aux urgences. A son arrivée à l'hôpital elle présente en plus des douleurs abdominales.

Quel est le meilleur moyen diagnostique :

- A. Coronarographie en urgence
- B. CT injecté thorax et abdomen
- C. US abdominal
- D. Radiographie thorax

Réponse : B

Question 65

Fille de 12 ans, fièvre, exanthème hémorragique. Elle développe par la suite une microhématurie ainsi qu'un méléna et forte douleur articulaire. Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Vasculite à IgA
- B. Périarterite noueuse
- C. Purpura thrombocytopénique idiopathique
- D. Lupus érythémateux
- E. Glomérulonéphrite

Vasculite à IgA :

Symptômes principaux :

- Fièvre
- Exanthème hémorragique (purpura palpable)
- Douleurs articulaires
- Atteinte rénale (hématurie)
- Manifestations gastro-intestinales (méléna)

La vasculite à IgA, également connue sous le nom de purpura de Henoch-Schönlein, est une petite vascularite médée par des complexes immuns qui survient principalement chez les enfants.

Les caractéristiques cliniques typiques comprennent :

- Purpura palpable : souvent sur les membres inférieurs et les fesses.
- Douleurs articulaires : principalement aux genoux et aux chevilles.
- Douleurs abdominales : souvent coliques et peuvent être accompagnées de saignements gastro-intestinaux (hématomène ou méléna).
- Atteinte rénale : hématurie et parfois protéinurie.

Norette: Rép E selon amboss (Bimodal age distribution; mostly affects children (between the ages of 3–12 years) and patients > 60 years of age

Réponse : B (plutôt A non ? → purpura de Henoch-Schönlein)(B fait de la fièvre, des symptômes cutanées, digestifs, articulaires et il n'y a pas de purpura dans l'anamnèse) (Je dirais aussi la A, touche plus les enfants, 75% arthralgie, 50% synd néphritiques, darrière sanguinolante/Melena et pupura palpable, alors que la B c'est plus les vieux, fait une IRA/HTA, au niveau cut plutôt ulcère et nodule). A +3

Question 66.

Patiente de 72 ans a subi une chirurgie pour remplacer sa valve mitrale. On lui donne des anticoagulants. 36 heures plus tard, elle fait un arrêt cardio-circulatoire et on la réanime. Le scope montre un rythme sinusal, la pression est à 85/55 mmHg, FC 128/min. Qu'est ce qui est le plus urgent à faire?

- A. CT thoracique
- B. Echocardiographie
- C. RX thorax dans le lit
- D. Poser un drain thoracique
- E. ECG et dosage des enzymes cardiaques

La situation clinique décrite, avec une hypotension sévère et une tachycardie après une chirurgie de remplacement de la valve mitrale, suggère fortement une tamponnade cardiaque. L'action la plus urgente à entreprendre est une échocardiographie car elle permet de diagnostiquer rapidement une tamponnade cardiaque en visualisant l'épanchement péricardique et ses effets sur le cœur. Une tamponnade cardiaque nécessite une intervention immédiate, comme une péricardiocentèse, pour évacuer le liquide péricardique et soulager la pression sur le cœur.

Indications de la tamponnade cardiaque :

- Tachycardie et hypotension
- Signes de choc (pression artérielle basse, tachycardie)
- Histoire récente de chirurgie cardiaque

Définition

- Épanchement péricardique : Accumulation de liquide dans l'espace péricardique entre le péricarde pariétal et viscéral, pouvant être aigu ou chronique.
- Tamponnade cardiaque : Processus pathophysiologique où une pression intrapéricardique élevée due à un épanchement péricardique comprime le cœur, surtout le ventricule droit.

Caractéristiques Cliniques

- Épanchement péricardique :
 - Souvent asymptomatique initialement
 - Dyspnée, surtout en décubitus (orthopnée)
 - Douleur thoracique rétrosternale
 - Symptômes de compression : enrouement, nausées, dysphagie, hoquets
 - Difficulté à localiser l'impulsion apicale
- Tamponnade :
 - Triade de Beck : Hypotension, bruits cardiaques assourdis, distension des veines jugulaires
 - Tachycardie, pouls paradoxal
 - Pâleur, sueurs froides
 - Insuffisance ventriculaire gauche
 - Symptômes d'insuffisance cardiaque droite
 - Choc obstructif, arrêt cardiaque (activité électrique sans pouls)

Évaluation et Gestion

- Évaluation rapide des patients instables :
 - Diagnostic clinique confirmé souvent rétrospectivement
 - Utiliser l'échographie cardiaque ciblée (POCUS) pour confirmer la présence d'un épanchement péricardique
 - Évaluer la nécessité d'un drainage immédiat du liquide péricardique
 - Consultations avec un cardiologue et/ou un chirurgien cardiothoracique
- Drainage urgent du liquide péricardique :
 - Péricardiocentèse sous guidage échographique ou fluoroscopique
 - Gestion chirurgicale immédiate en cas d'échec de la péricardiocentèse
- Support hémodynamique :
 - Accès IV avec deux grosses lignes
 - Réanimation liquidienne prudente
 - Support inotrope : dobutamine
 - Éviter les agents anesthésiques et la ventilation en pression positive
- Gestion subséquente :
 - Identification et traitement de la cause sous-jacente
 - Surveillance des complications et de la réaccumulation du liquide
 - Admission en unité de soins intensifs (ICU)
 - Surveillance télémétrique continue, mesure régulière du pouls paradoxal

Épanchement parapneumonique = Accumulation de liquide exsudatif dans la cavité pleurale en réponse à une pneumonie.

- **Non compliqué** : Sans invasion bactérienne directe.
- **Compliqué** : Extension de l'infection bactérienne dans l'espace pleural.

Caractéristiques cliniques

- Fièvre, frissons
- Toux
- Gêne thoracique

Diagnostic

- Imagerie : Pneumonie associée
- Analyse du liquide pleural :
 - Épanchement exsudatif
 - Apparence trouble ou purulente
 - Leucocytes > 10 000 cellules/μL
 - pH < 7.2
 - LDH élevé
 - Glucose < 60 mg/dL (< 3.3 mmol/L)

Traitement

- Tous les patients :
 - Traitement antibiotique systémique. Un traitement précoce peut prévenir la progression vers un épanchement compliqué et un empyème.
- Patients avec épanchements parapneumoniques compliqués :
 - Thoracentèse thérapeutique
- Patients à haut risque de progression vers un empyème pleural :
 - Consultation chirurgicale pour un drainage chirurgical.

Question A : Jeune homme avec pneumonie traitée par co-amoxicilline. Après 10 jours, péjoration des symptômes avec dyspnée, toux et état fébrile. A la radio, épanchement basi-thoracique droit. Cet épanchement est ponctionné :

LDH augmentés

Présence d'une leucocytose à prédominance de neutrophiles, pH 7, glucose 2 mmol/l

Que faut-il faire?

- Passer à de la clarithromycine PO
- Mettre un drain pleural
- Administrer du furosémide
- Contrôle clinique dans deux jours
- Donner de la Ceftriaxone intra-pleurale

La situation décrite correspond à un épanchement parapneumonique compliqué d'une pneumonie, comme l'indiquent les résultats de la ponction pleurale (LDH augmentés, leucocytose à prédominance neutrophilique, pH < 7, et glucose < 2 mmol/l).

Selon les recommandations, le traitement approprié pour un épanchement parapneumonique compliqué inclut la mise en place d'un drain pleural pour permettre le drainage du liquide infecté et prévenir l'évolution vers un empyème.

Réponse : B (car épanchement parapneumonique compliquée pH<7)

Jeune fille de 18 ans qui vient après 3 pertes de connaissance survenant après des périodes prolongées de station debout, dont deux dans un bar et une à un concert de rock. Que faire?

- Test de Shellong
- Contrôle cardiaque complet
- Envoyer chez le neurologue
- Prendre la TA au deux bras, en position assise

Les épisodes de perte de conscience chez une jeune fille de 18 ans après des périodes prolongées de station debout sont probablement dus à une **syncope vasovagale** ou à une **hypotension orthostatique**.

La **syncope vasovagale**, également appelée **syncope neurocardiogénique**, est fréquente chez les jeunes et est souvent déclenchée par des facteurs comme la **station debout prolongée**. La méthode de diagnostic recommandée pour confirmer une syncope vasovagale est le **test de Shellong** (ou **tilt-test**), qui permet d'évaluer la réponse cardiovasculaire à la station debout prolongée.

Réponse A (Est-ce qu'on va pas d'abord prendre la TA avant de faire un schellong ?) Je ne sais pas si la question était que faire d'abord ou quel examen diagnostique ? Schellong ça te prend déjà la pression, genre deux en un.

Syncope vaso-vagale => pas de Schellong -> mais du coup quoi ?

Je ferais pas de Schellong parce que c'est pas EN SE LEVANT mais quand elle était debout. Je vois plus la possibilité d'un vol sous-clavier, auquel cas on aura une tension différente dans les deux bras j'imagine -> D mais la station debout peut induire un réflexe vaso-vagal (surtout dans un bar et concert où il fait chaud -> vasodilatation)

Patient de 74 ans, avec HTA qui est sous IEC, BB, omeprazole, benzodiazépines et amlodipine. Labo avec hypocalcémie, hypomagnésémie, hypokaliémie. Quel médicament à l'origine?

- IEC
- BB
- IPP
- Benzo
- Aml

Effets secondaires des inhibiteurs de la pompe à protons (IPP)

Gastro-intestinaux

- Nausées, diarrhée, douleurs abdominales, flatulences
- Risque accru d'infection à C. difficile
- Hypergastrinémie réactionnelle
- Diminution de l'absorption de :
 - Fer
 - Vitamine B12
 - Calcium et magnésium → Augmentation du risque d'ostéoporose à long terme → Risque accru de fractures chez les personnes âgées

Neurologiques

- Étourdissements, maux de tête
- Possiblement un risque accru de développer des troubles cognitifs/démence

Autres

- Éruptions cutanées
- Troubles visuels (rares)
- Risque accru de pneumonie
- Néphrite interstitielle aiguë (rare)

- **Hypomagnésémie** : Les IPP sont connus pour réduire l'absorption intestinale du magnésium, conduisant à une hypomagnésémie.
- **Hypocalcémie** : La réduction de magnésium peut entraîner une diminution de la sécrétion de PTH ou une résistance à la PTH, entraînant une hypocalcémie.
- **Hypokaliémie** : Bien que moins direct, la perturbation du magnésium peut également affecter d'autres électrolytes, y compris le potassium.

Réponse : C

Question 121

M. De 77 ans, connu pour une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (25%) ainsi que pour un diabète de type 2. Ses traitements sont : torasémide, spironolactone, enalapril et bisoprolol. Il se présente à votre cabinet, en période de grande chaleur, en raison d'une fatigue considérable. Il dit s'être moins hydraté que d'habitude. Vous mesurez une tension à

105/65. L'ECG montre complexes QRS élargis, ondes T très pointues et hautes dans les dérivations précordiales.

Qu'est qui est à l'origine de la fatigue ?

- A. Hypocalcémie
- B. Hypercalcémie
- C. Hypokaliémie
- D. Hyperkaliémie
- E. Hyponatrémie

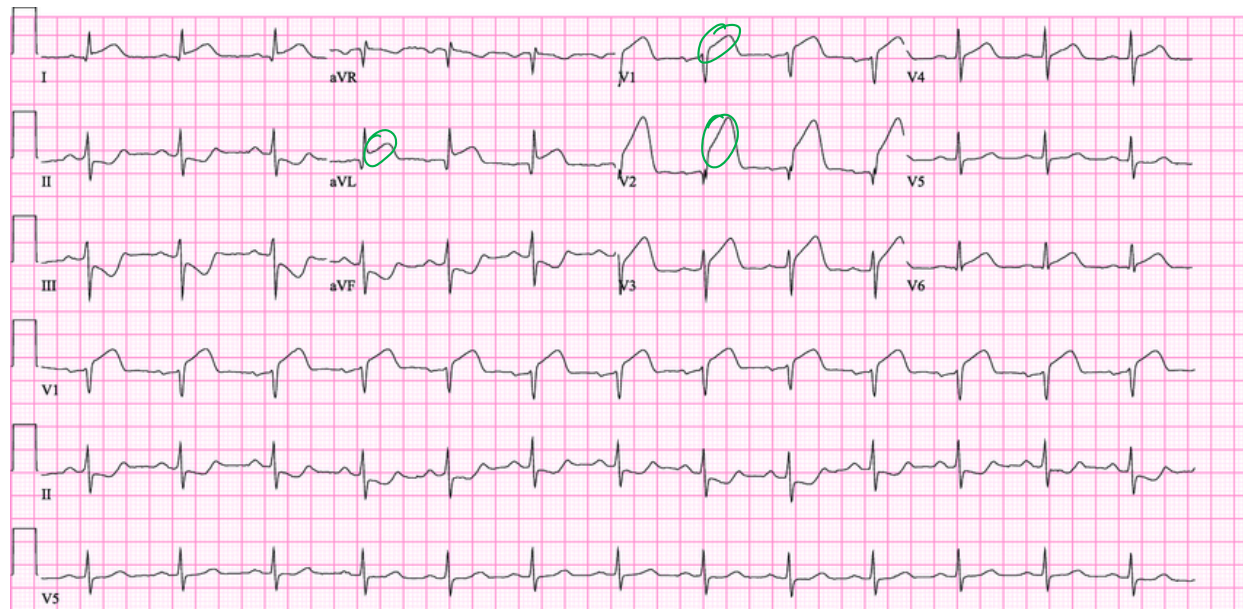
Les signes ECG de complexes QRS élargis et d'ondes T pointues et hautes sont caractéristiques d'une **hyperkaliémie**. De plus, dans le contexte de l'**insuffisance cardiaque** et de la prise de médicaments comme la **spironolactone** (un diurétique épargneur de potassium) et l'**enalapril** (un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine), le patient est à risque d'hyperkaliémie, surtout en période de **déshydratation**.

Hyperkaliémie :

- **ECG :** Complexes QRS élargis, ondes T pointues et hautes.
- **Symptômes :** Fatigue, faiblesse musculaire.

Réponse : D, E (ce ne serait pas plutôt l'hyponatrémie qui fait la fatigue et l'hyperkaliémie les troubles de l'ECG? pas con en effet)

STEMI Patient de X années, se présente au cabinet pour une **douleur thoracique** à gauche depuis quelques heures, **ne cède pas au paracétamol**. Vous faites l'ECG, qui donne :



25mm/s 10mm/mV 40Hz L'ECG présenté montre des signes classiques d'un infarctus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI), comme en témoignent les **élévations du segment ST** visibles dans plusieurs dérivations.

Que faire ?

Dans ce cas, il est crucial d'agir rapidement pour minimiser les dommages cardiaques et améliorer les chances de survie du patient. Le choix de l'action dépend des ressources disponibles et du niveau de soins requis.

- A. Donner un antalgique plus fort que le paracétamol
- B. **Envoyer en urgence avec ambulances dans un hôpital universitaire**
- C. Faire ECG, doser troponines et l'envoyer tout de suite dans un hôpital régional
- D. Faire un ECG, doser les troponines et l'envoyer à l'hôpital en fonction des résultats des troponines.

Options :

A. Donner un antalgique plus fort que le paracétamol : Non approprié en cas de STEMI, nécessite une prise en charge d'urgence.

B. **Envoyer en urgence avec ambulances dans un hôpital universitaire** : Correct, mais l'ECG et le dosage des troponines devraient être faits si possible.

C. Faire ECG, doser troponines et l'envoyer tout de suite dans un hôpital régional : Correct, car un diagnostic rapide et un traitement d'urgence sont nécessaires.

D. Faire un ECG, doser les troponines et l'envoyer à l'hôpital en fonction des résultats des troponines : Retarder l'envoi à l'hôpital en attendant les résultats des troponines n'est pas recommandé dans les cas suspects de STEMI.

Réponse : B

Patiente qui consulte pour une blessure à la face postérieure de la cuisse. Pas d'artères ni d'autres structures importantes lésées. A l'examen clinique on trouve d'autres anciennes cicatrices comme de coupure sur les avant-bras. La patiente semble tendue mais elle est coopérante. Depuis quelque temps les relations avec sa partenaire sont plus tendues et il lui

Caractéristiques du trouble de la personnalité borderline

- Impulsivité et comportements autodestructeurs : Elle se blesse lorsqu'elle est stressée ou en conflit, ce qui est typique des comportements impulsifs et autodestructeurs associés au trouble borderline.
- Instabilité émotionnelle : La patiente décrit des crises de colère fréquentes, ce qui indique une instabilité émotionnelle.
- Peur de l'abandon : L'anxiété liée à l'absence de sa thérapeute suggère une peur intense de l'abandon, courante chez les personnes avec un trouble borderline.
- Automutilation : Les marques de coupures anciennes sur les avant-bras sont des signes d'automutilation, fréquents chez les individus avec ce trouble.
- Relations interpersonnelles instables : Les relations tendues avec sa partenaire indiquent une instabilité dans les relations interpersonnelles, typique du trouble borderline.
- Sentiments de vide et de désespoir : La patiente mentionne que ses envies de mort disparaissent après s'être blessée, ce qui peut indiquer des sentiments chroniques de vide et de désespoir.

arrive régulièrement de faire des crises de colère. Elle s'est également tapé la tête contre le mur et elle n'a pas ressenti de douleur. Elle s'est sentie mieux après avoir fait cela et ses envies de mort ont disparu. Elle mentionné que sa thérapeute est en vacances depuis deux semaines. Quel est le diagnostic ?

- A. Trouble de la personnalité histrionique
- B. trouble de la personnalité schizoïde
- C. manque de confiance en soi
- D. trouble de la personnalité de type dépendant
- E. Trouble de la personnalité de type émotionnel labile (borderline)

Réponse E

(Question d'ancrage) Femme enceinte sur la 30aine qui fait méningite avec résultat de PL liquide claire, pléocytose et beaucoup de lympho. Cause :

- A. Listeria
 - B. S. pneumoniae
 - C. N. meningitidis
 - D. H. influenzae
- Listeria monocytogenes est connue pour provoquer une méningite avec un liquide céphalo-rachidien clair et une pléocytose lymphocytaire, en particulier chez les femmes enceintes.
 - Les autres agents pathogènes énumérés (S. pneumoniae, N. meningitidis, H. influenzae) sont plus susceptibles de provoquer une pléocytose neutrophilique.

Réponse : A

(Q ancrage) Femme enceinte Rh+ avec anti-D 1:182. A eu une fausse couche et un enfant d'un premier mari qui a du subir des transfusions sanguines après la naissance avec son premier mari. Actuellement il faut déterminer :

- A. groupe sanguin paternel
- B. groupe sanguin du fœtus par amniocentèse
- C. groupe sanguin du foetus par prise de sang maternel
- D. rien
- E. administrer anti-D

Pour une femme enceinte Rh négative avec un titre d'anticorps anti-D de 1:182, qui a eu une fausse couche et un enfant nécessitant des transfusions sanguines après la naissance. Contexte et Sensibilisation

- Titre d'anticorps anti-D de 1:182 : Un titre supérieur à 1:8 est généralement significatif et indique une sensibilisation maternelle aux antigènes Rh fœtaux. Cette sensibilisation peut entraîner une maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né (HDFN).
- Historique Obstétrical : Les fausses couches précédentes et la nécessité de transfusions sanguines pour le premier enfant suggèrent une sensibilisation antérieure importante.

- A. Déterminer le groupe sanguin paternel : Peut aider à évaluer le risque pour le fœtus actuel, mais n'est pas suffisant comme seule mesure. Si le père est Rh positif, le fœtus pourrait être à risque de maladie hémolytique.
- B. Déterminer le groupe sanguin du fœtus par amniocentèse : Procédure invasive avec des risques, utilisée pour déterminer le groupe sanguin du fœtus et évaluer l'hémolyse.
- C. Déterminer le groupe sanguin du fœtus par prise de sang maternel : Méthode non invasive pour déterminer le groupe sanguin fœtal et évaluer le risque de maladie hémolytique. Moins risquée que l'amniocentèse.
- D. Ne rien faire : Non recommandé en raison du titre élevé d'anticorps anti-D, ce qui nécessite une surveillance attentive.
- E. Administrer anti-D : Inapproprié pour une mère déjà sensibilisée (présence d'anticorps anti-D).

L'alloimmunisation, (Immunisation Rhésus) est une réponse immunitaire chez une femme enceinte Rh nég qui a été exposée à des globules rouges Rh pos. Cela peut se produire lors d'une grossesse antérieure, d'une fausse couche, d'une procédure invasive ou d'une transfusion sanguine.

- Rh incompatibilité : Lorsqu'une femme Rh négative est enceinte d'un fœtus Rh positif, des globules rouges fœtaux peuvent passer dans la circulation maternelle, surtout pendant l'accouchement, provoquant la formation d'anticorps anti-D par la mère. Ces anticorps peuvent traverser le placenta lors des grossesses ultérieures et attaquer les globules rouges du fœtus, entraînant une anémie hémolytique fœtale.
- Alloimmunisation ABO : Peut survenir même lors de la première grossesse car les anticorps anti-A et anti-B sont naturellement présents. Cependant, cette forme est souvent moins sévère que l'alloimmunisation Rh.

Risques et Complications

- Maladie hémolytique du fœtus et du nouveau-né : Une destruction des globules rouges fœtaux entraînant une anémie sévère, une hyperbilirubinémie et, dans les cas graves, une hydropisie fœtale (hydrops fœtal).
- Anémie fœtale : Peut nécessiter des interventions telles que des transfusions intra-utérines.

Dépistage et Diagnostic

- Typage ABO et Rh : Dès le début de la grossesse pour toutes les femmes enceintes.
- Test des anticorps anti-D : Pour les femmes Rh négatives, à 28 semaines de gestation et après toute procédure à risque de saignement fœto-maternel.
- Surveillance : Si des anticorps anti-D sont présents, des échographies Doppler de l'artère cérébrale moyenne fœtale sont effectuées pour évaluer l'anémie fœtale.

Prévention

- Immunoglobuline anti-D (RhoGAM) : Administrée aux femmes Rh négatives non sensibilisées à 28 semaines de gestation et dans les 72 heures suivant l'accouchement d'un bébé Rh positif, ainsi qu'après tout événement potentiellement sensibilisant (fausse couche, amniocentèse, etc.).
- Photothérapie : Pour les nouveau-nés atteints d'hyperbilirubinémie.
- Transfusions intra-utérines : Pour les cas sévères d'anémie fœtale.
- Échanges transfusionnels : Chez le nouveau-né si nécessaire.

Patient, ancien toxicomane, qui consulte pour des dorsalgie. Douleur vive à la palpation en regard de L4. Etat fébrile. Quel germe en est la cause ?

- A. S. aureus
 - B. S. epidermidis
 - C. S. gallolyticus
 - D. Mycobacterium tuberculosis
- Pour un patient, ancien toxicomane, qui consulte pour des dorsalgies avec douleur vive à la palpation en regard de L4 et état fébrile, le germe le plus probable responsable de cette infection est Staphylococcus aureus (S. aureus).
 - Staphylococcus aureus est le pathogène le plus fréquemment impliqué dans les cas d'ostéomyélite vertébrale (Spondylite), notamment chez les individus qui utilisent des drogues par voie intraveineuse (IV).
 - Les autres pathogènes comme S. epidermidis et Mycobacterium tuberculosis sont également des causes possibles, mais S. aureus reste le plus commun dans ce contexte.

- 1. Enfants
 - Principal mode de propagation : Hématogène (endogène)
 - Description : La bactérie se propage par la circulation sanguine à partir d'une infection distante.
 - Âge le plus affecté : Moins de 5 ans
 - Os les plus touchés : Métaphyses des os longs (fémur, tibia, humérus)
 - Pathogènes courants :
 - Staphylococcus aureus
 - Streptocoque du groupe A
 - Kingella kingae (enfants < 5 ans)
- 2. Adultes
 - Principal mode de propagation : Exogène
 - Description : La bactérie se propage à partir de tissus environnants ou à la suite d'un traumatisme.
 - Types de propagation :
 - Post-traumatique : Infection suite à une blessure profonde (fractures ouvertes, blessures sévères des tissus mous)
 - Contiguë : Propagation d'une infection des tissus adjacents
 - Ulcère du pied chez les patients diabétiques
 - Infection postopératoire d'une prothèse articulaire

L'Ostéomyélite est une infection de l'os, résultant soit d'une propagation hématogène (à partir d'une source éloignée), soit d'une propagation exogène (à partir de tissus adjacents). Elle est le plus souvent causée par Staphylococcus aureus. Les personnes présentant un risque accru d'ostéomyélite incluent celles ayant subi un traumatisme, une pose d'implants chirurgicaux, ou celles immunodéprimées ou ayant une mauvaise perfusion tissulaire.

Modes de propagation :

- Hématogène : Propagation à partir d'une infection à distance.
- Exogène : Propagation à partir de tissus environnants infectés.

Facteurs de risque :

- Traumatisme
- Implants chirurgicaux
- Immunosuppression
- Mauvaise perfusion tissulaire

Formes et Manifestations

- Formes : Peut être aiguë ou chronique.
- Signes locaux : Inflammation locale, y compris gonflement, douleur, rougeur et chaleur.
- Signes systémiques : Plus fréquents dans les infections aiguës, incluant fièvre et frissons.

- Diagnostic**
- Basé sur des tests de laboratoire, l'imagerie et/ou la biopsie.
 - La thérapie antibiotique empirique est réservée aux patients présentant des signes de sepsis ou des infections rapidement évolutives.

- Traitement**
- Antibiotiques : Généralement retardés jusqu'à l'obtention des résultats des cultures pour mieux adapter le traitement.
 - Chirurgie : Peut être nécessaire pour enlever l'os nécrotique, les abcès, les corps étrangers infectés ou les fistules.

Les adultes ont souvent une évolution chronique nécessitant un traitement prolongé, tandis que les enfants se rétablissent généralement rapidement et complètement.

(K') Patient auquel on a enlevé un cancer dans la bouche, avec métastases à 2 ganglions du même côté de la lésion. Le tumor-board suggère une radiothérapie. Quels effets secondaires?

- A. mucite
- B. hypersialorrhée
- C. risque de caries
- D. Lymphoedeme cervical

- Les effets secondaires de la radiothérapie pour un patient ayant subi une ablation d'un cancer buccal et présentant des métastases ganglionnaires incluent :
- A. Mucite** (Inflammation et ulcération des muqueuses buccales)
 - Symptômes : Douleur, rougeur, et ulcères dans la bouche, ce qui peut rendre l'alimentation difficile.
 - Fréquence : Très courante chez les patients recevant une radiothérapie dans la région de la tête et du cou.
 - C. Risque de caries** (Augmentation du risque de caries dentaires)
 - Cause : La radiothérapie peut endommager les glandes salivaires, réduisant la production de salive et augmentant le risque de caries.
 - Symptômes : Sécheresse buccale (xérostomie), sensibilité dentaire, et développement accru de caries.
 - D. Lymphoedème cervical** (Accumulation de liquide lymphatique dans le cou)
 - Cause : Dommages aux ganglions lymphatiques et aux canaux lymphatiques pendant la radiothérapie.
 - Symptômes : Gonflement, sensation de lourdeur, et douleur dans le cou.

Effets secondaires de la radiothérapie

Les effets secondaires de la radiothérapie sont généralement localisés à la zone traitée. Voici quelques complications courantes :

- **Lésions pulmonaires** induites par les radiations
 - Pneumonite radique
 - Fibrose pulmonaire induite par les radiations
- **Maladies cardiaques** induites par les radiations
- **Œsophagite radique**
- **Entérite radique**
 - Entérite radique aiguë
 - Entérite radique chronique
- **Proctite radique**
 - Proctite radique aiguë
 - Proctite radique chronique
- **Cystite radique**
 - Cystite radique aiguë
 - Cystite hémorragique radique

Effets secondaires spécifiques

- **Œsophagite radique**
 - **Début** : généralement 2 à 3 semaines après le début de la radiothérapie
 - **Symptômes** : dysphagie, odynophagie, anorexie, nausée, inconfort rétrosternal
 - **Complications** : sténose œsophagienne, perforation œsophagienne, fistule trachéo-œsophagienne
2. **Entérite radique**
 - **Aiguë** :
 - **Début** : heures à semaines après la radiothérapie
 - **Symptômes** : nausée, vomissement, diarrhée, douleur abdominale, perte de poids
 - **Chronique** :
 - **Début** : mois à années après la radiothérapie
 - **Symptômes** : diarrhée, malabsorption, ulcérations, sténoses, fistules, obstruction intestinale, perforation
3. **Proctite radique**
 - **Aiguë** :
 - **Début** : 0 à 3 mois après la radiothérapie
 - **Symptômes** : douleur rectale, diarrhée, ténisme, écoulement de mucus, saignement mineur
 - **Chronique** :
 - **Début** : 3 mois à années après la radiothérapie
 - **Symptômes** : caractéristiques de la proctite radique aiguë, sténoses intestinales, fistules, obstruction, perforation, saignement (potentiellement mortel)

Cas particulier : Cancer du col de l'utérus invasif

- **Complications de la radiothérapie** :
 - Sténose vaginale
 - Vaginite post-irradiation (sécheresse vaginale, dyspareunie)
 - Cystite/proctite radique
 - Augmentation du risque de formation de fistules

Gestion et prévention

- Les effets secondaires peuvent nécessiter des modifications alimentaires, des soins de soutien, des traitements symptomatiques, et parfois l'arrêt de la radiothérapie en cas de symptômes sévères.
- Des interventions médicales et chirurgicales spécifiques peuvent être nécessaires pour gérer les complications chroniques comme les strictures ou les fistules.

- **Os les plus touchés** : Vertèbres chez les patients adultes avec ostéomyélite vertébrale en augmentation.

Facteurs de risque communs

1. **Enfants** : Bactériémie, immunodéficience, drépanocytose
2. **Adultes** : Immunosuppression, diabète, utilisation de drogues IV, traumatismes

Pathogènes courants

- **Commun à tous les âges** : Staphylococcus aureus (le plus fréquent)
- **Spécifiques aux groupes** :
 1. **Enfants** : Streptococcus du groupe A, Kingella kingae
 2. **Adultes** : Pathogènes exogènes multiples, souvent nosocomiaux

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019)

COVID-19 est une maladie infectieuse aiguë causée par le coronavirus SARS-CoV-2. La transmission se fait principalement par l'exposition aux fluides respiratoires. La période d'incubation varie de 2 à 14 jours, et peut être plus courte avec les nouveaux variants.

Symptômes

- Fatigue
- Fièvre
- Symptômes d'infection des voies respiratoires supérieures (ex. toux sèche, dyspnée)

Certains individus peuvent être asymptomatiques. La gravité de la maladie varie d'une infection asymptomatique à une maladie légère avec peu de symptômes, jusqu'à des complications sévères telles que :

- Pneumonie
- Syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)
- Choc
- Dysfonctionnement d'organes

Diagnostic

La confirmation du diagnostic se fait par des tests de dépistage de la COVID-19, incluant :

- Tests de amplification des acides nucléiques (ex. PCR)
- Tests antigéniques sur un échantillon respiratoire

Les résultats d'imagerie ne sont pas spécifiques et ressemblent à ceux d'autres infections respiratoires virales. Ils ne doivent pas être utilisés pour confirmer le diagnostic de COVID-19.

Traitement

- Les cas légers peuvent généralement être gérés par des soins de soutien à domicile.
- La pharmacothérapie peut être envisagée pour les patients en consultation externe ayant des facteurs de risque de progression vers une forme sévère de la COVID-19.
- Les patients atteints de COVID-19 modéré ou sévère, ou ceux présentant des facteurs de risque de maladie sévère, peuvent nécessiter une hospitalisation pour une oxygénothérapie, une pharmacothérapie et une thérapie antithrombotique.

Prévention

Pour réduire le risque d'infection, plusieurs mesures préventives sont recommandées :

- Vaccination
- Mesures de santé publique (ex. distanciation sociale, port du masque)
- Test après un contact étroit avec des personnes infectées

Prise en Charge de la COVID-19

Principes Généraux

Pour les patients atteints de COVID-19 modéré à sévère nécessitant une hospitalisation, les principes généraux de prise en charge incluent :

- Détermination des objectifs de soins et obtention des directives anticipées, si disponibles.
- Évaluation de la gravité de la maladie et admission des patients au niveau de soins approprié.
- Adaptation des diagnostics supplémentaires (études de laboratoire, imagerie) en fonction de la présentation clinique.

Examens de Laboratoire

Les paramètres de laboratoire dans la COVID-19 ne sont pas spécifiques mais sont utiles pour évaluer la dysfonction organique.

- **Études de routine :**
 - NFS : peut montrer une lymphopénie, une thrombocytopénie.
 - Panel métabolique de base : créatinine sérique élevée en cas d'insuffisance rénale aiguë, anomalies possibles des électrolytes.
 - Chimie hépatique : peut montrer une augmentation des ALT et AST.
- **Évaluations supplémentaires selon la présentation clinique :**
 - Marqueurs inflammatoires : augmentation de la CRP, de la ferritine, de la LDH.
 - Études de coagulation : augmentation du temps de prothrombine, du D-dimère.
 - Enzymes cardiaques : augmentation de la troponine et du NT-proBNP peut indiquer une lésion cardiaque liée à la COVID-19.
 - Gaz du sang artériel : peut révéler une insuffisance respiratoire hypoxémique.
 - Hémocultures : à effectuer si une co-infection bactérienne est suspectée.

Imagerie Thoracique

Les indications pour l'imagerie thoracique incluent des caractéristiques de la COVID-19 modérée ou sévère, une aggravation de l'état respiratoire et des patients présentant des facteurs de risque de progression vers une forme sévère.

- **Modalités :** radiographie thoracique, échographie thoracique et TDM thoracique.
- **Considération importante :** les résultats d'imagerie dans la COVID-19 sont généralement non spécifiques et ressemblent à ceux d'autres infections respiratoires virales.

Thérapie de Soutien

- Thérapie par fluides intraveineux selon les besoins.
- Vasopresseurs au besoin (ex. : norépinéphrine en première ligne).
- Antipyrétiques et analgésiques selon les besoins (ex. : acétaminophène, ibuprofène).
- Antitussifs au besoin (ex. : benzonatate).
- En cas d'insuffisance rénale aiguë nécessitant une dialyse, la thérapie continue de remplacement rénal est préférée à l'hémodialyse.

Thérapie à l'Oxygène

Objectif : maintenir les niveaux de SpO₂ entre 92–96% (≥ 95% chez les femmes enceintes).

Canule nasale à haut débit : indiquée en cas d'insuffisance respiratoire hypoxémique malgré l'utilisation de systèmes de délivrance d'oxygène de base.

- **Ventilation mécanique :**
 - Indications : voir "Indications pour la ventilation mécanique invasive".
 - Réglages recommandés pour les patients atteints de COVID-19 et de SDRA : volume courant de 4–8 mL/kg de poids corporel prédictif, pression plateau < 30 cm H₂O, ventilation en position de décubitus ventral 12–16 heures/jour, PEEP élevé (> 10 cm H₂O).
 - **Oxygénothérapie extracorporelle (ECMO)** : il n'y a pas suffisamment de preuves pour recommander ou déconseiller l'utilisation de l'ECMO chez les patients atteints de COVID-19 et d'hypoxémie réfractaire.

Pharmacothérapie

La pharmacothérapie pour les patients hospitalisés atteints de COVID-19 varie selon la gravité de la maladie et comprend des options telles que le remdesivir, la dexaméthasone et d'autres immunomodulateurs.

- **Dexaméthasone :**
 - Utilisée pour réduire la réponse inflammatoire causée par la COVID-19.
 - Recommandée pour les patients nécessitant une oxygénothérapie ou une ventilation mécanique.
- **Régimes de pharmacothérapie selon la sévérité de la maladie :**
 - Pas besoin d'oxygénothérapie : envisager le remdesivir pour les patients à haut risque de progression de la maladie.
 - Besoin d'oxygénothérapie : remdesivir, dexaméthasone, ou combinaison des deux ; ajouter baricitinib ou tocilizumab pour les patients avec augmentation rapide des besoins en oxygène et inflammation systémique.
 - Besoin de ventilation à haut débit ou non invasive : dexaméthasone seule ou avec remdesivir.
 - Besoin de ventilation mécanique ou ECMO : dexaméthasone, ajouter tocilizumab si le patient est en USI depuis ≤ 24 heures.

Thérapie Antithrombotique

Pour tous les patients hospitalisés qui n'ont pas de contre-indications à l'anticoagulation. L'énoxaparine ou l'héparine non fractionnée sont préférées aux anticoagulants oraux.

(Q ancrage) Femme de 92 ans avec baisse état générale et état confusionnel qui vient à l'hôpital pour fièvre, rhinorrhée. Auscultation pulmonaire calme. Sat 92%. Frottis sars-cov2 négatif et frottis grippe positif que faire ?

Pour une femme de 92 ans qui présente des symptômes de grippe confirmée, tels que la fièvre, la rhinorrhée et une baisse de l'état général avec confusion, il est important de traiter rapidement en raison de son âge avancé et de ses risques élevés de complications. Voici les étapes recommandées :

Thérapie Antivirale

1. Indication pour une thérapie antivirale :
 - Hospitalisation nécessaire
 - Risque élevé de complications de la grippe
2. Options de traitement :
 - Oseltamivir (Tamiflu) :
 - Dosage :
 - Adultes (y compris les personnes âgées) : 75 mg deux fois par jour pendant 5 jours
 - En cas de troubles rénaux, ajuster la dose selon la fonction rénale.
 - Zanamivir :
 - Inhalé, pour les patients qui ne peuvent pas prendre Oseltamivir.

Mesures de soutien

- Hydratation orale : Assurer une bonne hydratation pour éviter la déshydratation.
- Antipyrétiques : Utiliser du paracétamol ou de l'ibuprofène pour réduire la fièvre et soulager les douleurs.
- Antitussifs : En cas de toux sèche et non productive, envisager des antitussifs appropriés.

Surveillance

- Température corporelle
- Saturation en oxygène
- État de conscience et confusion
- État hydrique et nutritionnel

Mesures d'isolement

- Isolement : Maintenir l'isolement du patient pour prévenir la propagation de l'infection.

Conclusion

- La prochaine étape appropriée pour cette patiente serait de commencer Oseltamivir (réponse C), un antiviral efficace contre la grippe, en particulier pour les patients hospitalisés ou présentant des formes sévères de la maladie.

Grippe (Influenza)

Résumé

La grippe est une infection virale hautement contagieuse qui survient principalement pendant les mois d'hiver. Elle est causée par les virus de la grippe A, B et C. Les sous-types des virus de la grippe A sont classés en fonction de leurs antigènes de surface, l'hémagglutinine (H) et la neuraminidase (N). Les virus de la grippe mutent fréquemment, entraînant l'apparition de nouveaux sous-types et souches.



- Symptômes**
- Début soudain de forte fièvre
 - Céphalées
 - Myalgies (douleurs musculaires)
 - Arthralgies (douleurs articulaires)
 - Toux non productive
 - Malaise général
- Diagnostic**
- Basé sur la présentation clinique
 - Confirmation possible par test PCR
- Traitement**
- Les symptômes sont généralement autolimités et le traitement de soutien est suffisant.
 - Thérapie antivirale envisagée pour les patients présentant une maladie précoce ou sévère, en particulier ceux à haut risque de complications.
 - La thérapie antivirale peut réduire la gravité et la durée des symptômes et le risque de complications.
- Complications**
- Rarement, pneumonie bactérienne secondaire, le plus souvent causée par *Staphylococcus aureus* ou *Streptococcus pneumoniae*.
- Prévention**
- Hygiène des mains
 - Hygiène respiratoire
 - Vaccination

- Autres options proposées incorrectes :**
- A. Rien**
- Explication : Ne rien faire n'est pas approprié dans ce contexte. La patiente présente une infection grippale confirmée avec des symptômes sévères (fièvre, confusion) et un âge avancé, ce qui la place à un risque élevé de complications. Une intervention est nécessaire pour réduire la gravité des symptômes et prévenir les complications potentielles.
 - Conclusion : Option incorrecte car la patiente a besoin d'un traitement antiviral et de soutien.
- B. Remdesivir**
- Explication : Remdesivir est un antiviral utilisé principalement pour traiter le COVID-19. Il n'est pas indiqué pour la grippe.
 - Conclusion : Option incorrecte car ce médicament n'est pas utilisé pour traiter la grippe.

- D. Co-amoxiclav (Amoxicilline/Clavulanate)**
- Explication : Co-amoxiclav est un antibiotique utilisé pour traiter les infections bactériennes. La patiente a une infection virale (grippe), et les antibiotiques ne sont pas efficaces contre les virus. Toutefois, ils peuvent être utilisés en cas de surinfection bactérienne secondaire, ce qui n'est pas indiqué dans ce cas particulier.
 - Conclusion : Faux car aucun signe de surinfection bactérienne.
- E. Ceftriaxone**
- Explication : Ceftriaxone est un antibiotique de la classe des céphalosporines, utilisé pour traiter les infections bactériennes. Comme pour le Co-amoxiclav, il n'est pas efficace contre les virus et n'est donc pas approprié pour traiter la grippe, sauf en cas de surinfection bactérienne.
 - Conclusion : Faux car il n'y a aucune indication de surinfection bactérienne.

Réponse C (A? si >2jours qu'elle a symptomes alors on fait rien non?)

Patiente de 62 ans traitée pour une HTA avec IEC et qui prend du lithium depuis 3 ans pour troubles humeurs. Elle se plaint de tremblements au repos qui l'embêtent avec maladresse et lâchage d'objets, que faire:

- A. Faire TT avec Levodopa pour voir si c'est un parkinson
- B. Changer IEC pour autre anti-hypertenseur
- C. Donner des BB pour agir sur le tremblement en central
- D. Donner un diurétique thiazidiques pour augmenter l'excrétion de lithium
- E. Doser lithémie et adapter la posologie en fonction

La patiente présente des tremblements au repos, ce qui peut être un **effet secondaire du lithium**. Voici les options disponibles et leur analyse en fonction des informations extraites :

- A. Faire TT avec Levodopa pour voir si c'est un parkinson :**
- Le tremblement lié au lithium est généralement un tremblement fin, non progressif et symétrique, plutôt qu'un tremblement de repos typique de la maladie de Parkinson. L'utilisation de Levodopa serait donc inappropriée dans ce contexte.
- B. Changer IEC pour autre anti-hypertenseur :**
- Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (IEC) peuvent réduire l'excrétion rénale de lithium, augmentant ainsi le risque de toxicité. Cependant, cela n'adresse pas directement le problème des tremblements.
- C. Donner des BB pour agir sur le tremblement en central :**
- Les bêta-bloquants, comme le propranolol, peuvent être efficaces pour traiter les tremblements liés au lithium s'ils sont persistants ou sévères. C'est une option valable pour soulager les symptômes de tremblement.
- D. Donner un diurétique thiazidique pour augmenter l'excrétion de lithium :**
- Les diurétiques thiazidiques peuvent en réalité augmenter la réabsorption rénale de lithium, augmentant ainsi les niveaux de lithium et le risque de toxicité. Cette option est donc contre-indiquée.
- E. Doser lithémie et adapter la posologie en fonction :**
- Mesurer le taux de lithium sérique et ajuster la posologie est essentiel pour maintenir les niveaux dans la plage thérapeutique et prévenir les effets secondaires, y compris les tremblements.

- B. Lever la jambe et comprimer
- C. Mettre du froid et attendre
- D. Donner fibrinogène
- E. Transfuser un culot érythrocytaire

Réponse : A

Homme qui se fait opérer d'une PTH et qui a quelques temps après des douleurs au mollet et mollet tendu, que faire ?

- A. Rechercher une thrombose veineuse profonde
- B. Antalgie et contrôle dans 1 semaine
- C. Antalgie et contrôle dans 48h
- D. Prescription de bas de contention

Rép: A

Monsieur de x ans sous traitement de statine depuis de nombreuses années qui développe une faiblesse musculaire ainsi qu'un érythème liliacé au niveau des paupières. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Dermatomyosite
- B. Myopathies induites par les statine
- C. Polymyosite
- D. Sclérodermie

Réponse : A

(Q ancrage) Un ouvrier agricole de 45 ans remplit la remorque de son tracteur de produit phytosanitaire dans un local fermé. Il se présente avec dyspnée, TA 100/60, FC 50, salivation abondante, pupilles légèrement dilatées, PeC K' :

- A. **Atropine**
- B. Naloxone
- C. Flumazenil
- D. Physostigmine

Symptômes du syndrome cholinergique

- **Muscariniques :**
 - Bradycardie
 - Hypotension
 - Bronchospasme et bronchorrhée
 - Salivation excessive, larmoiement
 - Diarrhée, vomissements, douleurs abdominales
 - Miosis (constriction des pupilles)
- **Nicotiniques :**
 - Faiblesse musculaire et fasciculations
 - Hypertension et tachycardie initiale suivie de bradycardie
 - Crampes abdominales

Prise en charge

- Atropine : Antagoniste des récepteurs muscariniques, utilisé pour contre les effets muscariniques du syndrome cholinergique.
- Pralidoxime (2-PAM) : Réactive l'acétylcholinestérase inhibée par les organophosphorés, utile surtout en cas de symptômes nicotiques.

L'ouvrier agricole présente des symptômes compatibles avec une **intoxication aux organophosphorés**, un type de produit phytosanitaire. Les signes cliniques incluent dyspnée, hypotension (TA 100/60), bradycardie (FC 50), salivation abondante et mydriase légère, qui sont tous typiques de ce type d'intoxication.

Justification

Atropine : C'est l'antidote de choix pour les intoxications par les organophosphorés. Elle agit en antagonisant les effets muscariniques de l'acétylcholine en excès.

Réponses possibles:

A. Atropine : Correct.

B. Naloxone : Incorrect. Utilisé pour les intoxications aux opioïdes.

C. Flumazenil : Incorrect. Utilisé pour les intoxications aux benzodiazépines.

D. Physostigmine : Incorrect. Utilisé pour les intoxications anticholinergiques, il pourrait aggraver la situation dans le cas d'une intoxication aux organophosphorés.

Homme d'affaires de 40 qui revient d'Inde avec des diarrhées aqueuses depuis 3 jours (elles ont débuté le dernier jour de son séjour). Il a commencé hier traité AB (Ciprofloxacine) sans effet. Bien hydraté et bon état général, afebrile. Que faites-vous ?

- A. Suivi clinique
- B. Examen des bactéries dans les selles
- C. Examen des virus dans les selles
- D. Examen des parasites dans les selles
- E. Hospitalisation

La diarrhée du voyageur est généralement causée par des bactéries, des virus ou des parasites.

Les antibiotiques comme la ciprofloxacine sont réservés aux cas modérés à sévères et peuvent ne pas être efficaces si la souche bactérienne est résistante.

La gestion initiale se concentre principalement sur le maintien de l'hydratation et le suivi clinique.

Le patient présente une diarrhée aqueuse non compliquée sans signes de gravité (pas de fièvre, pas de déshydratation sévère, bon état général).

La ciprofloxacine a été commencée sans effet, ce qui suggère soit une résistance bactérienne, soit une étiologie non bactérienne.

Dans de tels cas, il est recommandé de continuer le suivi clinique pour surveiller l'évolution des symptômes.

Les examens des selles (B, C, D) peuvent être envisagés si les symptômes persistent au-delà de 7 jours ou si des signes de gravité apparaissent.

Réponse : A

Gars de x ans qui est en vacances en Inde et qui a un accident de la route, première prise en charge la bas dans un hôpital puis rapatriement en suisse, Quel germe peut-il être porteur et faut-il faire attention?

- A. M. Tuberculose
- B. ESBL
- C. Clostridium difficile
- D. Neisseria Meningitis

Pour un patient hospitalisé en Inde après un accident de la route et ensuite rapatrié en Suisse, il y a plusieurs germes auxquels il peut être exposé. Parmi les options fournies, ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) est une possibilité importante à considérer. Voici un résumé des infections nosocomiales et des agents pathogènes courants dans les hôpitaux :

ESBL (Extended-Spectrum Beta-Lactamase) :

Les bactéries productrices d'ESBL, telles que certaines souches d'E. coli et de Klebsiella, sont courantes dans les hôpitaux et peuvent causer des infections urinaires, des infections du site opératoire, et des pneumonies nosocomiales. Les infections par ESBL sont de plus en plus fréquentes en raison de la résistance aux antibiotiques.

Clostridium difficile :

Ce germe peut causer des infections gastro-intestinales, notamment après une utilisation récente d'antibiotiques qui altèrent la flore intestinale normale.

Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (MRSA) :

Causant des infections du site opératoire, des pneumonies nosocomiales, et des infections sanguines.

Pseudomonas aeruginosa :

Souvent impliqué dans les infections des voies respiratoires et urinaires ainsi que dans les infections du site opératoire.

En conclusion, ESBL (B) est une réponse probable compte tenu de l'exposition hospitalière en Inde, où les infections par des organismes résistants aux antibiotiques, comme les producteurs d'ESBL, sont courantes.

Réponse B plutot

Homme qui vient avec hématome dans le dos, maltraitance par conjointe mais veux pas porter plainte que faire?

- A. Lui conseiller d'aller dans centre aide au victime
- B. L'orienter vers la médecine forensique
- C. Déclarer le cas au médecin cantonal
- D. L'inciter à déposer plainte à la police

Réponse A (les constats se font aussi aux centres d'aide aux victimes?) (B pour faire un constat médico légal? j'ai mis B aussi +3. dans les cours ils disaient qu'il fallait toujours faire le constat au cas où il voudrait porter plainte par la suite, donc B je pense) Mais pas besoin des médecins forensiques pour faire le constat non ?

IRA post-rénale (HBP) --> Globe

Homme traité pour HTA avec hyperplasie de la prostate et diabète traité par Metformine qui est anurique depuis 48h, HTA, et autre choses (en gros IRA) + tableau d'IC décompensée (non?). Râles bi-basaux, oedèmes MI, douleurs abdominales diffuses.

Au niveau du labo il y a :

Natrémie 135

Kaliémie à 5.5

Creat augmentée à > 300

Urée augmentée à 22

Glycémie à 10

Que faire en premier:

- A. US des voies urinaires
- B. Donner insuline + glucose
- C. Traitement par Lasix IV
- D. Perfusion NaCl 0.9%
- E. Dialyse

Réponse : C (chez un patient âgé avec une hyperplasie de la prostate, et des douleurs abdo diffuses, il ne faudrait pas faire un US pour exclure un globe ? +3) +1 → A

Je me dis que le diagnostic a priori on sait ce que c'est (HBP) même s'il faudra confirmer mais en gros c'est pas ce qu'il y a de plus urgent, surtout que c'est un truc chronique, qui décompense. Lasix plutôt pas parce que si c'est postrénal on va ajouter encore du liquide alors que c'est obstrué. Donc à mon avis le traitement c'est une sonde (après avoir fait un US

éventuellement) mais dans l'urgence il faut baisser la kaliémie -> B (L'insuffisance rénale s'est un des critères de gravité de traitement de l'hyperkaliémie)

Une femme enceinte de 12 (?) SA, vient toute inquiète car son premier enfant a attrapé la varicelle à l'école. Que lui conseillez-vous?

- A. Sérologies en urgences
- B. Administrer immunoglobulines
- C. Rassurer la patiente
- D. Isoler la patiente de son enfant

Réponse: ? si a déjà eu varicelle alors rassurer, sinon sérologie en urgence pour voir si besoin d'Ig.

Si on est pas sur de son anamnèse de varicelle je lui donnerai d'office les Ig -> B

A

(Q ancrage) Patient jeune, vient pour un ictère suite à état grippal il y a une semaine.

Bili totale augmentée.

Bili directe légèrement augmentée.

De quoi souffre-t-il?

- A. Syndrome de Dubin-Johnson
- B. Syndrome de Gilbert
- C. Cirrhose hépatique
- D. Hépatite aiguë
- E. Syndrome de Wilson

Réponse : B

(Question d'ancrage) Garçon de 4 ans qui ne veut plus courir ni manger depuis ce matin. Hier il était encore en bonne santé. VS et leucocytes dans la norme. Rotation de la hanche limitée.

Petit épanchement noté au sein de l'articulation :

- A. Synovite aigue transitoire de la hanche
- B. Legg calvé Perthes
- C. épiphysiolyse de la tête du fémur
- D. Arthrite septique

Réponse A (=rhume de la hanche = coxitis fugax)

Patient de 40 ans souffre d'HTA malgré la mise en place d'une trithérapie. Créatinine légèrement augmentée depuis le dernier contrôle. Prochaine étape :

- A. Echographie Doppler Duplex de l'abdomen
- B. Angio-IRM
- C. Angio-CT

Réponse : A

Femme revenant de vacances avec diarrhée aqueuse et vomissements depuis 3 jours, pas de sang dans les selles, Dg le plus probable :

- A. Enterotoxigène Escherichia Coli (ETEC)
- B. Salmonella typhi

...

Rép A

Patiente de 41 ans qui a eu une opération de Whipple pour cancer pancréatique (résection seulement de la tête du pancréas) qui se plaint depuis plusieurs temps de selles et flatulences, météorisme abdominal et sensation de réplétion. Test de l'élastase dans les selles négatif. C'est quoi ?

- A. Intolérance lactose
- B. Coeliakie nouvelle
- C. Syndrome de l'intestin irritable
- D. Insuffisance pancréatique exocrine
- E. Colonisation bactérienne anormale de l'intestin grêle

Réponse : E (syndrome de l'anse borgne)

4. Une maman vous consulte avec son garçon de 2.5 ans. Elle est inquiète car elle trouve qu'il est en retard par rapport à son cousin. Il n'est pas encore propre. Elle a une liste résumant son développement:

- Sourit à 6 semaines
- Fixe à 2 mois
- Tient assis à 7 mois
- Pince fine à 9 mois
- Tient debout avec appui à 11 mois
- Premiers mots à 12 mois
- Premiers pas à 13 mois
- Shooté dans un ballon à 24 mois

Que dites-vous à cette maman?

- A. Le développement de son enfant est normal
- B. Son enfance présente un retard sur le plan moteur
- C. Son enfant présente un retard sur le plan cognitif
- D. Son enfant présente un retard sur le plan langagier
- E. Son enfant présente un retard sur plusieurs domaines

Réponse A

(Q ancrage) Un patient de 62 ans, connu pour une BPCO et un carcinome pulmonaire à petites cellules traité par chimiothérapie palliative, se présente pour un état fébrile une semaine après sa dernière cure. Il présente une dyspnée associée. Au status, on retrouve un état fébrile à 39°C, une fréquence cardiaque à 115/min et une tension artérielle à 90/70,

également une fréquence respiratoire à 22/min. Le laboratoire montre des leucocytes à 1.1G/l, dont 0.15 neutrophiles, une CRP à 90 mg/l. Des hémocultures sont en cours.

Quelle est la prise en charge la plus appropriée?

- A. Fébrifuges et contrôle ambulatoire à 24h
- B. Fébrifuges et hospitalisation pour surveillance
- C. Amoxicilline-clavulanate p.o. et contrôle ambulatoire
- D. Amoxicilline-clavulanate en i.v. et hospitalisation pour surveillance
- E. Céfépime en i.v. et hospitalisation pour surveillance

Réponse E

Une mère se dit inquiète pour son fils de 18 ans. Il a perdu sa copine dans un accident. Depuis quelque temps, ses notes scolaires ont chuté, il a abandonné ses hobbies et ne rencontre plus ses collègues. Parfois, elle l'entend parler tout seul dans sa chambre et faire des dessins sur les murs. Quel est le diagnostic le plus probable ?

- a) Premier épisode psychotique
- b) Episode dépressif
- c) Trouble de l'adaptation
- d) Trouble bipolaire
- e) Deuil normal

Réponse A

BB de 22 jours avec croûte jaunâtre qui desquame à côté du nombril. Le lendemain, extension de l'exanthème sur tout le corps qui bulle et pèle. c'est quoi ?

- A. Impetigo
- B. SSSS
- C. SJS
- D. Choc toxique

Réponse B

Homme de 56 ans connu pour cirrhose éthylique CHILD A6 est traité avec les médicaments suivants :

- spironolactone 1 000mg/d,
- Pantoprazole 80mg/j,
- Torasémide 40mg/j,
- Propanolol 80mg LAid,
- Disulfiram 400mg 3 fois par semaine.

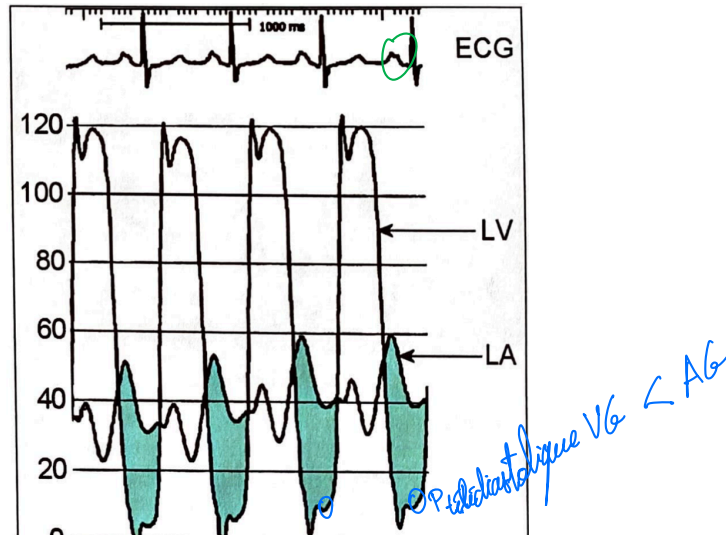
Après une évolution stable au cours des 6 derniers mois, le patient présente actuellement un gonflement des deux seins. Lors de l'examen il existe une tuméfaction bilatérale symétrique, indolore et mobile du tissu de la glande mammaire. Quel médicament en est responsable ?

- a) le propanolol
- b) Pantoprazole

- c) la spironolactone
- d) le torasémide
- e) le disulfirame

Réponse C

Jeune patient qui vient aux urgences. Il a une turgescence jugulaire et des crépitaux bi-basaux (signe de surcharge). Vous entendez un bruit en B1 très fort mais vous n'êtes pas sûr d'entendre un souffle. Votre CDC vous montre ça, c'est quoi ?



- A. Communication interventriculaire
- B. Sténose mitrale
- C. Insuffisance tricuspideenne
- D. Sténose aortique
- E. Péricardite constrictive

Réponse B (Il a une P mitrale à l'ECG)

Jeune femme avec nouveau partenaire sexuel qui a eu rapport non protégé il y a 10 jours et depuis a de symptômes.

Chlamydia +

Gono +

Test VIH négatif

VDRL 1:320 (normal négatif)

Serologies hépatites: anti-HBs hauts, anti-HBc négatifs

Que faire en premier?

- A. Prep VIH
- B. PEP VIH
- C. Ceftriaxone et azithro
- D. Pénicilline IM
- E. truc pour hépatite

Réponse C

(est-ce que on donne pas la PEP VIH malgré un test négatif vu qu'on est pas à 3 mois post RSNP ? Ou est-ce qu'on joue juste sur le "à faire en 1er ?")

51. (Question d'ancrage) Un patient de 66 ans, par ailleurs en bonne santé, souffrant de dysfonctionnement érectile. Il a des relations sexuelles régulières et souhaite avoir une puissance plus fiable. Quel medic est une CI avant de prescrire le sildénafil ?

- A. Dinitrate d'isosorbide
- B. Statines
- C. Metoprolol
- D. Aspirine
- E. lisinopril

Réponse A

On veut faire une intervention pour **prévention CV** chez les < 40 ans mais pas assez de moula pour faire pour tout le monde donc c'est mieux qu'on intervienne chez qui par rapport aux **conditions démographiques et professionnelles**?

- A. Cadres dans entreprise
- B. Femmes au foyer
- C. Travailleurs non qualifiés
- D. Étudiants universitaires
- E. Femmes travaillant dans l'administration

Rép: C (+2), A ??: age + avancé, plus hommes, et stress? un niveau socio-éco bas est un FRCV

(k') Homme qui a fait une chute à vélo et s'est tapé le côté de la tête. Il a une diminution de sensibilité sur le front et sous l'œil et il peut plus lever l'œil. C'est tout tuméfié donc on peut pas palper. hématome en monocle. Quel os pourrait être cassé ?

- A. Plancher orbite
- B. Toit orbite
- C. Os frontal
- D. Os zygomatique

Rép : -/+/-/+ (+1) ? +-+ je pense (+2) ++++ (tous ces os forment la cavité orbitaire) ou +--+ (fracture du plancher de l'orbite qui est formée par la zygomatique entre autre) (plancher ferait surtout diplopie et endophtalmie je pense)

(Q ancrage) Patients en soins intensifs, se plaignent après quelques jours de démangeaisons, surtout interdigitales et inguinales. De nombreux soignants et autres patients sont également concernés. Quelle est la cause la plus probable :

- A. Gale
- B. Teigne
- C. Impétigo
- D. ?

E. ?

Réponse : A

Femme qui a infection UG et qui a douleur dans une articulation qui est rouge et chaude, plus douleur pour uriner et conjonctivite que faire pour diagnostiquer ?

- A. Ponction articulaire
- B. Frottis urétral

Réponse : B

(Q ancrage) Homme en surpoids de 40 ans qui est connu pour un diabète TT par metformine + insuline et une HTA résistante. Il n'arrive pas à faire baisser sa TA, son médecin lui conseille de faire du sport et il fait un jogging de 45 min a la suite duquel il a une PC de quelques minutes puis est amené à l'hôpital. Cause la plus probable ?

- A. Vasovagale
- B. Hypoglycémie
- C. Déshydratation
- D. Cardiaque

Réponse : B

(Question d'ancrage) Homme de 60 ans, connu depuis 6 ans pour des épilepsies généralisées tonico-clonique suite à un TCC sur accident de voiture traitement avec valproate qui est hospitalisé pour crise. Actuellement, il se trouve depuis 3 jours à l'hôpital pour une pneumonie, traitée par Co-amoxicilline. Dans les dernières 4 heures, il a eu 2 crises tonico-cloniques résolues et maintenant il est en état de mal depuis 20 min avec EEG qui le montre. Que faire ?

- A. Attendre que la crise passe, puis adapter le traitement
- B. Donner midazolam (je crois c'était du diazépam?) et phénytoïne IV
- C. Donner une dose supplémentaire de valproate
- D. CT cérébral injecté
- E. Stop antibiotique et attendre

Réponse : B

Jeune femme avec tache de naissance dont le grand mère est morte d'une melanome a peur aussi. Que faire?

- A. Préciser atopie
- B. Préciser coup de soleil dans l'enfance
- C. Préciser tabac

Réponse : B, C (le tabagisme empire le pronostic du melanome)
Même si c'est une tache de NAISSANCE?

Jeune pharmacien/droguiste de 19 ans (lol) qui dit qu'il a une famille avec cancer du colon héréditaire et qui a peur d'en avoir un aussi. Qu'est ce qui est le plus important ?

- A. Faire coloscopie chez le gastroentérologue

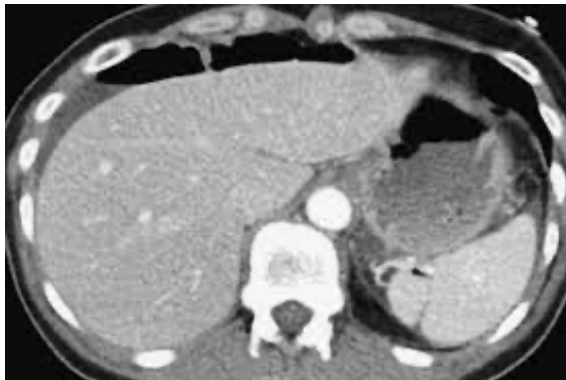
- B. Préciser anamnèse familiale cancer
- C. Faire un test génétique

Réponse : n'importe quoi cette question..B

Femme qui post-OP chir viscérale a des douleurs abdo et ventre sensible, pas de transit et on fait CT.

CRP 200, Lc 18. Fébrile à 38.9.

Abdomen douloureux diffusément, percussion tympanique.



C'est quoi la cause ?

- A. Aéroportie
- B. Lâchage anastomose iléo-colique
- C. Iléus paralytique postopératoire
- D. Iléus sur bride

Réponse : B

Jeune homme qui a des plaques prurigineuses sur la peau après avoir mis des pulls en laine, pris des douches froides et fait du sport l'été, plis de Dennis Morgan. C'est quoi ?

- A. Dermatite atopique
- B. Eczéma de contact
- C. Urticaire réactionnel
- D. Phénomène de Koebner

Réponse : A

(Question d'ancrage) Patiente de x années traité pour HTA par IEC. Elle a depuis 8 semaines des douleurs au dos traitée par ains et mnt elle a une HTA. Quelle est la cause ?

- A. AINS
- B. IEC

Homme qui a eu un OP et en post op l'infirmière vous appelle parce qu'il va pas bien. Qu'est-ce qu'il a ?



- A. Pneumothorax
- B. Pneumonie
- C. EP

Femme avec Ca thyroïde qui subit une thyroïdectomie totale, d'après l'anapath il s'agit de Ca folliculaire bien différencié T3N0Mx. Que faire ensuite ?

- A. Rien
- B. Iode radioactif
- C. Radiothérapie du cou
- D. Chimiothérapie

Réponse B

Patiente de 82 ans en réhabilitation en hôpital. L'infirmière vient vous voir car depuis ce matin elle a eu deux épisodes de mélèna malodorants. Elle avait eu une PTH en hôpital avant le transfert. Elle reçoit pour ses douleurs de l'ibuprofène, du paracétamol, et du tramadol. Elle est pâle, pulse à 95, hypotendue, que faites vous ?

- A. CT abdo
- B. Echographie de l'abdomen
- C. Coloscopie
- D. Gastroskopie
- E. Laparoscopie exploratoire

Réponse D

Patient de 36 ans, qui revient de New Delhi il y a 3 jours. Il y a 2 jours, il a eu des selles liquides 3-4x par jour, pas de vomissement ni de douleurs abdominales. Il a pris de la ciprofloxacine hier une dose. A l'examen clinique de ce jour, son abdomen est souple et indolore. Il est normocarde, normotendu et eupnéique. Que faites vous.

- A. culture de bactéries dans les selles
- B. culture de parasites dans les selles
- C. culture de virus dans les selles

- D. Recherche de C. Difficile
- E. Suivi clinique sans rien faire

Réponse E

Patiente de 22 ans qui pense avoir été agressée sexuellement à un festival hier, elle a bu deux bières le soir et ne se souvient pas de sa soirée. Quelles analyses toxicologiques sont à faire en premier lieu?

- A. Frotti vaginal
- B. Selles
- C. sang
- D. urines
- E. cheveux

Réponse C ("toxicologique") D (+2) (parce que moins invasif ?) GHB détectable dans le sang que durant 4 à 6 heures après l'ingestion et en moyenne 12h dans les urines

(Question d'ancrage) Patient de 22 ans, douleur de type mécanique au pli de l'aîne depuis 1 mois. Palpation de la hanche et du grand trochanter douloureuse. Boiterie à la marche no CRP, no fièvre, FSC N, radio bassin (quelque chose comme ça):



- A. Arthrite rhumatoïde
- B. Coxarthrose
- C. Fracture du col
- D. Ostéonécrose
- E. Tumeur du col

Réponse: E

Patiente avec une FA et une insuffisance cardiaque et une arthrose du genou qui prend du lisinopril, du torasémide, de la spironolactone, de l'amiodarone, et du diclofénac. Depuis 2 semaines, elle se sent très agitée, a de la peine à dormir, a perdu du poids.

Résultat laboratoire. TSH < 0.0004, T3T4 trop élevé. Quel médicament à pu induire cela?

- A. Amiodarone
- B. Lisinopril
- C. diclofenac
- D. torasémide
- E. spironolactone

Réponse A

Maman qui vient avec son fils de 8 ans car l'enseignant a demandé un examen clinique de l'audition de l'enfant. Il ne semble jamais écouter ce qu'il dit, ne répond jamais juste aux questions qu'on vient de lui poser et il semble toujours dans la lune. A l'examen clinique. Le test de Weber et de Rinné sont dans la norme, tout comme l'audiogramme. L'enfant semble montrer beaucoup d'intérêt pour tous les examens qu'on lui fait et il rit beaucoup et se tient souvent debout ?

- A. Surdit  de transmission
- B. Trouble du comportement
- C. Autiste
- D. Sd d'asperger
- E. Trouble du d ficit de l'attention et hyperactivit 

R ponse E

On fait une  tude pour voir si on peut remplacer le test par un gold standard

	Patient Malades	Patients non malades
Nouveau test	72	20
Gold standard	28	80

Quelle est la sensibilit  de ce test

- A. 72/92
- B. 28/100
- C. 80/100
- D. 80/200
- E. 72/100

R ponse E

On fait une  tude pour voir si on peut remplacer le test par un gold standard

	Patient Malades	Patients non malades
Nouveau test	72	20
Gold standard	28	80

Quelle est la spécificité de ce test

- A. 72/92
- B. 28/100
- C. 80/100
- D. 80/200
- E. 72/100

Réponse C

On fait une étude chez des adolescents dans le but de prévenir le risque d'accident et d'hospitalisation. Voici le tableau. Quel est le risque relatif dans une analyse "intention-to-treat" ?

	Patient ayant reçu le test	patient n'ayant pas reçu le test
patients inscrit dans l'étude	1100	1090
patients ayant fini l'étude	988	785
patient ayant eu des fractures	24	32

- A. 0.2
- B. 0.7
- C. 1.1
- D. 1.4
- E. 1.9

Réponse B

Question 69:

Patient de 58 ans, homme d'affaires qui vient pour son check-up annuel. Il est connu pour une hypertension traitée par lisinopril et l'hydrochlorothiazide et sinon en BSH. A l'examen clinique vous remarquez qu'il a un pouls à 156/minute, irrégulier. TA à 160/90. Glycémie post-prandiale à 10 mmol/l. Le patient est asymptomatique. Que lui donnez-vous ?

- A. Amiodarone
- B. Apixaban
- C. metformine

- D. aspirine
- E. Thiazidique

Réponse : B (FA de > de 48h ou de durée indéterminée, anticoaguler avant de cardioverser chimiquement avec amiodarone)

Coucou LIAM <3

Femme connue pour une Insuffisance cardiaque et un diabète de type II insulino requérant. Qui est retrouvée morte dans son appartement, une corde autour de son cou attachée à la porte de sa chambre, le nœud était derrière le cou. Elle avait des pétéchie dans les yeux. Quelle est la cause la plus probable de mort.

- A. Anoxie cérébrale
- B. Occlusion du larynx
- C. Hypoglycémie
- D. AVC
- E. Arrêt cardiaque

Réponse : A (+1) (petechies -> veines cou fermées)

71) un patient de 83 ans, arrive après un pontage coronarien aux soins intensifs.

Après quelques jours, il se plaint de démangeaisons. Au niveau du tronc, des plis de l'aîne et entre les doigts on observe des papules rouges. Après 2 jours, deux patients et un soignant présentent les mêmes symptômes. Quel est la cause le plus probable ?

- a) pityriasis vesicolor
- b) Tinea corporis
- c) la gale
- d) erythrasma
- e) érythème exsudatif polymorphe

Réponse C

Patient qui reçoit une pose de prothèse de genou programmée. A l'examen laboratoire d'entrée, sa prise de sang est dans la norme à l'exception de GGT légèrement augmenté. Le lendemain de la veille de sa PTG, il est tachycarde, désorienté, agité. Quoi lui donner

- A. Lorazépam
- B. Naloxone
- C. Flumazénil
- D. Physostigmine
- E. béta bloquant

Réponse A (sevrage alcoolique)

Jeune femme de 19 ans souffrant de douleurs crâniennes unilatérales plutôt au niveau frontal depuis 6 mois à raison de 1x/semaine environ. Douleurs à caractère pulsatile, d'intensité

5-8/10 sur l'échelle visuelle analogique, accompagnées de nausées, vomissements et photophobie. IRM et examen neurologique sans particularité.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Névralgie trigéminal
- B. Migraine sans aura
- C. Céphalées de tension
- D. Cluster headache
- E. Névralgies d'Arnold

Réponse : B

Patiente qui a fait de la peinture et de la rénovation. A des polyneuropathie périphériques aux quatres membres. Anémie normochrome normocytaire. Quelle est la cause probable?

δ-aminolevulinic acid (ALA) élevé

- A. Plomb
- B. Solvant
- C. Mercure
- D. CO
- E. Amiante

Réponse A (l'acide delta-aminolevulinique est typique d'une intoxic au plomb)

Question 100 : Patient avec ecchymose sur le dos qui avoue se faire maltraiter par sa femme à plusieurs reprises, n'ont pas d'enfant.

- A. Contacter la police
- B. Encourager à porter plainte
- C. Contacter le médecin cantonal
- D. Le diriger chez l'aide aux victimes
- E. Le diriger vers la médecine forensique (oui, c'était marqué "forensique")

Réponse : D? (j'aurai dit E pour qu'il y ait un constat légal, pas besoin de porter plainte, mais au moins le papier est là si besoin plus tard +2)

Question 101 : Patient de 53 ans, qui se plaint de douleurs dans tout le bras droit qui le poussent à se réveiller la nuit et il doit secouer le bras pour être soulagé.

Photo avec atrophie de la loge thénarienne. Déficit en de l'abducteur et de l'opposant du pouce.

Atteinte la plus probable de :

- A. N.Radial
- B. N.Ulnaire
- C. N.Median
- D. Racine C7
- E. Racine C8

Réponse C

Une femme de 49 ans vous consulte au cabinet car elle souhaite faire un dépistage du cancer du côlon (dans la donnée elle avait aussi du sang dans les selles). Son grand-père est décédé d'un cancer du rectum. Vous effectuez un examen clinique, y compris un toucher rectal, sans particularité, à part la découverte d'hémorroïdes de stade 2. Quelle est la meilleure prise en charge ?

Pour une femme de 49 ans avec des antécédents familiaux de cancer colorectal et des hémorroïdes de stade 2, la meilleure prise en charge pour le dépistage du cancer du côlon est la colonoscopie.

A. Colonoscopie pour dépistage du cancer du côlon

B. Contrôle dans 6 mois

C. Oeso-gastro-duodénoscopie

D. Resectoscopie

E. Recherche de sang occulte dans les selles

La colonoscopie est considérée comme le standard de référence pour le dépistage du cancer colorectal. Elle permet une visualisation directe de tout le côlon et peut inclure la biopsie de lésions suspectes. Les personnes ayant des antécédents familiaux de cancer colorectal, en particulier avec des membres de la famille au premier degré (comme un grand-père), devraient commencer le dépistage à un âge plus précoce que la population générale. Le sang dans les selles : Cela justifie davantage l'utilisation d'une colonoscopie pour exclure des pathologies plus graves, telles que le cancer colorectal.

Réponse : A ??? B? +1 A plutot!! De toute façon dès 50 ans il faut dépister le cancer du côlon, autant faire la colo tout de suite → ouais mais c'est pas remboursé si <50 ans => bien sûr que ça peut être remboursé, mais ce sera pas dans le cadre du dépistage cantonal

Une patiente de X années vient car a remarqué une lésion dans la bouche qui saignotte en position rétromolaire (?). Elle a une mauvaise hygiène dentaire et une parodontose, c'est une patiente qui boit et fume beaucoup (quantités données). Que faire ?

A. Envoyer chez le dentiste

B. Exérèse de la lésion pour analyse (biopsie)

C. Antalgiques, contrôle dans une semaine

D. lui dire d'arrêter de fumer et recontrôle à 3 semaines

Réponse : B

Question 120

Sinus Maxillaires

Localisation : Situés dans l'os maxillaire.

Symptômes :

Douleur et pression au niveau des joues, parfois irradiées avec des douleurs dentaires.

Sensibilité des dents supérieures.

Douleur augmentée par la pression sur la région maxillaire ou en se penchant en avant.

Rhinorrhée purulente.

Sinus Ethmoïdaux

Localisation : Entre les yeux, à la base du nez.

Symptômes :

Douleur au niveau de l'arête nasale et de la région rétro-orbitaire.

Cedème et rougeurs au niveau des yeux.

Rhinorrhée purulente.

Douleur augmentée en se penchant en arrière.

Sinus Frontaux

Localisation : Situés dans l'os frontal au-dessus des yeux.

Symptômes :

Douleur et pression au niveau du front.

Sensibilité accrue au toucher sur le front.

Céphalées frontales, souvent sévères, augmentées en se penchant en avant.

Sinus Sphénoïdaux

Localisation : Situés dans l'os sphénoïde à la base du crâne, près du nerf optique et de la glande pituitaire.

Symptômes :

Douleur profonde derrière les yeux ou à l'arrière de la tête.

Céphalées souvent diffuses et mal localisées.

Possible atteinte visuelle si le nerf optique est comprimé.

Jeune fille 13 ans, fébrile, rhinorrhée purulente rougeur et oedème périorbitaire, quel est le diagnostic le plus probable.

A. sinusite maxillaire

B. sinusite ethmoïdale

C. sinusite frontale

D. sinusite sphénoïdale

La sinusite ethmoïdale se manifeste par une douleur dans la région de l'arête nasale ou une douleur rétro-orbitaire.

Les rougeurs et l'œdème périorbitaires sont des signes typiques associés à la sinusite ethmoïdale en raison de la proximité des cellules ethmoïdales avec l'orbite.

La fièvre et la rhinorrhée purulente sont des symptômes courants de la sinusite bactérienne aiguë.

Réponse : B

Question 121

Femme de 34 ans, pneumonie basale droite traitée par amoxicilline, va mieux. 5 jours plus tard général abaissé, douleur pleural basale à droite, épanchement pleural avec LDH ++, protéines 56 (plasma 60), Lc avec 80% de Neutrophiles, fièvre 39.5

Que faire?

A. Ceftriaxone intra épanchement pleural

B. Clarithroymycine po

C. Pose de drain thoracique

D. ...

Réponse: C (?) (Empty?)

Femme jeune qui tombe dans les escaliers et se fait mal. Elle consulte aux urgences. Du point de vue du mécanisme physiologique de chute, laquelle de ces atteintes ne peut pas être observée dans ce mécanisme ?

- A. Fracture multifragmentaire de l'occiput
- B. Abrasions sur le dos
- C. Lésions spiroïdes à bord nets sur le tronc
- D. Fracture spiroïde du tibia
- E. Eraflures sur le siège

Rép: D (+2)? C (+1) ?

(Kprime) Dans votre joli cabinet, il y a un type de 58 ans qui a fumé une clope après l'autre dans la vie. Pour un check-up, il décide de consulter chez vous (forcément, puisque vous êtes expert dans les dépistages). Sachant que l'examen clinique est dans la norme, qu'est-ce qui fait partie des dépistages à proposer ?

- A. Tension artérielle
- B. Radio du thorax CT low dose oui
- C. Mesure du cholestérol sanguin
- D. Colonoscopie (?)

Pour un homme de 58 ans qui fume, les dépistages à proposer incluent :

- A. TA : Le dépistage de l'hypertension est recommandé pour tous les adultes à partir de 18 ans.
- C. Mesure du cholestérol sanguin : Le dépistage des troubles lipidiques est recommandé à partir de 20 ans.
- D. Colonoscopie (D) : Le dépistage du cancer colorectal est recommandé pour tous les adultes de 45 à 75 ans.
- La radiographie du thorax (B) n'est pas une méthode de dépistage standard pour les fumeurs, mais une CT scan thoracique à faible dose est recommandée pour les fumeurs de 50 à 80 ans ayant une histoire de tabagisme d'au moins 20 UPA.

Réponse : +/-/+ (+2) Dépistage du cancer pulm c'est CT low-dose donc B- (à partir de 30UPA)

Patient de X années que vous récupérez dans votre division depuis les soins intensifs. Il y avait séjourné pour décompensation X mais tout a été bien réglé, vous l'avez accueilli à l'étage dans de bonnes conditions.

La nuit, l'infirmière vous appelle, car il devient tachycarde, veut retirer sa sonde urinaire, avec état fébrile, TA basse. Le temps de recoloration capillaire est augmenté, les extrémités sont chaude ? et sèches. Marbrures. De quoi s'agit-il vraisemblablement ?

- A. Choc cardiogène
- B. Choc anaphylactique
- C. Choc septique
- D. Choc neurogène
- E. Choc hypovolémique

Réponse: C

Type connu pour une BPCO en chimiothérapie palliative, qui vient aux urgences avec une agranulocytose. Que faire ?

- A. Cefepime IV et hospitaliser
- B. Rien
- C. Co-amoxicilline PO et rentrer à la maison
- D. Co-amoxicilline PO et hospitaliser

Reponse: A si symptômes, sinon rien (B) mais pourquoi il viendrait aux urg? ...pour symptomatologie agranulocytaire mhm lol

(Q ancrage) Patient suivi en oncologie pour le traitement d'un cancer X, meurt de manière inattendue alors les médecins du service avaient prévu la sortie pour le lendemain. Que faire ?

- A. Autopsie anatomique
- B. Autopsie médico-légale
- C. Rien
- D. Autopsie clinique

Reponse : B

Un patient doit, pour une raison X, prendre un traitement avec isotopes radioactifs. Cependant, votre patient avale de travers et vous recrache par terre toute la soupe radioactive (bravo, c'est malin). Qu'est-ce qui permet de déterminer l'exposition radio-active ?

- A. Une chambre plombée
- B. Un compteur Geiger-Müller
- C. Un film dosimétrique
- D. Détecteur au germanium hyper pur
- E. Détecteur à puit de NaI

Réponse : C (le dosimètre électronique permet de mesurer la dose cumulative pendant l'accident)

Patient qui a eu une gastro il y a une semaine et qui ajd développe paresthésie et faiblesse musculaire aux 2-3 membre en commençant par les périphéries. Quelle est l'atteinte?

- A. Nerf spinaux
- B. Cordon postérieur
- C. Cordon latéral
- D. Cordon antérieur
- E. Cerveau

Réponse A

Patient qui a eu une gastro il y a une semaine et qui ajd développe paresthésie et faiblesse musculaire aux 2-3 membre en commençant par les périphéries. Comment poser le diagnostic?

- A. PL
- B. Electromyographie
- C. IRM cérébral cervicale

réponse A, SGB

Patient maçon qui a beaucoup travaillé à l'intérieur d'une ancienne maison ces derniers jours en faisant du ponçage, de la peinture etc, il a de l'acide delta-**ala-aminolévulinique** dans les urines. L'hypothèse diagnostique part sur une intoxication.

- A. **Plomb**
- B. Mercure
- C. Dissolvant

Réponse: A

Femme avec **gangrène de fourmier** qui progresse vite et tableau de choc

- A. iv direct + AB + CT
- B. **Nacl iv bolus en 15min + AB + appeler chir en urgence**
- C. Nacl iv en 1h + AB + surveillance
- D. Nacl iv + frottis plaie + chir

Réponse B

Patient avec tableau de méningite, l'examen PL retrouve des diplocoques Gram - . Qu'est-ce qui est la première mesure à faire, et la plus importante ?

- A. Isoler le patient
- B. Donner de la Ceftriaxone
- C. CT-cérébral
- D. Vancomycine IV

Rép: B (+1), sur suspicion de méningocoque pas plutôt A? a) oui j'ai mis A aussi (+1
algorithme CHUV faut commencer par isoler avant tout le reste si suspi méningite), isolement
serait fait avant la PL non?

(Kprim - Question d'ancrage) Photo avec trou par balle, les bords ne sont pas superposables. Il s'agit d'un patient qui a été trouvé le thorax dénudé, avec la plaie au milieu du thorax.

Quelles propositions sont justes ?

- A. Ce tableau fait penser à un suicide
- B. Il est possible que la personne ne soit pas décédée sur le moment
- C. La balle a été tirée d'une très courte distance
- D. Cette plaie est typique d'une plaie par balle

Réponse : -/+/-/+ (- + + + ?) La C est fausse, on ne peut rien dire sur la distance de tir, même avec collerette d'essuyage, on peut juste dire qu'il s'agit du trou d'entrée de la balle

Homme avec hémisyn-drome, parle pas par moments. Vous **suspectez un AVC**, mais pas de saignement, pas de zone d'ombre au CT. Pas de dissection de la carotide visible au CT. Que faire?

- A. **IRM cérébrale**
- B. IRM cervicale
- C. PL
- D. ?
- E. ?

Réponse: A (on voit l'oedème de l'AVC déjà après 6H à l'IRM au contraire du CT qui peut être normal les premiers jours) on fait pas une PL si on ne trouve rien au CT ? Pour une HSA oui mais 85% des AVC sont ischémiques donc j'aurai dit A (guideline CHUV c'est même directement IRM)

Enfant de 6 ans qui présente une énurésie. Il n'a jamais été propre la nuit, de jour il est propre depuis ses 3 (?) ans. La maman consulte chez vous car elle ne sait plus quoi faire. Le pauvre gosse ne veut pas aller chez son pote pour une pyjama party car il a peur de faire pipi au lit. Quoi faire ?

- A. Thérapie psycho-dynamico-comportementale-sociale
- B. Bilan entrée-sorties et restriction hydrique dès 17h
- C. Calendrier des mictions et thérapie comportementale (appareillage etc)
- D. On donne des anti-diurétiques (Desmopressine)

Réponse : C (+3) (pas D?non, après 7 ans et si le reste n'a pas marché) normalement en première ligne thérapie comportementale et limitation des fluids

Suite de questions

1) Patiente avec ascite -> ponctionner

2 (A) La patiente a arrêté de boire, les paramètres du foie se sont normalisés, mais jsp combien de temps plus tard lui trouve un nodule de ≈ 2 cm dans le lobe VI, que faire?

- A. Hémihépatectomie
- B. Résection du segment VI
- C. Radio-embolisation du foie droit

Rép : B,

3 (K') La patiente ne boit toujours pas, les paramètres sont toujours ok, mais encore quelque temps plus tard, on retrouve 2 nodules dans le foie. Qu'est-ce qui est une contre-indication à la transplantation ?

- A. La consommation d'alcool de la patiente
- B. La taille des nodules
- C. le nombre de nodule
- D. Antécédents chir hépatique

xx) Patient avec naevus suspect (mélanome). Quel est le facteur le plus important à préciser dans l'anamnèse ?

- A. Tabac
- B. Coup de soleil dans l'enfance
- C. Nombreux naevus

Réponse: B, A (tabac empire pronostic mélanome)

51. Patient de 9 ans, amené par sa mère pour fatigue et trouble de la croissance. Il mesure 120 cm (-2.8 SD) et pèse 19.8 kg (- 3.5).

Au laboratoire, on retrouve :

Enfant de 9 ans présentant de la **fatigue**, un **retard de croissance**.

T4 faibles et la TSH n'est pas augmenté donc elle ne compense pas (= dysfonctionnement hypophysaire) --> suggèrent une hypothyroïdie secondaire, généralement associée à un dysfonctionnement hypophysaire -->

Hypopituitarisme

- TSH 0.8
- T4 5

- A. Hypopituitarisme
- B. Déficit idiopathique en GH
- C. Hypothyroïdie primaire
- D. Maladie cœliaque
- E. Petite taille psychosociale

Réponse : A

52. Patient de 62 ans, connu pour une insuffisance rénale chronique, hospitalisé pour une pneumonie avec bonne évolution sous antibiotique.

Au laboratoire, on retrouve :

IRC

--> hypoCa
HyperPhos
hypoVitD

- Calcium 2.21 = normocalcémie
- Phosphate 2.1 = Hyperphosphatémie
- PTH 12 = Hyperparathyroïdie

IRC

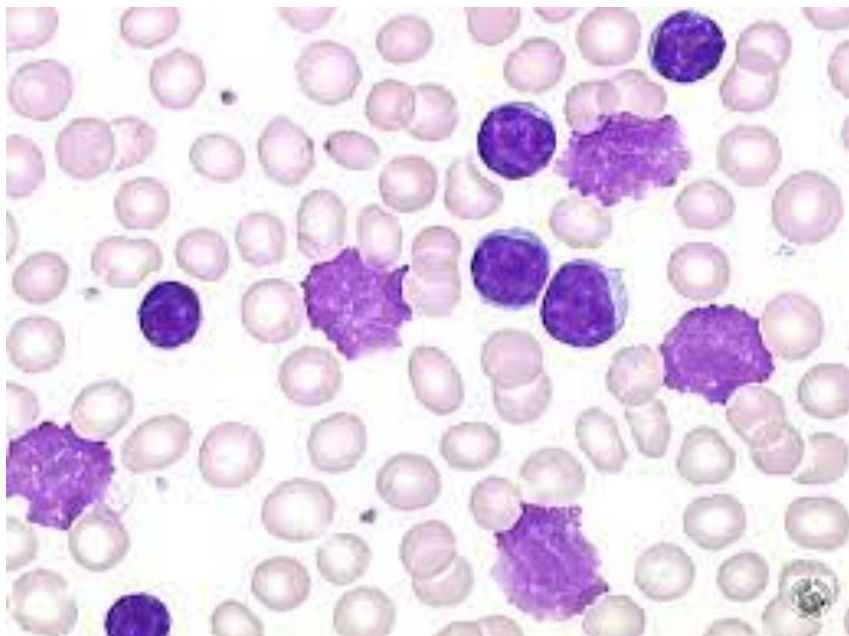
--> exrétion rénale de Phos diminuée
--> HyperPhos
--> prrécipitation de Pohn de Ca dans le tissus
--> hypoCa

- A. Hyperparathyroidie primaire
- B. Hyperparathyroidie secondaire
- C. Excès de vit D
- D. Production tumorale de PTH related peptide
- E. ?

--> hypoCa chronique --> **Hyperparathyroïdie II**

Réponse : B (sur l'IRC)

55) (Question d'ancrage) Patient de 80 ans avec baisse de l'état général, perte de 6kg non volontaire en quelques semaines. Sudations nocturnes. Lymphadénopathies, sauf erreur pas d'hépatosplénomégalie). On lui fait un frottis qui montre cela :



- A) mononucléose infectieuse
- B) VIH

- C) Lymphome de hodgkin
- D) leucémie lymphoïde chronique

Réponse : D (Gumprecht)

56) Femme de la cinquantaine qui présente des douleurs épigastriques avec nausées. Rien de particulier au status, si ce n'est une sensibilité en épigastre et en hypochondre droit. Pas de défense ni de détente. Labo : ASAT/ ALAT augmentées, PA GGT augmentées, bilirubine totale augmentée. Qu'est ce qui est le plus indiqué à ce stade ?

- A) ERCP
- B) Tests pancréatiques (amylase lipase)
- C) US abdominal haut
- D) CT abdominal (plus sûre de cette réponse)

Réponse : C

(Question d'ancrage) Cadavre retrouvé dans une maison qui a brûlé ou un truc du genre. Qu'est-ce qui permet d'affirmer que le patient a subi une intoxication CO ?

- A. Traces sanguinolantes trouvées sur la bouche et l'anus (qqchose comme ça)
- B. Pertes de selles
- C. Lividités cadavériques rouges claires
- D. Le cadavre a une odeur de vieille pomme
- E. Le radiateur émet une odeur d'amande amère

Réponse : C

(Question d'ancrage) Un enfant est né à la 36 0/7e semaine de grossesse avec un poids à la naissance de 2450g. L'adaptation postnatale est normale. Le groupe sanguin de la mère est 0 positif, celui de l'enfant est A positif. Dans les antécédents familiaux on retrouve un déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase chez un oncle maternel. La mère souhaite quitter l'hôpital avec son enfant 48 heures après la naissance. Quel test doit-elle faire avant cela ?

- A. Le test de Coomb
- B. Test Guthrie
- C. Mesure de la bilirubine
- D. Dépistage cardiaque
- E. Échographie de la hanche

Réponse : C, D

143) (Question d'ancrage) Patiente de 25 ans (environ), consulte pour des douleurs abdominales basses, avec pertes vaginales purulentes, elle a un nouveau copain depuis 2

mois. Mobilisation de l'utérus douloureuse. Patiente fébrile. US transvaginal sans particularité. Test de grossesse négatif. Quelles complications sont associées avec cette pathologie ? (K')

- A) Stérilité
- B) Douleurs abdominales basses chroniques
- C) Grossesse extra-utérine
- D) Péri-hépatite

Réponse: ++++

144) Question en deux parties (pour avoir la deuxième partie il faut verrouiller la première)

144.1 : Nouveau né de 2j qui est né à terme après grossesse harmonieuse, bonne adaptation néonatale avec un APGAR à 9/10/10, mère groupe O, Rhésus +, d'origine méditerranéenne. Contrôle de la sage femme : ictère prononcé, sinon nouveau-né qui va bien. La mère dit que l'ictère a débuté la veille. Qu'est ce qui est la raison de l'ictère ?

- A) Immaturité hépatique
- B) Incompatibilité ABO
- C) Thalassémie
- D) incompatibilité rhésus

L'ictère néonatal peut avoir diverses causes, dont les plus courantes sont :

1. **Immaturité hépatique** : L'immaturité du métabolisme hépatique de la bilirubine est une cause fréquente d'ictère physiologique chez les nouveau-nés.
2. **Incompatibilité ABO** : Une incompatibilité entre le groupe sanguin de la mère et celui du nouveau-né peut provoquer une hémolyse accrue, entraînant un ictère pathologique.
3. **Thalassémie** : Une hémoglobinopathie comme la thalassémie peut aussi être responsable d'une hyperbilirubinémie en raison d'une hémolyse accrue.
4. **Incompatibilité Rhésus** : Bien que l'incompatibilité Rhésus puisse aussi causer un ictère, ce n'est pas pertinent dans ce cas, car la mère est Rh+.

Réponse : B 100% sure A?
à partir du 3ème jour

Dans ce contexte, étant donné que la mère est de groupe O, il y a une possibilité d'incompatibilité ABO avec le nouveau-né, surtout si ce dernier est de groupe A ou B. Cela peut entraîner une hémolyse néonatale et un ictère.

144.2 :

Au vu de l'ictère précoce, la sage femme fait la bilirubine qui est à 320 (norme <220). Quel test supplémentaire doit-elle envoyer au pédiatre ? (K')

- A) Hémoglobine
- B) Électrophorèse de l'hémoglobine
- C) Coombs
- D) Tests hépatiques

A) Hémoglobine : Ce test permet de détecter une éventuelle anémie, qui pourrait résulter d'une hémolyse. Une anémie hémolytique est une cause courante d'ictère néonatal pathologique.

B) Électrophorèse de l'hémoglobine : Ce test est pertinent pour exclure des hémoglobinopathies, telles que la thalassémie, surtout chez les populations à risque, comme les personnes d'origine méditerranéenne.

C) Coombs : Un test de Coombs direct permet de détecter des anticorps maternels fixés sur les globules rouges du nouveau-né, indiquant une incompatibilité ABO (très probable dans ce cas puisque la mère est de groupe O et le nouveau-né pourrait être A ou B) ou Rhésus (bien que la mère soit Rh+, cette cause est exclue).

D) Tests hépatiques : Les tests des enzymes hépatiques peuvent aider à exclure une atteinte hépatique ou une cholestase, bien que ce soit moins probable dans ce cas spécifique mais reste une évaluation standard.

1. **Hémoglobine** : Évaluation de l'anémie hémolytique.
2. **Électrophorèse de l'hémoglobine** : Exclusion des hémoglobinopathies.
3. **Coombs** : Détection d'incompatibilité ABO (très probable).
4. **Tests hépatiques** : Évaluation de l'état du foie et exclusion des causes hépatiques.

Question A:

Homme dans la 40 ou 50aine, présentant depuis quelques mois des diarrhées, avec douleurs et ballonnements abdominaux. De plus, il rapporte avoir des épisodes pendant lesquels il sent son coeur battre vite, a chaud et devient très rouge au niveau du visage.

Quel est le diagnostic le + probable?

- A. Cancer du côlon
- B. Maladie de Crohn
- C. Tumeur neuro-endocrine
- D. ...
- E. ...

Symptômes de diarrhées, de douleurs et de ballonnements abdominaux, ainsi que des palpitations, des bouffées de chaleur et des rougeurs au visage. Parmi les options de diagnostic proposées, les tumeurs neuroendocrines (C) sont les plus probables. Voici pourquoi:

1. **Diarrhées** : Les tumeurs neuroendocrines peuvent provoquer des diarrhées chroniques.
2. **Douleurs et ballonnements abdominaux** : Ces symptômes sont communs dans diverses affections gastro-intestinales, y compris les tumeurs neuroendocrines.
3. **Palpitations, bouffées de chaleur et rougeurs au visage** : Ces symptômes sont caractéristiques du syndrome carcinoïde, qui est souvent associé aux tumeurs neuroendocrines.

Comparaison avec d'autres diagnostics

A. **Cancer du côlon** : Bien que le cancer du côlon puisse causer des diarrhées et des douleurs abdominales, les symptômes de palpitations, bouffées de chaleur et rougeurs au visage ne sont pas typiques.

B. **Maladie de Crohn** : La maladie de Crohn provoque des diarrhées et des douleurs abdominales, souvent accompagnées de perte de poids et de malnutrition. Cependant, les palpitations, bouffées de chaleur et rougeurs ne sont pas caractéristiques de cette maladie.

Pour un diagnostic précis, des examens supplémentaires tels que des analyses sanguines, des études d'imagerie et éventuellement une biopsie seraient nécessaires.

Réponse : C

Tumeurs Neuroendocrines (TNE)

Sont des néoplasmes qui proviennent des cellules neuroendocrines, capables de produire des hormones. Elles peuvent se développer dans divers organes, mais sont couramment trouvées dans le tractus gastro-intestinal et le pancréas.

Types de TNE

1. **TNE fonctionnelles** : Sécrètent des hormones en quantités suffisantes pour provoquer des symptômes cliniques spécifiques (e.g., insulinome provoquant une hypoglycémie).
2. **TNE non fonctionnelles** : Ne sécrètent pas suffisamment d'hormones pour causer des symptômes, mais peuvent causer des effets locaux dus à la masse tumorale.

Symptômes

- Symptômes gastro-intestinaux : **Diarrhée, douleurs abdominales, ballonnements.**
- **Syndrôme carcinoïde** (associé aux TNE carcinoïdes) : **Bouffées de chaleur, palpitations, rougeur du visage, diarrhée aqueuse.**
- Autres symptômes : Dépendent du type de hormone sécrétée par la tumeur. Par exemple, l'insulinome cause des épisodes d'hypoglycémie.

Diagnostic

- Tests hormonaux : Mesure des niveaux de diverses hormones dans le sang.
- Imagerie : Tomodensitométrie (TDM), résonance magnétique (IRM), scintigraphie aux récepteurs de la somatostatine (SRS).
- Biopsie : Confirmation histopathologique via l'examen de tissu tumoral.

Traitement

- Chirurgie : Resection chirurgicale des tumeurs localisées.
- Thérapies ciblées : Utilisation de médicaments visant des cibles spécifiques sur les cellules tumorales.
- Thérapie symptomatique : Analogues de la somatostatine pour réduire les symptômes des TNE fonctionnelles.

Pronostic

Le pronostic dépend de nombreux facteurs, y compris le type spécifique de TNE, son emplacement, et l'étendue de la maladie au moment du diagnostic. Les TNE peuvent varier considérablement en termes de malignité et d'agressivité.

Un garçon de 9 ans est admis avec un TCC ainsi qu'un traumatisme abdominal et thoracique. Il subit plusieurs examens radiologiques (scanner, 18 Rx) et est ainsi exposé à une dose totale de 30mSv. Les parents veulent savoir quels sont les effets des radiations sur leur enfant. Que répondez-vous aux parents ?

- a) Les rayons utilisés dans le radiodiagnostic sont inoffensifs pour le corps humain.
- b) Les radiations utilisées présentent un risque accru et justifient un contrôle par scanner tous les ans, puis tous les 5 ans.
- c) En raison de l'irradiation, il faut s'attendre à des séquelles aiguës telles que la rougeur de la peau et la chute des cheveux.
- d) Le niveau de rayonnement appliqué est inoffensif, il n'est donc pas nécessaire de prendre d'autres précautions.
- e) La dose totale est inférieure à la charge naturelle annuelle totale en Suisse.

d

Question ancrage: Réponse D (L'étude des victimes de Hiroshima et Nagasaki n'a pas révélé de risque statistiquement significatif de cancers pour des doses aux organes inférieures à 100 mSv=0,1 Sv. La dose d'irradiation annuelle moyenne de la population suisse s'élève à 5,5 mSv)

K) (Question d'ancrage) Une femme enceinte vient à votre cabinet pédiatrique car elle se demande quels sont les **facteurs de risques de la mort subite du nourisson**:

- A) dormir dans le lit des parents
- B) dormir sur le dos
- C) dormir avec une sucette (j'imagine qu'ils voulaient dire lolette/tétine)
- D) une chambre à + de 21 degré

Réponse: +--+

(Question d'ancrage) Lesquels des propositions suivantes tombent sous la responsabilité de la **Confédération** ?

- A. La délivrance du titre de médecin
- B. L'autorisation d'ouverture de cabinets *canton*
- C. L'organisations des urgences et de médecine de catastrophe *canton*
- D. Protection contre les produits toxiques et les radiations

Réponse : +/-/-/+ => les urgences et le plan de catastrophe c'est les cantons (site OFPP)

Patient qui consulte pour douleurs du poignet, a des douleurs lors de l'abduction ulnaire **poing fermé sans le pouce**.

- A. Dupuytren
- B. **Ténosynovite de De Quervain**
- C. Tunnel carpien
- D. Fracture scaphoïde
- E. Fracture du triquetrum

Réponse : B (+1) **(Test de Finkelstein+)**

Érythréenne qui consulte chez vous car de puis 8 semaines elle remarque une perte de poids et une adénopathie symétrique cervicale, sous-claviculaire et axillaire (sic!). Au labo vous avez pancytopenie si je ne me trompe pas (en tout cas Lc à 2 G/L), quel est votre diagnostic de présomption ?

- A. Hodgkin
- B. Tuberculose
- C. VIH
- D. Mononucléose infectieuse

Réponse : perso j'ai mis C, A plutot (+3)?

(Q ancrage) Mec de 60 ans d'années, a été stenté il y a un mois, s'en sort avec une DAPT (aspirine + clopidogrel) pour 6 mois. Actuellement, il présente des symptômes de cholecystite, le chirurgien aimerait effectuer une cholécystectomie dans les 3 prochains mois. Que faire ?

- A. Stop DAPT et opérer
- B. Stop DAPT et opérer après 7 - 10 jours
- C. Attendre 8 - 12 semaines puis Stop DAPT et opérer
- D. Attendre 8 - 12 semaines puis Stop clopidogrel et opérer sous Aspirine

D (confirmé avec recommandations AHAA/ACC)

Question 44 :

Patient d'environ 30 ans, ancien toxicomane, consulte pour des douleurs lombaires en péjoration sur les derniers jours, ne cédant pas à la prise d'AINS. Etat fébrile à 38.5°C. La palpation est douloureuse au niveau de L3, et la musculature paravertébrale est contractée. Quelle germe suspectez-vous ?

- A. Mycoplasma pneumoniae
- B. ...
- C. ...
- D. Staph aureus
- E. Staph epidermidis

Réponse : D

Question 45 :

Patiente d'environ 40 ans chez qui on trouve une microhématurie. Elle se sent en pleine forme, n'a pas de plainte. Elle est afebrile. Pas d'antécédent particulier hormis le fait qu'elle est une grosse fumeuse. Les résultats de laboratoires sont dans la norme, et les GR dans l'urine ne sont pas déformés. L'examen interne est normal. Que faites-vous ?

- A) Rien
- B) Cystoscopie et ...
- C) examen gynécologique (wtf? ils disaient que l'examen "interne" était normal)

Réponse : B

Question sur gars traité par Antidépresseur (Fluoxétine je pense). L'antidépresseur marche bien, il prend de nouveau du plaisir à faire des trucs, mais par contre au lit ça va pas, il constate une baisse de libido. Il s'entend bien avec sa compagne mais récemment, de nouvelles tensions sont apparues. Que faire ?

- A. Thérapie de couple
- B. Thérapie sexuelle
- C. Changer d'antidépresseur
- D. La réponse D

Reponse C? (+1) (pas de tr sexuels si on prend un AD atypique genre mirtazapine ou bupropion)

(Question d'ancrage - Kprim) Un homme de 24 ans doit faire un CT avec injection de produit de contraste IV. Qu'est-ce qui pourrait se passer ?

- A. Choc anaphylactique
 - B. Urticaire
 - C. Oedème de Quincke
 - D. Bronchospasme
- Autre Ell:
- Néphropathie induite par le contraste
 - Hyperthyroïdie induite par l'iode
 - Réactions retardées
 - Thrombophlébite
 - Métallose

Réponse : +/+/+

(Question d'ancrage) Ulcère au-dessus de la malléole interne, quelle origine en rapport avec la localisation?

- A. AOMI
- B. Insuffisance veineuse
- C. Mal perforant

Réponse : B

(mais c'était marqué malléole **externe** pas interne, non ?! Donc is externe => artériel)

Vous avez effectué une péridurale pour un accouchement. A quoi faire attention dans les heures suivant l'intervention ?

- A. Bilan mictionnel
- B. Choc par effet vasoplégique de l'anesthésie (truc du genre)
- C. Bloc sympathique

Réponse : A (retention urinaire, il faut un cathetere des fois), pas B car hypoTa possible, mais pas choc, pas C car bloc sympathique si niveau T4

Quel intérêt a la randomisation en double-aveugle dans une étude :

- A. Éviter l'erreur de type 2
- B. Distribuer les facteurs de confusion de manière équitable pour permettre de limiter leur effet
- C. Pouvoir contrôler les paramètres des participants (sexe, âge, facteurs de risque etc)

Réponse : B

(Question ancrage) Patient de 40 ans, originaire d'Italie, a des aphtes dans la bouche depuis un certain moment, un érythème noueux, des douleurs articulaires et des soucis oculaires.

Qu'est-ce qu'il a ?

- A. Maladie de Behçet
- B. Colite ulcéreuse
- C.
- D.

Réponse A

On aimerait démarrer une thérapie par anti-TNF chez un patient pour une raison dont je ne me rappelle plus. Que faire avant ?

- A. Radiographie
- B. Recherche de la tuberculose par QuantiFERON-TB © (tu vois le placement de produit...)
- C. Recherche EBV et CMV
- D. ?

Réponse : B

Vous avez un patient de 80 ans avec une anémie Hb à X g/L, MCV 87 fL (n 82-98), vous ne savez pas pourquoi, pas de piste clinique. Quoi doser **en premier** ?

- A. Ferritine
- B. LDH
- C. Bilirubine
- D. Réticulocytes

Réponse D (+2, selon algorithme HUG)

Maman de 35 ans, sans activité professionnelle, vit seule avec ses 2 enfants en bas âge, tombe alors qu'elle cuisine et se casse le bras. Elle n'est pas couverte par l'assurance de son mari, et n'est pas souscrite à l'assurance accident de son assurance maladie. Qui paie?

- A) Assurance perte de gain
- B) Assurance Maladie (Lamal)
- C) Assurance accident de son ancien travail
- D) Elle
- E) Caisse de compensation

Réponse : D

Patient de 55 ans, connu pour une hypertension réfractaire traité par lisinopril et amlodipine se présente pour un check up chez son généraliste. Il n'a aucune plainte actuelle. Au cabinet on mesure une tension de 175/95 et une FC de 85 BTM. Son status est normal.

HTA
réfractaire

L'hyperaldostérionisme primaire (ou **syndrome de Conn**) est une cause fréquente d'HTA réfractaire.

Il se caractérise par une production excessive d'aldostérone, entraînant une rétention de sodium, une excrétion de potassium (hypokaliémie) et une hypertension.

L'hypokaliémie en présence d'hypertension est fortement évocatrice d'hyperaldostérionisme primaire.

Au laboratoire on observe une creat, une GFR, un sodium et une HbA1c dans la norme mais une Kaliémie à 3.2 mmol/l (diminué)

Quelles sont les causes de l'HTA?

A) Sténoses bilatérales des artères rénales

B) Hyperaldostérionisme **Hyperaldostérionisme I**

--> **Aldostérone en excès**

C) Maladie de Cushing

--> Excré. K augmenté

D) Pheochromocytome

--> **hypoK** --> Crampes, faiblesse musculaire, fatigue, arythmies

E) Coarctation de l'aorte

--> Excré. H augmenté --> **Alcalose métabolique**

--> Réab. Na augmenté

--> **Rétention hydrique** --> **HTA**

B

--> **HyperNa légère** (mécanisme compensatoire: Echapement d'Aldo)

(Question d'ancrage)

Dans votre cabinet, vous voyez une vieille dame qui boit beaucoup malgré le fait qu'elle conduit sa voiture. Malheureusement, elle ne veut pas en parler avec vous, mais vous avez un bon nez et sentez un foetor alcoolique. Vous retenez d'aborder le sujet avec vos compétences de communication mais cette dame refuse toujours d'en parler. Que faire ?

A. Appeler la police

B. Contacter des proches pour en parler tranquillement autour d'un café

C. Contacter l'autorité compétente cantonale

D. Demander d'être délié du secret médical auprès du médecin cantonal (pas sûr que c'était lui?)

Réponse : C Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins.

Patiente avec 3 antécédents de mycose cette année, consulte pour les mêmes symptômes. Quelle démarche ?

A. Lui recommander le port de culotté en nylon

B. Effectuer un antifongogramme

C. Traitement antifongique prophylactique per os

Réponse : B (car > 4 épisodes)

Une mère qui travaille à 50% a besoin d'un **certificat** pour son employeuse car elle doit rester à la maison pour s'occuper de son **enfant malade**.

A. On lui fait une incapacité de travail à 100%

B. On lui fait une incapacité de travail à 50%

C. On lui fait une attestation mentionnant qu'elle ne peut pas aller travailler car elle doit s'occuper de son enfant malade

Réponse : C

- Patient diabétique avec crépitements... gangrène gazeuse? Fascéite?
- Patient jeune avec dyspnée, turgescence jugulaire, ascite... Péricardite constrictive?
- Kyste hépatique hypoéchogène retour de voyage, kyste **amibien**? Hydatique? Alvéolaire? echinococcose (ancrage)
- (Q ancrage) Patient avec fausse routes dans contexte de Parkinson, pneumonie par **aspiration**? à S. Pneumoniae?
- Céphalées brutales, Scanner? PL?
- Syndrome queue de cheval...
- Patient avec possible arthrose à la radio et clinique, ne rien faire de plus pour le diagnostic?
- Clinique de torsion testiculaire?
- Clinique hydrocèle?
- Patient avec perte sensibilité en chaussettes, réflexes rotuliens (?) diminués, polyneuropathie? Mononeuropathie sur vasculite?
- Question ou il fallait cocher BCR-ABL1
- Question sur SLA -> faire ENMG
- Question sur hypocalcémie et bisphosphonates
- Question sur fracture condylienne latérale pédiatrique avec risque d'atteinte du nerf ulnaire -> pas condyle médial du cou?
- Question sur entorse ch
- question sur anticoagulation pour FA / patient avec score Chads2Vasc haut
- enfant avec zona. mesures épidémiologiques pour proches?
- tunnel carpien
- Petite 4 mois avec toux, EF 39°C. Dx? Pneumonie/Bronchiolite/..

Opération d'une fracture sous rx, qu'est ce qui est juste pour la chirurgienne de 45 ans ?

- A. Peut laisser ses mains sans protection sous Rx pour maintenir la réduction de la fracture.
- B. Pas de précaution, car elle a 45 ans.
- C. Doit porter un tablier de plomb et pour protéger sa thyroïde
- ???

Réponse: C

Question 80 :

Homme de 54 ans, se plaint d'un prurit nocturne. Pas d'anomalie au niveau de la peau hormis quelques lésions de grattage. Douleurs abdo?

- A. OGD
- B. US abdominal

Réponse : B

Q46:

Un enfant de 3 ans présente un écoulement nasal purulent antérieur et une T de 38C puis un oedème peri-orbitaire. Quelle est la localisation de l'atteinte:

- A. Sinus Ethmoidale
- B. Sinus Frontale
- C. Sinus Maxillaire
- D. ...

Réponse: A

Q47: Un patient de 60 ans présente des douleurs mécaniques du genou droit depuis plusieurs mois. Aucune notion de traumatisme dans l'anamnèse. Au status, pas de signe d'inflammation, uniquement un léger oedème. Vous effectuez une radio du genou (cf ci-joint). Quel autre examen est nécessaire pour poser le Dx?



- A. IRM
- B. CT
- C. Aucun autre examen
- D. Echo
- E. SPECT

Réponse C

Examen fédéral 2022 jour 2

1. Un patient que vous suivez en post-opératoire suite à une parotidectomie remarque quelques jours plus tard que le bord droit de sa lèvre s'affaisse. Quel nerf est vraisemblablement lésé ?

- A. Facial
- B. Maxillaire
- C. Mandibulaire
- D. Trijumeau
- E. Oculomoteur

Réponse : A

2. Un homme de 35 ans a eu un accident en moto et les chirurgiens ont dû procéder à une splénectomie. Quelle vaccination devra être faite ?

- A. Coqueluche
- B. Hépatite B
- C. Pneumocoque
- D. Fièvre jaune
- E. ROR

Réponse : C

3. (Question d'ancrage) Femme de 85 ans amenée aux urgences après une chute. A l'examen clinique, vous constatez que son membre inférieur droit est douloureux à la mobilisation, et qu'il est raccourci et en rotation externe. Quelle est probablement la lésion?

- A. Fracture du bassin
- B. Fracture de la cheville droite
- C. Fracture du col du fémur à droite
- D. Fracture de la diaphyse fémorale à droite
- E. Luxation de la hanche droite

Réponse : C

4. (Question d'ancrage) Homme de 89 ans amené aux urgences après une chute. Vous diagnostiquez une fracture de la diaphyse humérale. A l'examen clinique, vous constatez que l'extension du poignet et des doigts est impossible. Quel est le nerf lésé?

- A. N. axillaire
- B. N. radial
- C. N. ulnaire
- D. N. médian

Réponse : B

7. Un homme de 76 ans est connu pour un diabète de type 2 diagnostiqué il y a 12 ans. Depuis plusieurs années, il suit un traitement composé de Metformine, Empagliflozine (SGLT2

inhibiteur) et d'insuline rapide (dépendant de la glycémie). Il est actuellement hospitalisé pour un tableau de gastro-entérite avec diarrhées et nausées. Au bilan, on retrouve une acidose métabolique avec une altération de la fonction rénale (eGFR à 28 mL/min).

A ce stade, quel traitement anti-diabétique peut être poursuivi ?

- A. Metformine seule
- B. Empagliflozine seule
- C. Insuline seule
- D. Metformine et insuline
- E. Empagliflozine et insuline

Réponse : C

8. (Question d'ancrage) Patiente de 62 ans séjourne dans une chambre à 5 lits d'un service de chirurgie pour les suites d'une résection colique pour un adénocarcinome. 10 jours après son admission, elle présente une toux et un état fébrile conduisant à un diagnostic de **pneumonie à Legionelle**. Quelle est la mesure épidémiologique à prendre ?

- A. Isoler la patiente
- B. Administrer une antibiothérapie prophylactique aux voisines de chambres
- C. Rechercher Legionella sur les frottis de surface de chambre
- D. **Rechercher Legionella dans l'eau courante de la chambre**
- E. Rechercher Legionella dans les frottis naso-pharyngé des voisins de chambres

Réponse : D

15. Femme de 30 ans, qui se plaint de fatigue, de perte de 5 kg sur les 3 derniers mois, de sudations nocturnes, avec adénopathies cervicales, au frottis de sang périphérique on retrouve des cellules de Reed-Sternberg, de quelle maladie s'agit-il :

- A. lymphome folliculaire
- B. lymphome du manteau
- C. lymphome de Hodgkin
- D. lymphome B à grandes cellules

Réponse : C

16. (Question d'ancrage) Homme de 56 ans, vieux toxico connu pour une consommation d'alcool chronique, présente un gonflement des gencives cf photo, avec ecchymoses

récurrentes et pétéchiées au niveau des avant-bras.



Symptomatologie expliquée par une carence en :

- A. fer
- B. acide folique
- C. vitamine K
- D. vitamine C
- E. vitamine D

Réponse : D

19. Une femme de 49ans sans antécédants, 20UPA, consulte pour des douleurs épigastriques apparues 2h plus tôt suite à une discussion animée au café. Les douleurs irradient dans la poitrine Elle présente également des nausées sans vomissements.

Au status, la patiente est hémodynamiquement stable. Le status cardio est sans particularité (pas de souffle audible, bruits normaux). La palpation abdominale est sensible au niveau épigastrique, sans défense. Murphy négatif.

Un ECG est effectué (image avec sus décalage ST en II III et AVF). Quelle est votre attitude ?

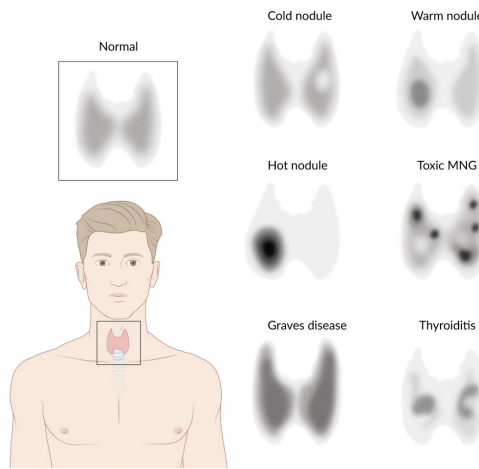
- A. Mesurer les troponine et attendre
- B. Donner de la morphine et attendre
- C. Effectuer un US abdominal
- D. Transfert dans un hôpital central pour une coronarographie en urgence
- E. Prévoir une consultation chez le cardiologue le lendemain

Réponse : D

20. Une jeune patiente consulte pour des symptômes qui vous font penser à une hyperthyroïdie (pas de détail sur la clinique, dit comme ça). Le laboratoire confirme une hyperthyroïdie (non plus, pas de labo donné). Un US thyroïdien est effectué et montre une hyperéchogénicité diffuse. Vous effectuez une scintigraphie qui est montrée. Quel est le diagnostic le plus probable ?



- A. Thyroïdite purulente
- B. Hashimoto
- C. Basedow
- D. Autonomie multifocale
- E. Carcinome papillaire



Réponse : C

53-Un nourrisson de 3 mois en BSH, naissance à terme, bonne adaptation. L'histoire actuelle a débuté il y a une semaine avec un rhume banal. A présent, apparition d'une toux et augmentation du rhume et difficultés respiratoires. Baisse de la prise alimentaire avec refus de prendre le sein. Le reste de la famille va bien.

Aux urgences vous la voyez, elle présente des signes de détresse respiratoire avec tachypnée, tirage sous costal, wheezing. A l'auscultation, wheezing sur l'ensemble des plages respiratoires.

Le plus probable :

- A. Asthme allergique débutant
- B. Pneumonie
- C. Syndrome respiratoire du rhume descendant
- D. Bronchiolite
- E. Surinfection sur inhalation d'un corps étranger

Réponse : D

A54) Un enfant de 15 mois en BSH présente brutalement une fièvre à 40°C et une éruption cutanée rapidement progressif. A l'hôpital, l'enfant devient somnolent avec une nette altération de l'état général. On trouve des cocci gram négatifs. Que faire en premier ?



- A. PL
- B. Ceftriaxone

- C. Isoler
- D.

B, ou C ? (selon les guidelines du guide d'antibio du chuv pour **suspicion méningite aigue** https://www.chuv.ch/fileadmin/sites/min/552801_22_DM_DAM_guide_antibiotherapie_version_mai_2022.pdf?)

Patient qui vient avec plusieurs lésions. Il passe beaucoup de temps à la montagne.



Quel traitement?

- A. Chimiothérapie
- B. Cryothérapie
- C. Excision chirurgicale
- D. Immunothérapie
- E. Prednisone

Réponse: B

30. Patient de 68 ans, cadre dans une entreprise, connu pour HTA traitée et fumeur. Il se plaint de douleurs épigastriques avec nausées et vomissements depuis hier soir. Il dit qu'il a pris des AINS depuis 48H pour des douleurs à l'épaule. A l'examen clinique, abdomen souple, pas de défense, pas de détente. A la prise de sang effectuée chez le généraliste le matin-même, les tests hépatiques, pancréatiques et CRP sont dans la norme.

Que faire en premier?

- A. Gastroskopie
- B. US abdominal
- C. Colonoscopie
- D. Électrocardiogramme
- E. Rx thorax

Réponse : D

Patiente de 32 ans qui vient avec ADP. Ponction sur laquelle on voit des cellules de Reed-Sternberg.

De quelle maladie s'agit-il?

- A. Lymphome folliculaire
- B. Lymphome à grandes cellules B
- C. Lymphome de Hodgkin
- D. Lymphome du manteau

Réponse : C

27. Une femme de 67 ans se plaint de fièvre ayant débuté il y a un mois avec une fatigue et une perte de 3 kg. Son médecin traitant avait dosé la CRP qui était légèrement augmentée. Aujourd'hui elle revient en consultation et mentionne qu'une céphalée holocranienne a débuté il y a une semaine, péjorée à la mastication. Vous faites un labo qui révèle une légère anémie ainsi qu'une légère leucocytose et une VS et CRP fortement augmentée.

Quel est votre diagnostic à ce stade?

- A. Fièvre d'origine inconnue
- B. Sarcoidose
- C. Artérite de Takayasu
- D. Artérite à cellules géantes
- E. Endocardite

Réponse D

28. Femme 70 ans, depuis deux jours présente des fortes diarrhées aqueuses et verdâtres. Elle se trouve en soin de réhabilitation suite à une ostéosynthèse du fémur. Il y avait eu une complication avec une infection, une antibiothérapie a été débutée il y a 2 semaines et est toujours en cours. Elle mange beaucoup de yaourt probiotiques. Ses voisines de chambre se portent bien. Quel est l'agent pathogène le plus probable?

- A. Clostridium difficile
- B. Norovirus
- C. Lactobacillus
- D. Giardia lamblia
- E. Salmonella typhi

Réponse A

29. Femme de 19, vient vous consulter pour des douleurs et des brûlures vaginales estimée à 9/10 sur une échelle allant de 0 (pas de douleur) à 10 (pire douleur imaginable). (Merci pour cette explication, j'aurais jamais su!). Température 37.7°C. Nouveau partenaire depuis 3 mois avec relations sexuelles non protégées. au status on voit des vésicules ulcérées sur la vulve et leucorrhée blanche aqueuse. Quel est le traitement à donner en attendant les résultats de microbiologie?

- A. Acyclovir
- B. Pénicilline

- C. Metronidazole
- D. Fluconazol
- E. Corticostéroïde topique

Réponse : A

31. Une femme de 27 ans G1P0 à 20 4/7 d'une grossesse gémellaire se présente aux urgences pour des contractions prématurées. Elle se plaint de douleurs dans le bas ventre et d'une dyspnée en augmentation, A l'US, on met en évidence un polyhydramnios pour un des fœtus alors que le second n'a quasiment plus de liquide amniotique. Qu'est ce qui est le plus probable ?

- A. Une malformation cardiaque chez l'un des fœtus
- B. Un syndrome de fuite capillaire systémique
- C. Un syndrome de transfusion foeto-foetale
- D. Une mort intra-utérine d'un des fœtus
- E. Une malformation digestive d'un des fœtus

Réponse: C

Diphthérie 32. Un enfant afghan de 2 ans se présente aux urgences avec sa mère. L'anamnèse est très limitée par la barrière de la langue et vous ne parvenez pas à obtenir le status vaccinal de l'enfant. Il présente de la fièvre ainsi qu'une toux aboyante et un état général diminué. Au status, il est fébrile à 38.5°C. A l'examen de la cavité buccale, vous mettez en évidence des amygdales oedématisées et couvertes d'un dépôt blanc ainsi qu'un érythème des zones amygdaliennes et pré-amygdaliennes. Au frottement léger des amygdales, un saignement est déclenché puis cesse rapidement spontanément. Les résultats de laboratoires sont les suivants:

- Hémoglobine : 88 g/L
- Plaquettes : 155 G/L
- Leucocytes : 22.3 G/L.

Le tableau clinique décrit est le plus compatible avec la diphthérie.

Les éléments clés en faveur de ce diagnostic incluent :

- La présence de fièvre et de toux aboyante.
- L'oedème et le dépôt blanc sur les amygdales, ainsi que l'érythème.
- Le saignement déclenché par un léger frottement des amygdales.
- Les résultats de laboratoire montrant une leucocytose significative.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- A. Une angine de Plaut-Vincent
- B. Une infection à EBV
- C. Un abcès para-amygdalien
- D. La diphthérie
- E. Une angine à streptocoques

La diphthérie, causée par *Corynebacterium diphtheriae*, se manifeste souvent par la formation de pseudomembranes grisâtres sur les amygdales ou le pharynx. Ces pseudomembranes peuvent saigner lors d'une tentative de les retirer, ce qui correspond à l'observation clinique mentionnée.

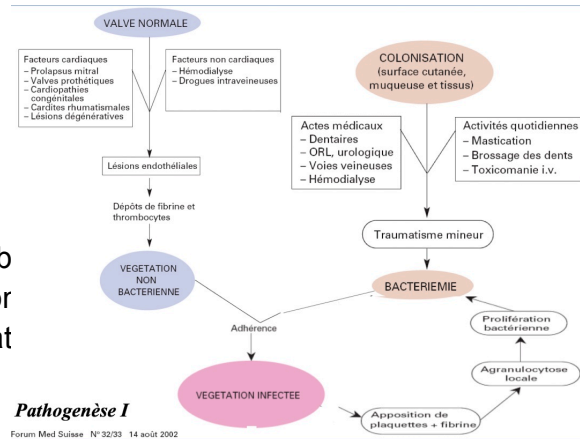
Réponse: D

Teigne Patient de 5 ans qui présente des lésions de prurit au niveau occipital du cuir chevelu (notamment). Le patient présente également des adénopathies (occipitales ?). Qu'est ce qui est juste?

- A) le patient peut continuer à l'école jusqu'au début du traitement
- B) Peut aussi se présenter au niveau des sourcils et des cils
- C) Il faut prescrire un antifongique PO
- D) Peut se surinfecter avec *Pseudomonas* (?)

Caractéristique	Teigne (Tinea capitis)	Pédicose (Poux de tête)
Pathogène	<i>Trichophyton tonsurans</i> , <i>Microsporum canis</i>	<i>Pediculus humanus capitis</i>
Présentation clinique	Plaques squameuses prurigineuses avec alopecie	Prurit intense du cuir chevelu, excoriations, présence de lentes/poux
Lymphadénopathie	Possible (postauriculaire)	Rare
Diagnostic	Examen des cheveux, culture fongique	Détection visuelle des poux et lentes, lampe de Wood
Traitement	Antifongiques oraux (griséofulvine, terbinafine)	Pédiculicides topiques (perméthrine, ivermectine), retrait mécanique
Complications	Kérion (peut causer alopecie permanente)	Surinfections cutanées dues aux grattages
Transmission	Contact avec des surfaces ou objets contaminés, animaux infectés	Contact direct tête-à-tête ou partage d'articles personnels
Zones affectées	Cuir chevelu, parfois sourcils et cils	Cuir chevelu, principalement derrière les oreilles et la nuque
Épidémiologie	Enfants, plus fréquent dans les zones surpeuplées	Enfants en âge scolaire, épidémies fréquentes dans les écoles

Réponses: - + - ? +++- ? (Teigne : HUG ok pour l'école dès le déb
teigne des cheveux c'est antifongique PO, et Pseudomonas... cor
- Mais ce ne serait pas plutôt des poux? (oui ils font des adénopat
msd)

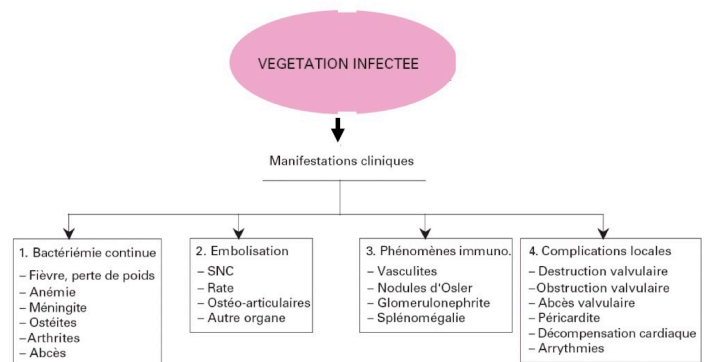


41.) Femme de 73 qui consulte aux urgences pour des douleurs au genou gauche depuis cette nuit. Vous constatez que le genou est rouge et enflé. Elle se plaint également d'une faiblesse, d'une sensation de fièvre ainsi que de frissons occasionnels depuis 1 mois. Elle présente des lésions macules rouges ne disparaissant pas à la vitropression sur les paumes des mains. Elle a également eu 2 épisodes de sang dans les selles en 2 semaines. Labo montrant une anémie microcytaire, un syndrome inflammatoire (leucos 16, CRP 68), et une augmentation de la créatinine (138 environ).

Que faites-vous ?

- A. Coproculture
- B. Biopsie des lésions cutanées
- C. Hémocultures
- D. Coloscopie
- E. Radio du thorax

Réponse: C - plutôt D pour hémorragie dig non?



42.) Homme de 50 ans connu pour un DM2 traité par Metformine. Vient pour un contrôle chez son médecin traitant. Tension 135/85. On lui détecte une microalbuminurie au stix urinaire, ce qui était également le cas au contrôle précédent. Quel traitement est le plus indiqué?

- A. Pas de traitement
- B. Bêtabloquant
- C. Diurétique de l'anse
- D. Inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine
- E. Calcium channel blocker

Réponse: D

Dystonie aiguë
sur métoclopramide

43.) (ancrage) Femme de 19 ans en BSH qui est hospitalisée en Orthopédie suite à une fracture du tibia du à une chute à ski. Le psychiatre est appelé à son chevet car la patiente est très anxieuse. Elle dit ne plus pouvoir bouger les yeux et se sentir nerveuse. La patiente est hypertendue (140/90 mmHg) et tachycarde (112 bpm). On objectifie une fixation du regard. Les infirmiers vous racontent que cela est arrivé après lui avoir filé une petite dose de Metoclopramide, depuis elle ne veut plus les regarder dans les yeux quand on lui parle. Vous lui donnez quoi

- A. Biperiden (Akineton) = Anticholinergique
- B. Domperidon (Motilium)
- C. Haldoperidol (Haldol)
- D. Une petite Benzo

La patiente présente une dystonie aiguë induite par la metoclopramide. La dystonie aiguë est une réaction extrapyramidale caractérisée par des contractions musculaires soutenues, souvent douloureuses, qui peuvent impliquer divers groupes musculaires, y compris ceux des yeux (crise oculogyre), du cou, et des membres. Elle est fréquemment observée après l'administration de médicaments antidopaminergiques tels que la metoclopramide.

Réponse : A (+1) (metoclopramide responsable de symptômes extrapyramidaux -> crise oculogyre : regard fixé vers le haut)

Options de traitement
Anticholinergiques:

- Biperiden (Akineton) ou Benzotropine: Les anticholinergiques sont les traitements de choix pour les réactions dystoniques aiguës. Ils agissent en bloquant les récepteurs de l'acétylcholine, ce qui aide à rétablir l'équilibre entre la dopamine et l'acétylcholine dans le système nerveux central.
- Diphenhydramine: Un antihistaminique qui possède également des propriétés anticholinergiques et peut être utilisé pour traiter les dystonies aiguës.

44) Lors d'un CT abdo pour un patient avec diverticulite sigmoïdienne, vous découvrez une masse au-dessus du rein. Vous n'avez pas d'autres infos. Qu'est-ce que c'est?

- A. Adénome du cortex surrénal
- B. Carcinome du cortex surrénal
- C. Myélolipome
- D. Phéochromocytome non sécrétant
- E. Métastase

Réponse : A

A45) Une jeune femme consulte pour des douleurs abdominales 12 heures après avoir bu une bouteille de vodka et avalé 20 comprimés de 1 g de paracétamol. Le ALAT et la GGT sont augmentées. Que faut-il lui administrer ?

- A) Flumazenil
- B) Atropine
- C) N-acétylcystéine
- D) Physostigmine
- E) Charbon actif

Réponse : C

Kprim) Jeune homme de 17 ans souffrant d'une dépression. Tentamen médicamenteux avec 4g de paracétamol il y a quelques mois. Actuellement, le patient se sent un peu mieux. Quelles seraient les situations à risque d'une nouvelle tentative de suicide ?

- A. L'introduction d'un antidépresseur type ISRN/ISRS.
- B. Le suicide d'un chanteur qui est son idole depuis l'enfance.
- C. Qu'il s'éloigne de son groupe d'amis.
- D. Recommencer à jouer dans sa bande de groupe de rock

Proposition de réponse : +++ - (+4, risque augmenté au début du ttt => le risque est pas augmenté au début des antipsychotiques?) (-++-? +3 dans les études pas de preuve d'augmentation de risque suicidaire au debut du ttt avec ISRN ou ISRSI)

→ *pas de preuve chez les adultes mais modeste augmentation du risque suicidaire (idéations suicidaires) chez les enfants et jeunes*

(<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2022.880496/full>)

A56) Patient de 50 ans qui présente des lésions au niveau des ongles d'une main. Atteinte de trois ongles, avec dépôts blanchâtres et teintes jaunâtres et roses-rouges, ainsi que des petites dépressions punctiformes. (description à l'écrit, pas de photo)

De quoi s'agit-il ?

- A. Psoriasis
- B. Onycholyse
- C. Onychomycose
- D. Cancer epidermoïde
- E. ...



Proposition de rép : A (sinon C.. +1)

← psoriasis selon AMboss

69) (Question d'ancrage) Patiente de 75 ans prenant aspirine cardio et atorvastatine pour un AVC, se voit prescrire une antibiothérapie pour une pneumonie. On observe une élévation de la créatinine kinase au laboratoire. Ceci est attribuable à une interaction avec un antibiotique, lequel ?

- A. Clarithromycine
- B. Azithromicine
- C. Céfuroxime
- D. Pipéraciline-tazobactam
- E. Co-amoxicilline

Réponse : A

70) Patiente avec un carcinome mammaire. Ni la chirurgie ni la radiothérapie ne sont envisageables. Elle présente un lymphoedème important au bras et à la main ipsilatéral. Quel est le premier traitement de choix ?

- a) Cryothérapie
- b) Drainage manuel
- c) Bandage compressifs
- d) Debulking chirurgical

Réponse B

71) Un homme de 77 ans présente une douleur abdominale. Il présente également un anurie depuis la veille. L'ultrason confirme le diagnostic de vessie hypotone sur regorgement. Quel médicament en cause ?

- A) Amoxicilline
- B) Bromazepam
- C) Phénytoïne
- D) Amitriptyline
- E) Hydrochlorothiazide

Réponse D

72) Adolescent de 16 présente un larmoiement de l'œil droit. Il présente depuis une tuméfaction très rouge douloureuse du bord médiale de la paupière inférieure. (Photo d'un gosse avec tuméfaction très rouge du bord médiale de la paupière inférieure.)

Diagnostic ?

- A) Empyème de sinus maxillaire
- B) Abscès du sinus frontal
- C) Dacryocystite
- D) Lymphoedème
- E) C'est la mer noire (+10^^)

Réponse C

Quel examen permet d'exclure la présence d'un corps étranger métallique dans l'œil ?

- A. CT scan
- B. Fond d'œil
- C. Absence d'hémorragie du vitré
- D. Pressions bilatérales symétriques

Réponse A

61)

(Question d'ancrage) Un patient opéré d'une oesophagectomie avec tubulisation gastrique. On le désintube, mais le patient développe une dyspnée aiguë et un stridor inspiratoire.

Quelle est la cause de ces symptômes ?

- A. pneumonie
- B. Pneumothorax
- C. Aspiration pendant la désintubation
- D. Paralysie bilatérale du nerf récurrent
- E. Oedème réactionnel

Réponse D

62)

Quel est le meilleur moyen pour évaluer le burden of disease d'une maladie ?

- A. PYLL (année de vie perdues)
- B. mortalité infantile
- C. mortalité totale de la population
- D. DALY

Réponse D

Question 73

Un patient de 35 ans est amené aux urgences par la police après qu'il a été retrouvé délirant dans la rue. Il présente une agitation, mydriase bilatérale, en sueur, fébrile, tachycarde, HTA. Quelle est la prise en charge?

- A. Naloxone
- B. Fluvoxamine

- C. Physostigmine
- D. Atropine
- E. Lorazepam

Réponse : E? Plutôt C (intoxication antichol... nope il transpirerait pas !) // E si intox cocaïne ? No E plutôt si sevrage alcool mais pas un tableau de sevrage à mon avis // Intoxication aux sympathomimétiques (diaphorèse, serait sec si anticholinergique) e.g. coke/amphétamines → donner benzodiazépines (E +5)

Question 74

Une patiente de 3 ans est amenée à votre cabinet par sa maman pour un second avis concernant sa dermatite atopique diagnostiquée il y a 2 ans. Elle présente une atteinte des joues, des coudes, des poignets et des plis poplités avec bonne réponse aux corticoïdes topiques mais de courte durée. Actuellement elle présente peu de symptômes hormis une sécheresse généralisée de la peau.

Comment peut-on confirmer son diagnostic?

- A. Rhagades sous-auriculaires
- B. Gonflement généralisé des adénopathies
- C. Fissure anale
- D. Kératose palmo-plantaire
- E. Dermographisme urticairecft

Réponse : A (+4), E?->non dermatisme blanc

Patiente à 28 SA qui présente un saignement indolore vaginal. Le status gynécologique et l'US ne retrouvent rien à part du sang dans le vagin postérieur. Vous pouvez raisonnablement écarter un placenta praevia ou un décollement placentaire. Vous décidez d'effectuer une prise de sang qui donne :

- Groupe sanguin : O-
- Rhésus : D-
- Anticorps anti-D : négatif
- Anticorps anti-C : faiblement positif
- Pas d'informations sur le bébé données.

Pour cette patiente de 28 semaines d'aménorrhée (SA) qui présente un saignement vaginal indolore avec un test de Coombs indirect négatif pour les anticorps anti-D mais faiblement positif pour les anticorps anti-C, la meilleure attitude est d'administrer de l'anti-D lors de la consultation (option B).

Selon les recommandations pour les patientes Rhésus négatif :

- **Administration d'anti-D:** La prophylaxie par immunoglobuline anti-D (RhoGAM) est indiquée chez toutes les femmes Rh négatif à 28 semaines de gestation et en cas de saignement pendant la grossesse, indépendamment de la présence d'anticorps anti-D.
- **Prise en charge des anticorps anti-C:** La présence d'anticorps anti-C, bien que faiblement positive, ne modifie pas la nécessité d'administrer de l'anti-D pour prévenir la sensibilisation Rhésus.

Les autres options ne sont pas appropriées pour les raisons suivantes :

A: Ne rien faire : Ignorer le besoin de prophylaxie par anti-D n'est pas recommandé en présence de saignement chez une patiente Rhésus négatif.

C. Refaire une prise de sang dans 2 semaines et adopter une attitude anti-D en fonction du résultat : Attendre 2 semaines avant d'agir peut exposer la patiente à un risque accru de sensibilisation Rh.

D. Administrer de l'anti-D à l'accouchement : Bien que l'administration d'anti-D soit nécessaire après l'accouchement si le bébé est Rh positif, il est également essentiel de l'administrer à 28 semaines de gestation et en cas de saignement pendant la grossesse pour prévenir la sensibilisation.

Quelle est votre attitude ?

- A. Ne rien faire
- B. Administrer de l'anti-D lors de la consultation
- C. Refaire une prise de sang dans 2 semaines et adopter une attitude anti-D en fonction du résultat
- D. Administrer de l'anti D à l'accouchement
- E. ?

Réponse : B

13) La **sensibilité et la spécificité** des tests conventionnels par détection des antigènes urinaires pour le pneumocoque est modeste. Pour cela vous voulez évaluer la sensibilité et la

spécificité d'un nouveau test de détection d'antigène urinaire du pneumo. Quel est le type d'études le plus approprié?

- A. Une étude cas-témoin nichée dans un essai clinique randomisé
- B. Une étude transverse en comparant avec le gold standard
- C. Une étude cas-témoin comparant une population avec pneumonie et sans pneumonie
- D. Une étude cas-témoin avec une population ayant été diagnostiquée avec une pneumonie à pneumocoques et une population avec une pneumonie à autres germes
- E. Un essai clinique randomisé mettant en évidence les différences de mortalité, de traitement et de durée d'hospitalisation dans les deux sous groupes

Réponse: Pas A, pas E, plutôt D...ou **B** (+5)?

14) (ancrage) Une patiente de 82 ans, connue pour une consommation chronique d'alcool, se présente aux urgences en raison d'une légère dyspnée d'une fatigue, un ictère, un angiome stellaire et un érythème palmaire. A l'examen clinique, vous remarquez un abdomen distendu mais souple sans douleurs à la palpation, la rate est palpable 5 cm sous le rebord costal. Au Labo, vous avez:

HB 102g/l
MCV 82
Thrombocytes 105 G/l
ASAT 53
Alat 49
Bili 45
GGT 300
Albumine 29
INR 1.7

Étiologie de la thrombocytopénie

1. Production plaquettaire altérée dans la moelle osseuse

- Conditions de la moelle osseuse → Diminution des mégacaryocytes → Diminution de la thrombopoïèse
- Insuffisance de la moelle osseuse : anémie aplasique, hémoglobinurie paroxystique nocturne
- Suppression de la moelle osseuse : médicaments (p. ex., linezolid, daptomycine, acide valproïque, valacyclovir), chimiothérapie, radiation
- Thrombocytopénies congénitales : syndrome de Wiskott-Aldrich, syndrome d'Alport, syndrome de Bernard-Soulier, anémie de Fanconi, maladie de von Willebrand
- Autres conditions congénitales : maladie de Gaucher
- Infection : CMV, EBV, virus de l'hépatite C, VIH, oreillons et rubéole, parvovirus B19, rickettsia, VZV, dengue
- Malignité : leucémie, lymphome, infiltration de la moelle osseuse, syndrome myélodysplasique
- Carence nutritionnelle : carence en vitamine B12 et/ou en folate (p. ex., dans l'abus chronique d'alcool)

2. Augmentation du renouvellement plaquettaire en périphérie

- Thrombocytopénie immunitaire (ITP) et autres maladies auto-immunes (p. ex., lupus érythémateux disséminé, polyarthrite rhumatoïde)
- Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) et sepsis
- Purpura thrombocytopénique thrombotique (TTP) et syndrome hémolytique et urémique (SHU)
- Thrombocytopénie immunitaire induite par des médicaments (DITP)
- Grossesse : prééclampsie et syndrome HELLP
- Infection

Quelle est l'étiologie la plus vraisemblable de la thrombocytopénie?

- A. **Hypersplénisme**
- B. Carence en folates
- C. Aplasie médullaire
- D. Hémorragie gastro-intestinale
- E. Leucémie myéloïde aiguë

- Thrombocytopénie post-transfusionnelle
- Dommages mécaniques dus à des valves cardiaques artificielles ou à la circulation extracorporelle (p. ex., dialyse)

3. Redistribution, dilution et autres causes

- Maladie hépatique et abus chronique d'alcool (diminution de la production de thrombopoïétine dans le foie)
- Splénomégalie : Séquestration des thrombocytes dans une rate augmentée de volume

Réponse : A

En prenant en compte les antécédents de consommation chronique d'alcool, la présence d'une splénomégalie, et les résultats de laboratoire, l'hypersplénisme (due à la splénomégalie) est l'étiologie la plus probable de la thrombocytopénie.

(Question d'ancrage) Patiente de 22 ans, en BSH, sinon quelques antécédents de troubles de la vision auto-résolutifs qui consulte pour des problèmes de vision. **Paralysie de l'adduction de l'oeil gauche** avec **nystagmus de l'oeil droit lors du regard à droite**. Reste oculomotricité sp. Quel est le nom de cette symptomatologie?

- A. Paralysie du muscle droit latéral à droite

- B. Ophtalmoplégie internucléaire associé à maladie démyélinisante (SEP p.ex)
- C. Paralysie du muscle oblique inférieur
- D. AVC mésencéphalique
- E. Ischémie de la veine centrale de la rétine

Réponse: B

(Question d'ancrage) Patiente de 57 ans ayant bénéficié d'une thyroïdectomie totale dans un contexte oncologique. 4h post-op la patiente présente des Paresthésies au niveau des mains, des doigts et dans la zone péri buccale associées à des crampes au niveau des mains. Légère dyspnée. Quelle est la cause la plus probable?

Thyroïdectomie --> hypopara transitoire post-op --> hypocalcémie

- A. Hypokaliémie
- B. Hyperkaliémie
- C. Hypercalcémie
- D. Hypocalcémie

Réponse: D

Consultation ambulatoire pour un garçon de 9 ans, petite taille et fatigue. 120cm (-2.8 DS), 19.8kg (-3.2DS)

TSH 0.8 (N : 0.5-4.7)

T4 5.0 (N : 10 - 35)

Quel est le diagnostic le plus probable?

- A. Hypopituitarisme
- B. Hypothyroïdie primaire
- C. Déficit congénital en hormone de croissance
- D. Maladie coeliaque
- E. Petite taille d'origine psychosociale

Réponse: A

Patiente de 75 se plaignant de vision trouble sans douleurs à l'œil D, sensibilité à l'éblouissement et à la lumière. DT2 diagnostiquée récemment, pas de rétinopathie diabétique mise en évidence. Opération de la cataracte il y a 10 ans avec implantation de lentilles intraoculaires.

Quel est le diagnostic?

- A. Opacification de la capsule postérieure
- B. Oedème maculaire diabétique
- C. Dégénérescence maculaire sénile
- D. Hémorragies sous-rétiniennes
- E. Hémorragie intra-oculaire

Réponse: A

(Question d'ancrage) Petit enfant de X années qui vient aux urgences pour des maux de ventre intermittents atroces depuis X jours. Il a présenté des vomissements biliaires et non biliaires. Les paramètres vitaux sont dans la norme, lors de l'examen clinique le gosse sourit et vous tape la causette. Abdomen souple. Quand vous faites le TR, il se tord de douleur. Vous retrouvez un peu de sang au TR.

L'US montre :

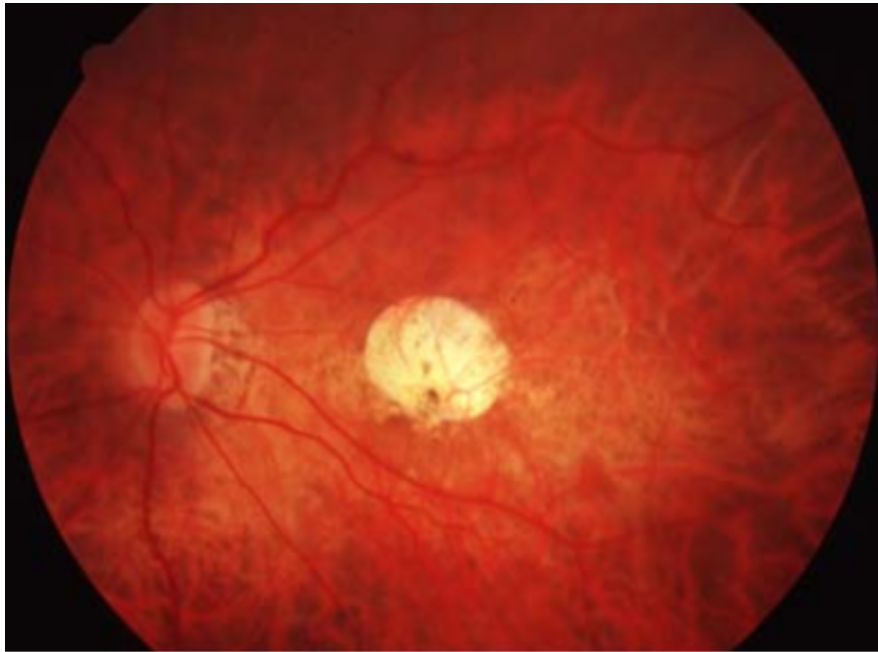


De quoi s'agit-il ?

- A. Diverticule de Meckel
- B. Invagination
- C. Sténose du pylore
- D. Volvulus du grêle
- E. Entérocolite nécrosante

Réponse : B

Patient avec baisse d'acuité visuelle, vous êtes un pro des fond d'oeil, et en voyant ça, vous pensez immédiatement à :



- A. Cécité arciforme
- B. Cécité centrale
- C. Cécité périphérique
- D. Hémianopsie
- E. Quadranopsie

Réponse : B

(Question d'ancrage) **N'est pas** un but de la LAMal :

- A. Solidarité entre patients malades et non-malades
- B. Protection de l'individu contre les conséquences économiques des maladies
- C. Prise en charge globale des coûts des soins pour les personnes âgées
- D. Remboursement des frais maladie liés à la grossesse (sans plus de précision)
- E. ?

Réponse : C Pas B? (assurance perte de gain, AI)

(Question d'ancrage) Patiente qui est femme au foyer, n'a pas d'assurance accident, n'est pas couverte pour les accidents dans son assurance maladie. N'est pas non plus couverte à travers son mari qui lui est assuré. Qui paye en cas d'accident ?

- A. AI
- B. Assurance-accident
- C. LAMal
- D. La patiente
- E. Assurance responsabilité civile RC

Réponse: C (+1), pas D? (+2) Sinon ça servirait à quoi d'avoir une assurance accident (l'assurance accident rembourse à 100%, avec la LAMal il faut payer une quote-part je pense - donc théoriquement, D est également juste...) l'assurance accident est présente si on travail,

si on ne le fait pas on doit payer une option dans la Lamal pour être couvert lors d'accident, madame ne l'a pas donc D (source: ma mère) ←haha j'ai fait la même et j'ai la même info^^

(Question d'ancrage) Patiente à qui un carcinome ovarien a nouvellement été diagnostiqué. Elle est en état général moyen, présente une ascite et une dyspnée. Que faire ?

- A. Ponction d'ascite et cytologie
- B. Ablation de la masse
- C. ?

Réponse : A

GEU (Question d'ancrage) Patiente de x années qui n'a pas eu ses règles depuis 8 semaines, elle ne va pas bien du tout et vous explique qu'elle a des douleurs après le sexe avec son mari. Au status clinique, la patiente a **mal à la palpation** dans le quadrant inférieur droit. A l'ultrason, vous trouvez du **liquide dans le Douglas** et un truc aux annexes. **Suspicion GEU**. Vous regardez les paramètres vitaux et (sauf erreur) ils sont **TA 90/60 et 110 bpm** ou qch du genre. Que faire ?

- A. Laparoscopie
- B. **Laparotomie**
- C. Méthotrexate
- D. Mifégyne
- E. Contrôle demain

↳ = rupture de GEU possible

Réponse : A ou B ? (B +1 car patiente instable et il faut opérer rapidement, (sauf erreur de ma part, la A c'est plutôt pour les cas non urgent, chez patients stables après échec au MTX p.e) Il me semble qu'il n'y avait pas la proposition laparoscopie +1 (seulement laparotomie)=> non il y avait les deux, je me souviens d'avoir hésité => oui, moi aussi AMBOSS: Laparotomy is preferred for large intraperitoneal bleeding or critically unstable patients, otherwise a laparoscopic approach is typically performed (donc je pense laparoscopie ici)

Avant d'intuber un patient, à quoi sert la **pré-oxygénation au masque**?

- A. Augmenter le temps nécessaire à l'intubation
- B. **Augmenter le temps pouvant être passé en apnée**
- C. Diminuer les douleurs post opératoires

Réponse : B

(Question d'ancrage) Qu'est-ce qui fait partie des signes de mort certaine ?

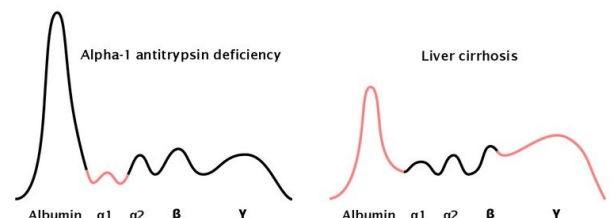
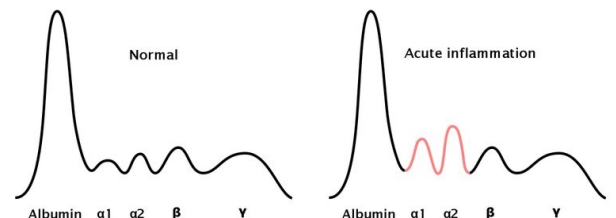
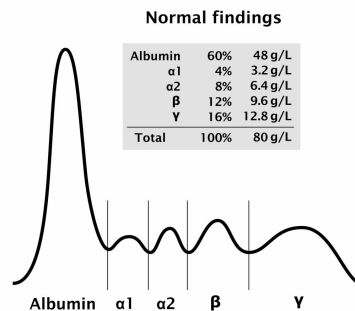
- A. Hypothermie
- B. Pupilles dilatées
- C. **Lividités** cadavériques
- D. Rigidité des quatre membres
- E. Pas de pouls

Réponse : C

(Question d'ancrage) Patient de 23 ans qui vient aux urgences parce qu'il a eu une bagarre en soirée. Il a reçu un coup de poing sur la mandibule qui l'a mis KO (quel loser...). Il se rappelle bien que le coup était proche de la mandibule. Effectivement, à la radio vous voyez une **fracture du condyle de la mandibule** à gauche. A l'examen clinique, vous retrouvez une hyposensibilité de la lèvre inférieure gauche. Quel nerf est vraisemblablement lésé ?

- A. Nerf mandibulaire
- B. Nerf mentonnier
- C. **Nerf alvéolaire inférieur**
- D. Nerf rétromolaire
- E. Nerf maxillaire

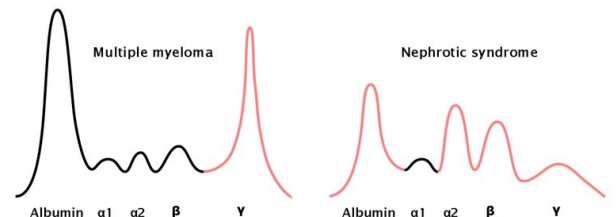
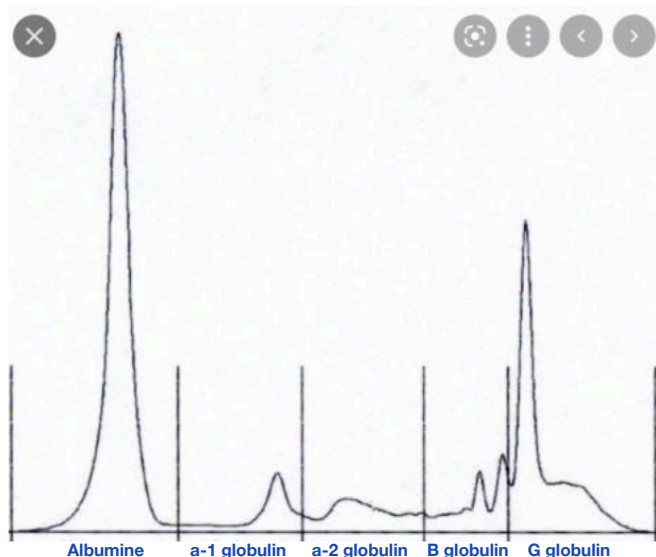
Réponse : C



MM

Patient avec **douleurs du dos depuis quelques semaines**.

L'électrophorèse sérique donne ça :



Électrophorèse: Principales fractions protéiques :

Albumine : Représente le pic le plus élevé.

- Diminués --> maladie hépatique / malnutrition / perte de protéines.

Alpha-1 globulines :

- Augmentées = réactions de phase aiguë / grossesse.
- Diminuées = déficit en alpha-1 antitrypsine.

Alpha-2 globulines :

- Élevées = syndrome néphrotique / infections chroniques.

Bêta globulines :

- Augmentées = anémie ferriprive / infections chroniques.

Gamma globulines :

- Pic étroit (pic monoclonal) = **gammopathies monoclonales** :
 - MM
 - macroglobulinémie de Waldenström
 - MGUS
 - Amylose à chaîne légère
- Augmentation diffuse = **gammopathie polyclonale** :
 - maladie hépatique
 - infections
 - auto-immuns

Quel prochain examen faire pour votre diagnostic ?

- A. Radio de la colonne
- B. Scintigraphie osseuse
- C. Ponction médullaire

Réponse : C

IRA

Q57: Jeune de 27 ans avec diarrhées et vomissements depuis 5 jours, mêmes symptômes chez sa copine. Le MT opte pour une gastro-entérite virale et prescrit un traitement conservateur. Le patient se présente aux urgences avec une tachycardie et persistance des symptômes. Au labo, créatinine, acide urique et taux d'urate élevés, le reste dans la norme. Corps cétoniques ++ dans l'urine.

- **Diarrhées et vomissements prolongés** : Ces symptômes peuvent entraîner une déshydratation sévère, causant une hypoperfusion rénale et un développement d'une **insuffisance rénale aiguë prérenale**.
- **Élévation de la créatinine et de l'acide urique** : Ces résultats sont indicatifs d'une IRA, probablement due à une déshydratation et à un syndrome de lyse cellulaire secondaire à un catabolisme augmenté.
- **Corps cétoniques dans les urines** : Le jeûne ou une consommation réduite d'aliments, combinée à des vomissements et une diarrhée, peuvent provoquer une **cétose**.

Autres diagnostics exclus :

B. Pyélonéphrite : Cette condition s'accompagne généralement de symptômes urinaires et de fièvre, ce qui n'est pas décrit ici.

C. Syndrome hémolytique et urémique (SHU) : Le SHU est généralement associé à une anémie hémolytique microangiopathique, une thrombocytopénie et une insuffisance rénale. Ces éléments ne sont pas mentionnés ici.

D. Néphrolithiase : Les coliques néphrétiques et l'hématurie sont des signes plus typiques d'une néphrolithiase.

Quel est le diagnostic?

- A. Insuffisance rénale aiguë
- B. Pyélonéphrite
- C. SHU
- D. Néphrolithiase

Reponse A

Métrorragies /ménopausé Q58: Dame de 63 ans avec hypertension et en surpoids, qui consulte son médecin pour des saignements vaginaux irréguliers et constipation. En ménopause, sans enfants.

À l'examen clinique, vulve rouge et hémorroïdes. À l'US, endomètre épaissi, ovaires non visibles et absence de liquide libre.

Comment procéder?

Postménopausée, saignements vaginaux irréguliers, endomètre épaissi à l'US:

Épaississement de l'endomètre :

Chez postménopausées > 4 mm = éval. supplémentaire pour **exclure cancer de l'endomètre**.

- A. Examen direct
- B. CT scan
- C. Recherche de sang dans les selles et coloscopie
- D. **Hystéroscopie et curetage**

D. **Hystéroscopie avec curetage** : Cette procédure permet la visualisation directe de la cavité utérine et la réalisation d'une biopsie endométriale pour l'analyse histologique. Elle est indiquée dans le cas d'un épaississement de l'endomètre ou en présence de saignements persistants.
A. Examen direct : Utile pour évaluer les hémorroïdes et la vulve rouge, mais insuffisant pour diagnostiquer la cause des saignements vaginaux postménopausés.
B. CT scan : Pas l'examen de première intention pour explorer les saignements vaginaux irréguliers en l'absence d'indications de malignité extra-utérine.
C. Recherche de sang dans les selles et coloscopie : Indiqué pour la constipation et les hémorroïdes, mais ne répond pas à la question principale concernant les saignements vaginaux et l'endomètre épaissi.

Reponse D

Critère	Réponse	Score
Ouverture des yeux (E)	Spontanée	4
	À la commande verbale	3
	À la douleur	2
	Aucune réponse	1
Réponse verbale (V)	Orientée	5
	Confuse	4
	Mots inappropriés	3
	Sens incompréhensibles	2
	Aucune réponse	1
Meilleure réponse motrice (M)	Suit les instructions	6
	Localise la douleur	5
	Retrait à la douleur (flexion normale à la douleur)	4
	Décorication (flexion anormale à la douleur)	3
	Décubitation (extension à la douleur)	2
	Aucune réponse motrice	1

TCC sévère HTIC

Un travailleur sur un chantier arrive aux urgences après être tombé de l'échafaudage de 6m de hauteur. Il a eu une perte de connaissance brève, puis est revenu à lui. Aux urgences, vous objectiviez un **Glasgow à 5** et un hématome occipital sous-galéal. Le **CT-scan natif** effectué en urgence ne montre pas de signes d'hémorragie. Après le CT, le GCS reste à 5.

Que faites-vous ?

- A. Transfert immédiat aux soins intensifs
- B. EEG
- C. Répéter le CT dans 24 heures
- D. Effectuer une craniotomie en urgence
- E. **Mise en place d'une sonde de mesure de la pression intracrânienne**

TCC sévère avec GCS à 5.
Bien que le CT-scan initial ne montre pas de signes d'hémorragie intracrânienne, le GCS reste bas, ce qui est préoccupant et suggère un risque élevé de décompensation neurologique.
--> surveiller en continu la pression intracrânienne, détecter rapidement toute augmentation de la PIC, et gérer de manière proactive les complications potentiellement fatales.

A. Transfert immédiat aux soins intensifs : Cela pourrait être une option appropriée pour surveiller de près l'état neurologique du patient et gérer tout signe de détérioration.
B. EEG : L'EEG n'est pas la priorité immédiate dans la gestion d'un traumatisme crânien sévère avec une altération de l'état de conscience.
C. Répéter le CT dans 24 heures : Bien que le suivi par imagerie soit important, attendre 24 heures sans autre intervention pourrait être dangereux si la situation se détériore.
D. Effectuer une craniotomie en urgence : Une craniotomie serait indiquée en présence d'une lésion nécessitant une intervention chirurgicale, mais le CT-scan ne montre pas de telles lésions pour l'instant.
E. Mise en place d'une sonde de mesure de la pression intracrânienne : Avec un GCS de 5, il est crucial de surveiller la pression intracrânienne (PIC) car il y a un risque élevé d'œdème cérébral ou d'autres complications intracrâniennes.

Réponse : E (indications pose sonde: severe TC avec GCS<8 + CT anormal OU 1ere condition et CT normal MAIS age>40ans/BP<90mmHg/posture motrice anormale)

Angioedème bradykinine-médié

Une femme de 72 ans connue pour une HTA traitée et un diabète consulte pour un oedème de la lèvre supérieure qui est apparue sur la nuit. Le traitement habituel est de metformine, un IECA et un diurétique. Le soir, elle a mangé une salade, du poulet, des frites et un yaourt au chocolat. Quelle mesure faut-il prendre?

- A. Remplacer le diurétique
- B. Arrêter la metformine
- C. **Remplacer l'IECA par un antagoniste du récepteur à l'angiotensine (ARA)**
- D. Organiser une consultation allergologique pour effectuer des prick test cutanés
- E. Tester les allergies médicamenteuses

L'angioedème bradykinine-médié est un effet secondaire connu des IECAs et peut survenir à tout moment après le début du traitement, même après des années d'utilisation sans problème.

Réponse : C

Q146 (3 Questions qui se suivent) :

Iléus mécanique

- I. Une patiente de 63 ans arrive aux urgences pour des douleurs abdominales diffuses en augmentation depuis 3 jours. Elle est connue pour un **carcinome de l'ovaire**, une **carcinose péritonéale et de l'ascite**. Elle n'a pas eu de selles depuis 5 jours. À son arrivée, elle présente des **nausées et des vomissements**, ce qui l'empêche de manger depuis hier. L'examen clinique montre des **douleurs diffuses à la palpation superficielle** dans tout l'abdomen, des **bruits augmentés en fréquence mais pas en tonalité**, sans défense ni détente. FC 88/min, tension artérielle 110/80, température 37.5. Quel est le diagnostic le plus probable?

A. **Iléus de l'intestin grêle**

B. Fécérome

C. Gastro entérite

D. ...

E. ...

- **Carcinose péritonéale et ascite** : La patiente a un historique de carcinome ovarien avec carcinose péritonéale et ascite, ce qui augmente considérablement le risque d'obstruction intestinale.
- **Absence de selles depuis 5 jours + nausées, vomissements + douleurs abdominales** --> **obstruction intestinale**
- **Bruits intestinaux augmentés en fréquence mais pas en tonalité** = **typiques iléus mécanique**, souvent obstruction intestinale
- La gastro-entérite (option C) est moins probable en raison de l'absence de symptômes infectieux typiques tels que la fièvre élevée, la diarrhée, et le contexte médical prédisposant à une obstruction mécanique.
- Le fécérome (option B) pourrait expliquer l'absence de selles, mais l'ensemble des symptômes et le contexte clinique pointent plutôt vers une obstruction intestinale liée à la carcinose péritonéale.

Réponse : A

- II. Un CT est réalisé et le diagnostic d'iléus du grêle est retenu. Au vu de son carcinome de l'ovaire et des métastases péritonéales, la **décision de ne pas opérer** est prise. Quelle est la meilleure chose à effectuer **pour diminuer les nausées et vomissements**?

A. Perfusion de NaCl 0.9% en 2 heures

B. **Pose de sonde NG** pour décompresser l'intestin, ce qui réduit la pression intraluminaire et diminue les nausées et les vomissements.

C. Ondansetron IV

D. Octréotide

E. Mise à jeun

Réponse : B

- III. Un sonde NG est posée et permet de retirer 2L de liquide gastrique. Les nausées et vomissements s'améliorent. La patiente reçoit également **une injection de morphine 2.5mg IV**. Les douleurs passent à 3/10 sur l'échelle EVA. **1h après, les douleurs remontent à 6/10 EVA**. Quel médicament est à mettre à la patiente pour diminuer ses douleurs au vu de la situation actuelle?

A. Hypnose

B. Paracétamol 1000mg PO 3x/j en fixe + 1x/j 1000mg en réserve

C. Irfen 400mg PO 3x/j en fixe + 3x/j 400mg en réserve

D. **Morphine IV 2.5mg 6x/j + 3x/j 2.5mg en réserve**

E. Fentanyl en patch transdermique 12.5 µg 1x/72H

- Gestion de la douleur**
1. **Escalade des Opioides** :
 - Start avec faibles doses d'opioïde puissant (mieux que grande dose d'opioïde fort) et courte durée d'action (morphine orale, oxycodone, hydromorphone)
 - **Augm. après SS** (4-5 h/2)
 2. **D+ paroxysmique** :
 - Add Réserve à 10-20% de la dose quotidienne totale
 - Rééval. à 24-48h --> ajustement
 3. **Augm. doses** :
 - D+ légère/modérée : augm. dose de 25-50 %
 - D+ modérée/sévère : augm. dose de 50-100 %
 4. **Voie parentérale** :
 - D+ sévères nécessitant une voie parentérale: dose / 2-4 en fonction de l'opioïde.
 - D+ à nouveau contrôlée --> envisager retour per os.
 5. **Libération prolongée** :
 - Formulation lib. prolongée si D+ pas contrôlé avec >4 réserves
 - Transdermique à considérer si préf. du patient
 6. **D+ réfractaire** :
 - D+ cancéreuse réfractaire:
 - +/- infusions continues d'opioïdes
 - +/- blocs nerveux régionaux
 - +/- ttt adjuvants (corticostéroïdes ou kétamine).

- Remarques**
- **Évaluation Continue** : La gestion des opioïdes nécessite une évaluation continue des risques et bénéfices, avec un ajustement régulier des doses en fonction de la réponse du patient et des effets secondaires.
 - **Utilisation Prudente** : Les opioïdes doivent être utilisés avec prudence en raison des risques de dépendance, de tolérance et d'effets secondaires graves comme la dépression respiratoire.

m

Réponse : D

Gestion de la D+

Patientes avec **trouble du comportement alimentaire**, dont anorexie, accès d'hyperphagie et vomissements compensatoires. IMC à 19.5. Complications à court terme?

Principales fractions protéiques

Albumine : Représente le pic le plus élevé. Des niveaux diminués peuvent indiquer une maladie hépatique, une malnutrition ou des conditions

entrainant une perte de protéines

Alpha-1 globulines : Augmentées lors de réactions de phase aiguë et pendant la grossesse ; diminuées en cas de déficit en alpha-1 antitrypsine.

Alpha-2 globulines : Elevées lors des conditions telles que le syndrome néphrotique et les infections chroniques.

Bêta globulines : Peuvent augmenter en cas d'anémie ferriprive et de certaines infections chroniques.

Gamma globulines : Les changements dans cette région sont cruciaux ; un pic étroit (pic monoclonal) suggère des conditions comme le myélome multiple, tandis qu'une augmentation diffuse indique une gammopathie polyclonale, souvent due à des infections ou des troubles auto-immuns.

Pathologies spécifiques :

Gammopathies monoclonales : Un pic étroit dans la région des gamma-globulines pourrait indiquer un myélome multiple, une macroglobulinémie de Waldenström ou une MGUS (gammopathie monoclonale de signification indéterminée).

Gammopathies polyclonales : Une augmentation diffuse peut indiquer une maladie hépatique, des infections ou des troubles auto-immuns.

Réponse : B

A. Anorexie secondaire

B. **Problèmes dentaires**

C. Ostéoporose

D. Infertilité

Mastite 67. Une femme de 35 ans a eu un enfant il y a 7 jours. Elle a maintenant des douleurs au sein gauche et une légère augmentation de la température. L'examen révèle une zone rougeâtre d'environ 4 cm de diamètre dans le quadrant supérieur externe du sein gauche. Que faire ?

- A. Mammographie
- B. Thé à l'orange
- C. Biopsie
- D. Ne donner à boire à l'enfant qu'au sein sain
- E. Tirer le lait toutes les 2 heures puis refroidir le sein

Mastite puerpérale (inflammation du sein associée à l'allaitement)

Réponse : E PEC: Continuer l'allaitement au sein affecté est important pour éviter un abcès mammaire. L'allaitement doit se faire à la demande pour éviter de contribuer à l'inflammation.

Support thérapeutique : repos, hydratation adéquate, compresses chaudes et froides pour soulager la douleur et réduire l'inflammation.

Traitement antibiotique empirique : envisagé si aucune amélioration n'est observée après 12 à 24 heures.

LYELL, TEN 68. Une dame de X année souffrant d'une infection respiratoire reçoit un traitement de co-amoxicilline pour une durée de 14 jours. Après 10 jours de traitement, elle présente un exanthème maculo-papuleux sur le tronc avec un prurit intense localisé particulièrement sur le tronc et quelques vésicules dans le dos. La patiente n'a pas de fièvre. Laquelle de ces présentations est signe de sévérité ?

- A. Température normale
- B. Prurit intense
- C. La localisation particulièrement sur le tronc
- D. La présence de papules
- E. La présence de vésicules

Exanthème maculo-papuleux avec prurit et des vésicules après avoir pris de la co-amoxicilline, la présence de vésicules (Option E) est le signe le plus préoccupant car peuvent indiquer une réaction cutanée sévère (comme le syndrome de Stevens-Johnson ou la nécrolyse épidermique toxique), conditions potentiellement mortelles.

Réponse : E

HSA? 69. Homme de X années, céphalées soudaines intenses, arrive aux urgences, devient somnolent. Il devient somnolent et vous constatez qu'il a une mydriase unilatérale (il me semble que pas cette info), que faites vous en premier ?

- A. PL
- B. CT
- C. Intubation
- D. ...
- E. ...

Réponse : C

70. Femme enceinte d'environ 25 SA, vous suspectez une embolie pulmonaire. Quel prochain examen diagnostique faites-vous ?

- A. IRM
- B. Angio-CT
- C. Échocardiographie
- D. ?
- E. N.B. : La radio de thorax et la scintigraphie ne figuraient pas dans les réponses.

Réponse : B (à savoir que dans les guidelines ESC, il est proposé de faire une radio de thorax avant un angio-CT ou une scintigraphie)

- Question d'ancrage sur TSV chez un enfant
- Question sur convulsion fébrile d'un enfant ayant mangé du poulet bio
- Questions à la suite sur maladie coeliaque, symptôme, anaphylaxie et complication
- Question sur spasme du sanglot
- Question sur CAT devant enfant avec apnée de qlq seconde qui récupère après stimulation
- Question sur sarcoidose et présence d'érythème noueux